



LIVRE DES RÉSUMÉS DES QUATRIÈMES JOURNÉES SCIENTIFIQUES DES SCIENCES DE LA SANTÉ.

THÈME : INNOVATIONS EN SCIENCES DE LA SANTÉ



23 au 27 Septembre 2025



Fss



THEME:

INNOVATIONS EN SCIENCES DE LA SANTE



MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA MICROFINANCE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



BIENVENUE AUX

4^{èmes} journées scientifiques

Des Sciences de la Santé de l'Université
d'ABOMEY-CALAVI

CHAMP DE FOIRE DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2025

LIVRE DES RESUMES

MOT DE BIENVENUE DU DOYEN



Chères autorités, Chers collègues, chers partenaires, chers invités,

C'est avec un immense honneur et un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la quatrième édition des Journées des Sciences de la Santé de notre Faculté. Cette rencontre, qui se déroule du 23 au 27 septembre 2025, illustre parfaitement la vocation de notre institution : conjuguer excellence scientifique et engagement social au service de la population.

Sur le plan scientifique, nous aurons le privilège d'échanger autour de thématiques d'actualité, de partager les résultats de recherches innovantes et de renforcer les liens entre enseignants, chercheurs, étudiants et praticiens. Ces journées représentent un moment capital pour la formation, la réflexion et la construction d'une médecine toujours plus performante et adaptée à nos réalités locales.

Sur le plan social et communautaire, nous avons voulu que la science soit aussi un outil concret de solidarité et de santé publique. Ainsi, des consultations foraines gratuites avec dons de médicaments, moustiquaires et conseils de prévention seront organisées à Cotonou sur le campus du champ de foire, à Bopa et à Kpago-Houédjro. Dans le même esprit, une campagne de dépistage, des formations en secourisme, des séances de don de sang, et des conférences grand public viendront renforcer notre mission citoyenne.

Ces journées, à la fois académiques et sociales, traduisent notre volonté de rapprocher l'Université de la communauté, et de faire de la Faculté des Sciences de la Santé un acteur clé du bien-être de nos populations.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude aux enseignants, aux étudiants, aux autorités sanitaires, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui, par leur engagement, rendent possible la réussite de cette noble initiative. Reconnaissance spéciale aux responsables des collectivités locales qui organisent avec enthousiasme l'accueil des délégations de la FSS dans leur localité respective.

Au nom de toute la Faculté, je souhaite plein succès à cette édition et à chacun d'entre vous une participation enrichissante.

Vive les Journées des Sciences de la Santé !

Vive la coopération scientifique et la responsabilité sociale au service du bien être de chaque citoyen

SOMMAIRE

Organisation de la journée	6
Programme scientifique	15
Résumés des conférences	24
Résumés des communications	29
Résumés des conférences grand public.....	102
Résumés des conférences des tables rondes.....	109

Organisation dela Journée



Equipe décanale

Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou (BENIN)

Doyen : Pr AVAKOUDJO Josué Dejinnin Georges

Vice doyen médecine : Pr VODOUHE Ulrich Bidossèssi

Vice doyen pharmacie : MCA GANFON Medessou Yoweil Habib

Vice doyen des écoles : Pr AZON KOUANOU Angèle



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ

LE DÉCANAT

N° 0017/2025/UAC/FSS/IV-D/SGE/SA

Cotonou, le 11 FEV 2025



NOTE DE SERVICE

(Portant désignation des membres du comité d'organisation des quatrièmes Journées scientifiques des Sciences de la Santé (J4S3))

- 1- Dans le cadre de l'organisation des quatrièmes Journées scientifiques des Sciences de la Santé de Cotonou, prévues du 26 septembre au 3 octobre 2025, un comité est mis en place. Il est composé ainsi qu'il suit :
 - **Équipe de supervision**
 - Pr Josué Déjinnin G. AVAKOUDJO
 - Pr Angèle AZON KOUANOU
 - Pr Ulrich B. VODOUHE
 - MCA Habib GANFON
 - **Comité d'organisation**
 - Présidente : Pr Christiane TSHABU AGUEMON
 - Vice – Président : MCA IMOROU SOUAÏBOU Yacoubou
 - Secrétaire : Mme Germaine Abadjayé T. ESSEGNON
 - **Comité chargé du pré congrès**
 - Pr Eugène ZOUMENOU
 - Pr Xavier ZOMALHETO
 - Pr Anthelme AGBODANDE
 - MCA Mathieu OGOUDJOBI
 - MCA Simon AZONBAKIN
 - MCA Joseph AKODJENOU
 - MCA Carmelle MIZEHOUN ADISSODA
 - **Comité scientifique**
 - Président : Pr Xavier ZOMALHETO
 - Membres : Pr Lisette ODOULAMI
 - Pr Bonaventure AWEDE
 - Pr Gildas AGODOKPESSI
 - Pr Aurel Constant ALLABI
 - Pr Patricia YEKPE AHOUANSON
 - Pr Etienne ALAGNIDE
 - Pr Antoine Vikkey HINSON
 - Pr Francis Honorat LALYA

- Pr Jacques VIGAN
- Pr Annelie Célestine KEREKOU
- MCA Thierry ALIHONOU
- MCA Colette AZANDJEME
- MCA Florence ALIHONOU
- MCA Gilles BOGNON
- MCA Fred HODONOU
- MCA Elvyre KLIKPO
- MCA Raimi KPOSSOU
- MCA Magloire YEVI
- MCA Ernest AHOUNOU
- MCA François AMOSSOU
- MCA Guy AZA GANDJI
- MCA Alexis do SANTOS ZOUNON
- MCA Jules GNINKOUN
- MCA Jean SOSSA
- MC Agnès BADOU

➤ **Comité chargé de la trésorerie et de la mobilisation des ressources**

Président : Pr Anthelme AGBODANDE

Membres : Pr Angeline Josiane TONATO BAGNAN

- Pr Gaspard Dansou GBESSI
- Pr Léopold CODJO
- MCA Sonia LAWSON AFOUDA
- MCA Yolande SISSINTO SAVI de TOVE
- MCA Chakirath ABOUKI
- MCA Bérénice DEGBOE
- MCA Caroline PADONOU
- MCA Lutécia ZOHOUN
- MCA Gabin ASSANHOUN
- MCA Patrice DANGBEMEY
- MCA Oswald GOUKODADJA
- MCA Alban ZOHOUN
- Mme Rose GUEDOU BEHANZIN
- Monsieur Fiacre DETONDJI

➤ **Comité chargé de la restauration**

Président : MCA Carmelle MIZEHOUN ADISSODA

- Membres : MCA Mênouli ADJOBIMEY
- MCA Tatiana BAGLO
- Dr Annatou YAKOUBOU
- Dr Eugénie DANSOU
- Mme Sènam AKOHA
- Mme Edwige GOGAN
- Mme Diane AYELESSO
- Mme Océane DANMADOU
- Monsieur Parfait DOFFON
- Mme Lydie Kafayath ZINSOU

➤ **Comité chargé de l'hébergement et l'accueil**

Président : MCA Joseph AKODJENOU

Membres : MCA Moufalilou ABOUBACAR

- MCA Cédric BIGOT

A

- MCA Adébola PADONOU
- MCA Prudence Ablo WACHINO
- Dr Chakirou LADJOUAN
- Mme Armelle HOHODJI
- Monsieur Morel DETONDJI
- Monsieur Georges SODABI
- Monsieur Fernand KANTCHEME
- Monsieur Roxane HOUNGBO
- Mme Persévérancias KPOYE
- Mme Yousra WABI

➤ **Comité chargé du secrétariat**

Président : MCA Mathieu OGOUDJOBI

Membres : MCA Fabrice AKPADJAN

- MCA Gilles ATTOLOU
- MCA Pascal CHIGBLO
- MCA Falilatou SEIDOU
- MCA Arnaud SONOU
- MCA Engelbert AGBOKPONTO
- Dr Richard Ghislain Constantin HOUZE
- Dr David Gilles HOUNDETOUNGAN
- Dr Honesty TOHON
- Dr Austher O. AYI MEGNANGLO
- Dr Ingrid OLOWO
- Dr Akim KOGUI DOURO
- IDH Barnard ACAKPO
- Mme Sabine TOUDONOU
- Mme Charmine GANKPA
- Mme Nicarette DAH ZOUNDI - FIOSSI
- Monsieur François DEGBEGNI
- Monsieur Modeste DOSSOU
- Monsieur Alexandre AKPOVO
- Monsieur Justin FATCHEHOUN
- Monsieur Sylvestre ADOUGOUNDE
- Monsieur Marc AGUEWE
- Mme Eudoxie KOKLANNOU

➤ **Comité chargé de la logistique**

Président : MCA Simon AZONBAKIN

Membres : Dr Alexandre FATON

- Dr Togbedji Richard DAHOUE
- Dr Julien DJOSSOU
- Dr Fresnelle TODOME
- IDH Emmanuel GBESSI
- IDH Gilchrist LENOUMI
- IDH Joëlle ADJIBI
- Monsieur MONGBO Engelos
- Monsieur AGBOKOU Mesmin
- Monsieur Adamou ACAKPO
- Monsieur Audrey DAGBETO
- Mme Egyptie AIDEGO
- Mme Tabitha AHOUANSOU
- Monsieur Wilfried KOUÉLO

- Monsieur Mohamed MOUSSA

➤ **Comité chargé de la santé**

Président : Pr Eugène ZOUMENOU

Membres : Pr Paul AYELO

- Pr Armand WANVOEGBE
- MCA Joseph AKODJENOU
- MCA Arnaud SONOU
- MCA Ernest AHOUNOU
- Dr Serge MEWANOU
- Dr Yévèdo TOHODJEDE
- Dr Nicole ENIANLOKO TCHIAKPE

2- Les Vice – Doyens, la Secrétaire générale d'Entité, les Chefs de Départements, d'Unités, Comptabilité, Matériel et Maintenance, sont chargés chacun, en ce qui concerne, de l'application de la présente note de service qui prend effet pour compter de sa date de signature.



Le Doyen,

Professeur Josué Déjinnin G. AVAKOUDJO

MERCI A NOS PARTENAIRES



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA MICROFINANCE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



**AMBASSADE
DE FRANCE
AU BÉNIN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

AGENCE BÉNINOISE
DE GESTION INTÉGRÉE
DES ESPACES FRONTALIERS



Enabel



PNLB BENIN

LIVEK
JUS DE FRUIT BIO

MultiColor
Flash Print Services
"The Benin Color"™
COMMERCIAL PRINTING
PHOTOCOPYING

**Global Solidarity
for human Dignity**

**MERCI A TOUS LES ENSEIGNANTS DE LA FSS
AYANT SOUTENU LES ACTIVITES**



MERCI AUX ASSOCIATIONS DES ETUDIANTS DE DE LA FSS



Programme scientifique

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

Session 1

	SIMULATION EN SANTE1-INTELLIGENCE ARTIFICIELLE- ASSURANCE QUALITE EN MEDECINE -ALIMENTS THERAPEUTIQUES
8h30-9h30	COMMUNICATIONS ORALES Co01-Co08 (5 mn par communication) (GRAND AMPHI) Modérateurs : Pr WANVOEGBE Armand, MCA WACHINOU Ablo, Dr HOUNKPONOU Murielle COMMUNICATIONS ORALES Co09-Co17 (5mn/communication) (AMPHI ISBA) Modérateurs : MCA ALIHONOU Thierry, MCA PADONOU Abiodun, Ass GBAGUIDI Abdias
9H30-11H	CONFÉRENCE 2 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) en pratique médicale (GRAND AMPHI MEDECINE) Modérateurs : Pr ATADOKPEDE Félix, Pr YEKPE A Patricia, Dr VIGNON Rodolph CONFÉRENCE 2a IA en situation clinique au Bénin MCA WACHINOU, CONFÉRENCE 2b IA et la neurochirurgie au Bénin : pour quelles attentes? MCA Alihonou CONFÉRENCE 2c Chirurgie métabolique au Bénin (MCA IMOROU) CONFÉRENCE 2d IA en imagerie médicale MCA ADJADOHOUN CONFÉRENCE 2e IA en biologie MCA SISSINTO, CONFÉRENCE 2f : IA et Génétique (MCA AZONBAKIN) CONFÉRENCE 2g Apport de l'IA dans la gestion du traitement des patients MCA LAWANI
	DEBATS (10 mn)
11H-11H30	Pause café
11h30-12H	CONFERENCE 3 : régulation de l'IA dans la pratique médicale au Bénin : rôle de l'ARS (25mn) Dr McCRAKEN AGUEH (point focal santé numérique à l'ARS) (GRAND AMPHI MEDECINE) Modérateurs : Pr ATADOKPEDE Félix, MCA IMOROU Souaïbou , Dr VIGNON Rodolph
12H05-12H35	CONFERENCE 4 : IA GENERATIVE : UTILITÉ POUR LA FORMATION EN SCIENCES DE LA SANTÉ ; Pr Eugène EZIN (GRAND AMPHI MEDECINE) Modérateurs : Pr ZANNOU DJIMON MARCEL , MCA ZOHOUN Lutécia, MCA SEIDOU Falilatou

Session 2

	EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES AFFECTIONS MEDICO-CHIRURGICALES
12H40-13H30	COMMUNICATIONS ORALES Co18-Co25(5mn/communication) (AMPHI ISBA) Modérateurs : Pr KEREKOU Annelie, MCA AZA GNANDJI Gérard, Dr TOTDJEDE Y COMMUNICATIONS ORALES Co26-Co33 (5 mn par communication) (GRAND AMPHI) Modérateurs : Pr ZOUMENOU Eugène , MCA ANAGONOU Lucrèce, Dr TCHIAKPE ENIANLOKO Nicole
13h30-14h30	Déjeuner –pause
	SESSION 2 :
14h35-15H35	Modérateurs : Pr SEHONOU Jean, MCA SONOU Arnaud, Dr AYHI MEGNANGLO Austher Table ronde 1 : Rôle des organisations de santé dans le contrôle de l'IA au Bénin - rôle des sociétés savantes (Pr ZANNOU Marcel)

	- rôle de l'ONMB (Dr HOUANSOU, représentante ONMB) - rôle du l'ONPB (Dr DJOUERATH représentante ONPB)
	<u>CEREMONIE D'OUVERTURE</u> (GRAND AMPHI MEDECINE)
16H-17H	Allocution du doyen FSS (5 min) Allocution du recteur (5 min) Allocution du MASM (5 min) Allocution du MESRS (5 min) Allocution du MS (5 min)
17H15-18H	CONFERENCE INAUGURALE : INNOVATIONS DANS LA FORMATION EN SCIENCES DE LA SANTÉ: BILAN ET PERSPECTIVES ; (GRAND AMPHI MEDECINE) Pr Raphael DARBOUX Modérateurs : Pr ZANNOU DJIMON MARCEL, MCA AZONBAKIN Simon , Dr OLOWO Bénédicte
	PAUSE-CAFE
Vendredi 26 SEPTEMBRE 2025	
	Session 3
	SIMULATION EN SANTE – MEDICAMENTS- EPIDEMIOLOGIE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES AFFECTIONS MEDICO-CHIRURGICALES (suite)
8h30-9h45	CONFERENCE 5 : La réglementation et éthique en simulation en santé au Bénin et ailleurs (MCA BIGOT Cédric) (GRAND AMPHI MEDECINE) CONFERENCE 6 : Utilisation de la simulation en santé dans la pratique médicale au Bénin: bilan, défis et perspectives (MCA LAWANI Ismael) (GRAND AMPHI MEDECINE) DEBATS Modérateurs : Pr DOSSOU Francis, MCA OGOUDJOBI Mathieu, MCA ANAGONOU Lucrèce
9H50-11H	COMMUNICATIONS ORALES Co34-Co42(5mn/communication) (AMPHI ISBA) Modérateurs : MCA LAWSON AFOUDA Sonia, MCA AKPADJAN Fabrice , Dr HOUZE Richard COMMUNICATIONS ORALES Co43-Co51(5 mn par communication) (GRAND AMPHI) Modérateurs : MCA AVAKOUDJO François, MCA ABOUBACAR Moufalilou, Dr DANSOU Eugénie
11H- 11h30	Pause-café, visite des posters, visite exposition pharmaceutique
11h35-12h40	Table ronde 2: Mise en place de la Simulation en santé dans la formation en santé à Cotonou Quels sont les atouts et freins? (Pr VODOUHE , VD médecine) -Expériences de l'INMeS (Dr SOUSSIA) - faculté de pharmacie (VD pharmacie) - Représentant des écoles Modérateurs : Pr DOSSOU Francis, MCA AKPADJAN Fabrice, Dr LALEYE Christel
	SESSION 4
	MEDICAMENTS TRADITIONNELS AMELIORES- ALIMENTATION- AUTRES
12h45-13h30	TABLE RONDE 3 : Place des médicaments traditionnels améliorés et autres produits de santé dans l'arsenal thérapeutique au Bénin (AMPHI ISBA) Rôle de l'ordre des pharmaciens dans la promotion de la santé (ONPB) Enjeux et défis des MTA dans le système de santé du Bénin VD pharmacie) La pharmacie hospitalière et médicaments traditionnels améliorés: où en sommes-nous? (AB MED)
13h30-14h30	Déjeuner- pause
15H15-16H30	CONFERENCE 7 : Place des médicaments traditionnels améliorés dans la recherche pharmaceutique au Bénin (GRAND AMPHI MEDECINE)

	Pr ALLABI Aurel Modérateurs : Pr Aurore OGOUYEMI, Pr GBESSI Gaspard, Dr Philippe ADJAGBA
16h35-18H	CONFÉRENCE8 : Alimentation (GRAND AMPHI MEDECINE) Modérateurs :Pr Bonaventure AWEDE, Pr Jean SOSSA, MCA gninkoun Jules CONFÉRENCE8a: Place des compléments alimentaires dans la prise en charge des maladies non transmissibles MCA AZANDJEME C. CONFÉRENCE 8b Dénutrition hospitalière et état des lieux MCA MIZEHOUN CONFÉRENCE 8c Nutrition Artificielle : avantages et éléments de surveillance, Dr FAYEMENDY Philippe (France)
Samedi 27 SEPTEMBRE 2025	
	MEDICAMENTS TRADITIONNELS AMELIORES- ALIMENTATION- AUTRES (suite)
08H30-08H50	SYMPOSIUM LABORATOIRE
9H-9h50	Table ronde 4: hémophilie au Bénin : un combat pour l'équité, la dignité et le droit à la santé_ Etat des lieux de l'hémophilie au Bénin MCA BAGLO Diagnostic biologique de l'hémophilie au Bénin : défis et perspectives : MCA ZOHOUN Vivre avec l'hémophilie : Mme VIGNON Chimène DEBATS Modérateurs : MCA SISSINTO SAVI DE TOVE Y,MCA ANAGONOU Lucrèce , Dr OREKAN
10H-10H45	Modérateurs :Pr DENAKPO Justin, MCA DEGBOE Bérénice, Dr VOHOUHE Tchimon CONFERENCE9: Santé reproductive à l'ère du changement climatique: Cas des fortes chaleurs et de la mortalité périnatale en Afrique subsaharienne ;Dr DOSSOU Jean-Paul , CERRUD
10h50-11h20	Pause-café, visite des posters, visite des stands
11H30-12H	Table ronde 5 : les étudiants en sciences de la santé face aux innovations en santé (Associations estudiantines FSS, délégué enseignants, les VDs) Rôle des étudiants dans les innovations en santé (Associations estudiantines) Pdt AEMC Rôle des enseignants dans les innovations en santé au Bénin (VD médecine) Pr GBESSI Rôle du décanat face aux besoins des étudiants en matière d'innovation (VD Médecine)—— Modérateurs : Pr SEHONOU Jean,MCA ZOHOUN Lutécia , AGUEWE Marc
12H-13H	COMMUNICATIONS ORALES Co52-Co62(5mn/communication) (GRAND AMPHI MEDECINE) Modérateurs : MCA Elvire KLIKPO, MCA AKPADJAN Fabrice Dr Murielle HOUNKPONOU
13H00	CEREMONIE DE CLOTURE- DEJEUNER DE CLOTURE

Résumés des Conferences



Conférence
inaugurale

INNOVATIONS DANS LA FORMATION EN SCIENCES DE LA SANTÉ: BILAN ET PERSPECTIVES

Dr Raphael DARBOUX

Histo-embryologie

Professeur émérite

Chevalier OIPA/CAMES)

RESUME

Selon Alan Altshuler et Robert D. Behn, l'innovation comprend l'invention originale et l'utilisation créative. Ces auteurs définissent l'innovation comme la génération, l'adoption et la réalisation de nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouveaux services et de nouveaux procédés.

La formation en sciences de la santé s'étend au Bénin sur 2, 3, 6, 7 ans pour la formation de base pour des techniciens, des infirmiers et sages femmes, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes, des pharmaciens, des dentistes, des médecins etc... Suivront les spécialisations pour encore 4 ans ou plus. Durant ces longues périodes de formation s'alternent ou se combinent des cours théoriques et pratiques de même que des stages en situation réelle. Durant toutes ces périodes il s'introduit quelque chose d'originale ou de nouveau pour remplacer ou améliorer ce qui existait auparavant. C'est déjà de l'innovation.

De même les activités d'enseignement, d'apprentissage, d'évaluation des compétences s'appuyant sur des principes pédagogiques suivant le contexte et les ressources disponibles réclament des innovations pour produire des personnels de santé qui se comportent de façon professionnelle et éthique pour impacter favorablement le système national de santé.

Les fruits tiennent-ils la promesse des fleurs ? Avons-nous une transformation positive ?

Au vu du développement technologique ambiant, il est alors souhaité la formation d'un personnel de santé toujours capable de se remettre en question pour utiliser à bon escient les nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'intelligence artificielle pour l'intégration des progrès scientifiques et technologiques dans les pratiques et dans les tâches attendues de leur part par leurs collègues, les patients, les employeurs, la société.

Mots clés : Innovation, Formation en sciences de la santé

RÉSUMÉ

L'intelligence artificielle (IA) est en train de transformer la pratique médicale à l'échelle mondiale, et le Bénin n'est pas en reste. Au-delà des promesses technologiques, l'IA trouve désormais des applications concrètes en situation clinique, tant en consultation qu'en hospitalisation, avec un potentiel considérable pour améliorer la qualité et l'efficacité des soins dans notre contexte.

L'IA générative, en particulier, se distingue par sa capacité à traiter de grandes quantités de données médicales, à assister le clinicien dans la rédaction de comptes rendus, à générer des protocoles adaptés aux patients, ou encore à fournir un support décisionnel en temps réel. Par exemple, des outils d'aide à la décision permettent déjà d'interpréter plus rapidement des radiographies pulmonaires pour la tuberculose ou la pneumonie, d'optimiser la lecture de polygraphies ventilatoires en médecine du sommeil, ou de faciliter le triage des patients en urgence grâce à des algorithmes prédictifs.

Dans le domaine de la consultation, l'IA peut automatiser la prise de notes médicales, structurer l'anamnèse, et proposer des pistes diagnostiques à partir de bases de données internationales enrichies.

En hospitalisation, elle peut contribuer à la surveillance continue des patients, détecter précocement les signes de décompensation, et personnaliser les schémas thérapeutiques.

Certaines initiatives exploratoires en Afrique illustrent cette dynamique et seront présentées lors de cette communication : programme Satmed dans plusieurs pays y compris le Bénin pour la télémédecine ; utilisation de chatbots pour des téléconsultations, apprentissage fédéré appliqué à l'imagerie thoracique.

Au Bénin, l'intégration progressive de ces technologies est possible, à condition de tenir compte des réalités locales : infrastructures numériques, formation des professionnels de santé, protection des données et adaptation culturelle. Cette conférence mettra en lumière des exemples concrets d'applications existantes et discutera des perspectives pragmatiques pour une adoption raisonnée et bénéfique de l'IA générative dans nos pratiques cliniques.

Mots clés : Intelligence artificielle, Pratique clinique, Bénin, Télémédecine, Santé numérique

Conf 2b

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET NEUROCHIRURGIE AU BÉNIN : POUR QUELLES ATTENTES ?

Alihonou Thierry

Université d'Abomey-Calavi / Faculté des Sciences de la Santé

RÉSUMÉ

L'Intelligence Artificielle (IA) connaît aujourd'hui une croissance fulgurante, car elle stimule et améliore la productivité et l'innovation dans de nombreux secteurs, de l'économie aux sciences, en passant par la santé. Elle permet l'automatisation de tâches, la personnalisation des services, l'analyse de données massives et l'amélioration de la prise de décision en temps réel. Cependant, son développement rapide soulève aussi des risques significatifs liés à l'éthique, la désinformation et les inégalités, qui nécessitent une gouvernance attentive pour en assurer les bénéfices au service de l'humanité.

Le Bénin compte un nombre limité de neurochirurgiens (9 en 2018 et 18 en 2025) inégalement répartis entre le nord et le sud du pays. Les infrastructures de soutien (réanimation) et les équipements sont insuffisants ou parfois manquants. Les coûts restent élevés pour certaines investigations (scanner, IRM), ce qui rend l'accès plus difficile pour beaucoup de patients. Le manque de technologie de pointe engendre une incapacité à traiter les cas complexes et une augmentation des délais de prise en charge.

Ces contraintes offrent le terrain sur lequel l'IA pourrait jouer un rôle important, mais aussi montrent les défis spécifiques pour adapter les technologies dans ce contexte. Ainsi, les attentes de l'IA en neurochirurgie au Bénin pourraient porter sur l'amélioration du diagnostic et de la planification préopératoire, la prédiction des risques et le pronostic ; de même que l'assistance intra-opératoire, le suivi postopératoire ainsi que l'optimisation des ressources pour la formation.

Mots clés : IA, neurochirurgie, ressources, modélisation, Bénin.

**Conf
2C**

CHIRURGIE METABOLIQUE AU BENIN

MCA IMOROU SOUHAIBOU

RESUME

NON DISPONIBLE



RÉSUMÉ

L'intelligence artificielle (IA) en plein essor, fait actuellement partie des avancées technologiques majeures en médecine. L'imagerie médicale est sans doute l'un des domaines où son impact est le plus tangible. L'IA se développe de plus en plus dans le domaine de l'imagerie médicale pour diverses applications et prend une place significative dans la routine de travail des radiologues. Ces logiciels, pouvant représenter de réels outils diagnostiques pour les radiologues, sont très divers et présentent des limites éthiques et techniques.

Cette conférence se veut être un creusé d'échanges pour apporter quelques éléments de réponses aux questions suivantes : quelle est la place actuelle de l'IA dans les examens d'imagerie ? Quels sont les avantages concrets pour les radiologues, les patients et dans la formation ?

Les innovations de l'IA vont révolutionner l'imagerie médicale au Bénin en vue d'améliorer la qualité des soins. Le développement des solutions d'IA en imagerie médicale, adaptées aux particularités béninoises devient essentiel et devraient être encouragées.

Mots clés : intelligence artificielle, imagerie médicale, éthique, Bénin



INNOVATION DANS LA LUTTE CONTRE LES FUNGI : SENSIBILISATION SUR LA PREVENTION DES INFECTIONS SUPERFICIELLES FONGIQUES

Yolande Sissinto Savi de Tové

Unité de parasitologie-Mycologie / Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou/
Université d'Abomey Calavi/ Cotonou/ Bénin

RESUME

Selon l'OMS, les agents pathogènes fongiques constituent une menace majeure pour la santé publique. La semaine du 15 au 19 septembre 2025 est décernée à la sensibilisation de lutte contre les infections fongiques. Les études réalisées au Bénin et en Afrique révèlent que parmi les maladies fongiques, les infections superficielles sont plus fréquentes. Elles sont souvent bénignes mais représentent une porte d'entrée pour des infections plus graves. En attendant le déploiement d'un plateau technique de pointe, la sensibilisation de proximité reste une possibilité pour réduire la stigmatisation et les handicaps liés à ces infections fongiques.

L'objectif est de sensibiliser nos voisins proches, le public, les professionnels de santé, de l'esthétique de la peau, des phanères par des techniques de proximité et les réseaux sociaux sur la préservation de la barrière cutanéomuqueuse afin de prévenir les infections superficielles fongiques.

Une sensibilisation régulière de proximité (réseaux sociaux, causeries éducatives, consultations foraines, discussions interactives, mobilisation des leaders communautaires) sur les infections fongiques est nécessaire en partageant les connaissances sur ces maladies avec les professionnels de la santé, des soins de la peau et toute la population béninoise et mondiale.

En effet la peau et les muqueuses constituent une première ligne de défense de l'organisme contre les agents pathogènes. Son rôle essentiel est la barrière mécanique, immunologique et chimique contre ces agents. L'altération de cette barrière favorise les infections superficielles fongiques bactériennes et virales. Une revue de la littérature a mis en évidence les facteurs favorisant locaux des mycoses superficielles par des pratiques qui agressent la barrière cutanéomuqueuse. Elles sont multiples et diversifiées par l'utilisation de produits de toilettes irritants, de traumatismes répétés, de mauvaises hygiènes, de conditions favorables prolongées à l'humidité, de rapports sexuels non protégés fragilisant les muqueuses. Les conséquences directes de ces pratiques est l'apparition de microfissures et lésions cutanées, une perte de l'effet protecteur naturel cutanéophanérien et l'exposition à la pénétration des agents pathogènes fongiques, bactériennes et virales. Une meilleure connaissance et compréhension des bonnes pratiques de prévention et l'adoption d'une hygiène régulière, douce et adaptée pourrait maintenir l'intégrité de la peau, des phanères et des muqueuses.

L'application des pratiques simples d'hygiène est essentielle pour réduire la fréquence des infections fongiques superficielles. La sensibilisation de la population sur la préservation de la barrière cutanéomuqueuse est un enjeu majeur de santé publique.

Mots-clés: Mycoses superficielles, sensibilisation, Bénin

**Conf
2f**

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LA GENETIQUE MOLECULAIRE HUMAINE

Dr AZONBAKIN Azandégbé Simon ,

Médecin Biologiste ,

Maître de Conférences Agrégé en Histologie-Embryologie-Cytogénétique ,

Unité de Biologie Humaine- FSS-UAC

Laboratoire de Biologie médicale, CHU MEL

Tel : 0022997130061 , e-mail : azandeg@yahoo.fr

RESUME

La génétique moléculaire et l'intelligence artificielle (IA) sont deux domaines fascinants, et bien qu'ils semblent distincts, ils se croisent de manière intéressante, notamment dans les domaines de la biotechnologie, de la médecine, et de la recherche scientifique. Les énormes données issues du séquençage du génome sont facilement analysées grâce à l'IA. Ceci permet d'identifier les mutations génétiques, de prédire les risques de maladie et surtout de personnaliser les traitements. Aussi, les modèles de l'IA sont de plus en plus utilisés pour l'amélioration de l'efficacité clinique des traitements, la recherche et le développement des médicaments et dans la médecine préventive. La génétique combinée à l'IA transforme radicalement la manière dont les soins sont fournis, en les rendant plus adaptés, préventifs et efficaces. Toutefois, ceci pose d'autres problématiques en matière de sécurité des données, d'éthique et parfois de déontologie. Nous nous proposons de faire un point sur l'utilisation de l'IA en génétique moléculaire humaine.

Mots clés : IA , Génétique, génome, médecine personnalisée



**Conf
2g**

APPORT DE L'IA DANS LA GESTION DU TRAITEMENT DES PATIENTS
MCA LAWANI Ismail

RESUME

Non disponible



Conf 3

**REGULATION DE L'IA DANS LA PRATIQUE
MEDICALE AU BENIN : RÔLE DE L'AUTORITE
DE REGULATION DE LA SANTE**

Dr McCRAKEN AGUEH

RESUME

NON DISPONIBLE

Conf
4

IA GENERATIVE : UTILITÉ POUR LA FORMATION EN SCIENCES DE LA SANTÉ ;
Pr Eugène EZIN

RESUME

NON DISPONIBLE

RESUME

La simulation en santé est aujourd'hui reconnue comme un levier pédagogique essentiel, contribuant à l'amélioration des compétences cliniques des professionnels ainsi qu'à la qualité et à la sécurité des soins. Elle s'impose comme un outil incontournable de formation initiale et continue. Cependant, son développement soulève des interrogations d'ordre réglementaire et éthique. Alors que plusieurs pays occidentaux disposent déjà de cadres normatifs précis et de codes éthiques spécifiques, le Bénin et d'autres pays africains ne possèdent pas encore de textes dédiés, malgré une adoption croissante de la simulation dans les pratiques de formation.

L'objectif de cette communication est de présenter les résultats d'une analyse des cadres réglementaires et éthiques relatifs à la simulation en santé, et de proposer des pistes d'adaptation au contexte béninois et africain. Cette analyse repose sur une revue documentaire structurée des principaux textes de référence (SSH Guidelines 2024, directives de la HAS, recommandations nord-américaines pour les certifications, code d'éthique de la SSH), complétée par une comparaison avec les pratiques émergentes observées au Bénin.

Il en ressort qu'à l'international, la réglementation accorde une place centrale aux principes éthiques (sécurité psychologique, consentement, équité, confidentialité) et à la standardisation des méthodes pédagogiques (OSCE, patients simulés). Elle encadre également l'usage de la simulation pour certaines certifications, notamment en réanimation néonatale et en chirurgie mini-invasive, et précise, dans certains pays, les modalités d'accréditation des centres et des professionnels. Au Bénin et dans d'autres pays africains, la simulation se développe dans les universités et hôpitaux sans cadre légal spécifique. Toutefois, les enjeux éthiques liés à l'équité d'accès, à la standardisation des pratiques et à la formation des formateurs sont déjà pris en compte.

En conclusion, la simulation en santé requiert un encadrement réglementaire et éthique clair pour garantir son efficacité, son équité et son intégration durable. L'expérience internationale constitue une base solide, mais son adaptation au contexte africain, et béninois en particulier, apparaît indispensable. L'élaboration d'un cadre normatif national est une priorité pour professionnaliser la simulation et renforcer la sécurité des patients.

Mots-clés : Simulation en santé – Éthique – Règlementation – Bénin – SSH Guidelines.

UTILISATION DE LA SIMULATION DANS LA FORMATION DES APPRENANTS EN SANTÉ À COTONOU: ÉTAT DES LIEUX ET FAISABILITÉ**Ismail LAWANI^{1,2}, Gilles S ATTOLOU¹, Nounagnon René HOUNSOU¹, Yacoubou IMOROU SOUAIBOU¹, Freddy HR GNANGNON¹, Ortiz SALLAN², Ahouefa TOI², Gaspard D GBESSI¹, Francis M DOSSOU¹**¹Unité de Chirurgie Viscérale, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi – Bénin,² Hub Béninois de l'Unité de Recherche en Chirurgie Globale du NIHR

* Auteur correspondant: Ismail LAWANI, Email: ismailawani@gmail.com

RÉSUMÉ

La formation en sciences de la santé connaît des transformations majeure à l'échelle mondiale, marquée par l'introduction d'outils pédagogiques innovants comme les techniques de simulation, qui permettent aux apprenants d'acquérir des compétences cliniques dans un environnement sécurisé, contrôlé et reproductible, avant de les appliquer en situation réelle auprès des patients. À Cotonou, le recours à la simulation reste encore limité, bien que son potentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement et la sécurité des soins soit largement reconnu. Cette présentation propose un état des lieux de l'utilisation de la simulation dans la formation des étudiants en santé à Cotonou. En se basant sur les initiatives existantes, l'identification des infrastructures disponibles et des ressources humaines formées, ainsi que l'évaluation des besoins potentiels des institutions académiques et hospitalières, plusieurs initiatives ponctuelles de simulation ont été introduites dans certaines disciplines, notamment en chirurgie, en anesthésie et en soins infirmiers. Toutefois, l'absence d'un centre structuré multidisciplinaire, le manque de formateurs spécialisés et la limitation des ressources matérielles constituent des freins majeurs à une implémentation à large échelle. Il existe cependant des opportunités réelles : l'intérêt marqué des enseignants, la disponibilité de partenariats internationaux, ainsi que l'existence de programmes académiques favorables à l'intégration de la simulation. L'enjeu est désormais de structurer une stratégie progressive et durable afin de positionner la simulation comme pilier de la formation des futurs professionnels de santé au Bénin.

Mots-clés: Simulation médicale, Formation en santé, État des lieux, Faisabilité

RESUME

La médecine traditionnelle occupe une place centrale dans les systèmes de soins en Afrique subsaharienne, et particulièrement au Bénin, où plus de 70 % de la population recourt régulièrement aux plantes médicinales pour la prévention et le traitement des maladies. Face aux limites d'accessibilité et de coût de certaines thérapeutiques, mais aussi aux enjeux de souveraineté sanitaire, la valorisation scientifique de cette pharmacopée s'impose comme une voie stratégique. C'est dans ce contexte que s'inscrit le développement des **Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA)**, qui représentent une interface entre savoirs endogènes et recherche pharmaceutique moderne.

Les MTA sont définis comme des préparations issues de la médecine traditionnelle, mais standardisées, stabilisées et soumises à des procédures de contrôle de qualité rigoureuses. Contrairement aux remèdes artisanaux, ils bénéficient d'un conditionnement pharmaceutique, d'une dose déterminée et d'une traçabilité. Leur conception implique une démarche scientifique intégrée : identification botanique, extraction et caractérisation phytochimique, études pharmacologiques précliniques, évaluation de la toxicité, puis validation clinique. Ainsi, les MTA constituent un modèle original de transposition des savoirs traditionnels dans le champ académique et industriel, tout en respectant les exigences de sécurité, d'efficacité et de qualité.

Au Bénin, plusieurs initiatives illustrent la place croissante des MTA dans la recherche pharmaceutique. Plusieurs institutions telles que, l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université de Parakou, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRAB) etc. mènent des travaux sur des plantes à intérêt thérapeutique reconnu.

Sur le plan scientifique, les MTA représentent un vivier pour la découverte de nouvelles molécules bioactives, susceptibles de déboucher sur des médicaments innovants. La biodiversité végétale du Bénin constitue une ressource considérable pour la recherche de substances originales à activité anti-inflammatoire, antimicrobienne, antiparasitaire ou métabolique. Plus de quarante MTA ont été homologués au Bénin et utilisés notamment dans la prise en charge de différentes pathologies.

Cependant, de nombreux défis devront être levés. L'intégration des méthodes analytiques modernes (chromatographie, spectrométrie de masse, biologie moléculaire) permettra de franchir un cap en matière de validation scientifique. Une plateforme de recherche clinique plus performante permettra de mettre en place des approches adaptatives qui permettront d'accélérer le développement clinique des MTA. L'absence d'une industrie pharmaceutique locale forte limite la production à grande échelle et la compétitivité des MTA. Les questions de propriété intellectuelle liées aux savoirs traditionnels et aux MTA méritent également d'être discutées et règlementées afin de garantir entre autres une exploitation équitable des ressources végétales. Enfin, la confiance des professionnels de santé et du public reste tributaire d'une meilleure communication scientifique et d'une intégration progressive dans les protocoles de soins.

Les MTA constituent à la fois une réponse pragmatique aux besoins de santé publique et un levier de développement scientifique et économique. Le renforcement des partenariats entre chercheurs, praticiens traditionnels, autorités sanitaires et secteur privé est essentiel pour transformer ce potentiel en innovations concrètes. La valorisation des MTA ne se réduit pas à un simple enjeu de santé : elle participe à la construction d'une souveraineté pharmaceutique africaine, à la préservation du patrimoine culturel et à la promotion d'une recherche contextualisée et durable.

Mots-clés: Pharmacopée Nationale, Recherche et Développement des MTA, Homologation, Intégration

**Conf
8a**

**PLACE DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES DANS LA PRISE EN CHARGE
DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES**

MCA AZANDJEME C.

RESUME

NON DISPONIBLE

DÉNUTRITION HOSPITALIÈRE : ÉTAT DES LIEUX

Carmelle Mizéhoun Adissoda^{1,2}

- 1- Ecole de Nutrition et Diététique, Faculté des Sciences de Santé (FSS) de Cotonou, Université d'Abomey Calavi (UAC), Bénin
 - 2- Service de Nutrition Clinique du Centre National Hospitalier Universitaire de -Pneumo phtisiologie de Cotonou
- Email : carmelle.mizehoun@uac.bj, carmelle.mizehoun@gmail.com ; 01 BP 188, Cotonou, Bénin Tél : +229 0194181770

RESUME

La dénutrition est définie comme un changement mesurable des fonctions et/ou de la composition corporelle, induit par un déficit en énergie, en protéines ou en tout micro ou macronutriment. Elle constitue un problème majeur chez les patients hospitalisés et concerne toutes les spécialités médicochirurgicales. Sa prévalence en hospitalisation est rapportée, tant dans les pays industrialisés que dans les pays émergents. Elle augmente la morbidité (infections, retard de cicatrisation), la durée de séjour, les coûts liés aux soins et retentit sur la qualité de vie des patients. Les données disponibles indiquent qu'au moins un patient hospitalisé sur cinq est dénutri en Europe. Dans les pays d'Amérique latine, une revue systématique des études réalisées de 1995 à 2014 rapportait des prévalences variant de 20% à 50%. En Afrique subsaharienne, il est noté des disparités selon les pays. Au Togo, une fréquence de 87% a été enregistrée chez les sujets d'âge ≥ 60 ans de 2017 à 2020. Au Burkina Faso, il a été retrouvé en 2021 une prévalence de 20,7% à l'admission et de 28,3% à la sortie des patients en chirurgie digestive d'urgence. Au Bénin, une étude réalisée en chirurgie viscérale en 2014 montrait une fréquence de 46,6% chez les patients en post-opératoire et les facteurs associés étaient l'âge ≥ 50 ans, les apports énergétiques, protéiques et hydriques faibles, la diarrhée, la présence de cancer, la chirurgie sur le tractus digestif, la chirurgie urgente, une perte de poids significative et l'hyperleucocytose. Une autre plus récente a relevé une fréquence de dénutrition de 29,4% à l'admission contre 54% en postopératoire dans deux centres hospitaliers universitaires. Seuls les patients dénutris avaient présenté des complications postopératoires (36%). L'ensemble de ces résultats soulignent la nécessité d'un dépistage et d'une prise en charge systématiques chez tout patient hospitalisé.

Mots clés : Dénutrition – hospitalisation- fréquence – Dépistage- Prise en charge

**Conf
8c**

NUTRITION ARTIFICIELLE : AVANTAGES ET ÉLÉMENTS DE SURVEILLANCE
Dr FAYEMENDY Philippe
(France)

RESUME

NON DISPONIBLE

**Conf
9**

**SANTÉ REPRODUCTIVE À L'ÈRE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: CAS DES
FORTES CHALEURS ET DE LA MORTALITÉ PÉRINATALE EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE;**

Dr DOSSOU Jean-Paul , CERRUD

RESUME

NON DISPONIBLE



Résumés des communications

Introduction

La simulation est une technique pédagogique qui confronte les apprenants à des situations proches du réel. Employée dans le domaine de la santé, elle favorise l'apprentissage du travail en équipe, essentiel au développement d'une culture de sécurité partagée par tous les professionnels. L'INMeS est doté du Simulateur haute-fidélité Victoria pour l'apprentissage des étudiantes sages-femmes.

Méthodes

Il s'agit de la collecte des données rétrospectives allant de 2023 à 2024. Toutes les étudiantes ayant validées les compétences d'accouchement sur le simulateur Victoria sont incluses dans l'étude. L'outil était la fiche de contrôle des compétences et le matériel le simulateur haute-fidélité Victoria. Des cas cliniques étaient programmés dans le logiciel Victoria puis les étudiantes étaient observés pour la surveillance, l'accouchement, la délivrance du placenta, la révision utérine et la réparation du périnée.

Résultats

Sur 77 étudiantes Sages-femmes de la 2ème année 70 ont pu faire l'accouchement dans le délai programmé dans le logiciel soit un taux de 90,90%. Pour la délivrance du placenta, 100% des étudiantes ont pu l'effectuer correctement. Quant à la révision utérine, plusieurs étudiantes n'ont pas pu le faire, au total 47 sur 77 soit un taux de 61,03%. Presque toutes les étudiantes ont raté la réparation du périnée.

L'utilisation de ce simulateur dans l'apprentissage a augmenté les compétences pratiques des étudiantes sur les lieux de stage. De même les encadreurs de terrain sont très satisfaits de leur prestation.

Conclusion

La simulation s'affirme comme une méthode pédagogique incontournable une acquisition de la compétence avant la pratique sur le vivant.

Mots - clés : Simulation, accouchement, compétence , Simulateur, Victoria

VARIATIONS DES BRANCHES COLLATÉRALES DE L'ARC AORTIQUE: ÉTUDE CADAVERIQUE

Christel Marie Laleye¹, Tata Touré², Abdoulaye Kanté², Gervais Martial HOUNNOU¹

1 : Laboratoire d'Anatomie Humaine de la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de Cotonou, Bénin

2 : Laboratoire d'Anatomie de la Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie (FMOS) de Bamako, Mali

Auteur correspondant : Christel Marie LALEYE : laleyefor@yahoo.fr, Tel : (+229)0197925134

Introduction : L'arc aortique donne trois branches collatérales qui sont, de droite à gauche, le tronc brachio-céphalique, l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche. Les variations de ces branches sont nombreuses et fréquentes. Il a été suggéré que ces variations sont plus fréquentes dans la population africaine. Le but de cette étude était de rapporter la prévalence des variations et les différents types de variation des branches collatérales de l'arc aortique dans une série africaine.

Méthodologie : Il s'agissait d'une étude anatomique transversale et observationnelle. Au total 69 arcs aortiques ont été disséqués (58 chez les hommes et 11 chez les femmes). Les résultats ont été classés selon la classification de Popieluszko et al.

Résultats : La modalité classique (Type 1) a été observée dans 43 cas (62,3%). Les variations ont été observées dans 26 cas (37,7%). La plus fréquente de ces variations était l'arc bovin (Type 2) avec une prévalence de 29% (n=20), suivi de l'association de l'arc bovin et de l'artère vertébrale (Type 4) (2,9% soit n=2). Les autres variations ont été observées, chacune, dans 1 cas (1,4%). Il s'agissait de Type 3 (artère vertébrale), Type 5 (tronc bicarotidien), Type 6 (artère subclavière droite aberrante) et une variation non incluse dans la classification de Popieluszko et al. (la naissance de l'arc aortique de l'artère vertébrale gauche et de l'artère subclavière gauche).

Conclusion : Les variations dans les branches collatérales de l'arc aortique sont fréquentes. La connaissance de ces variations est importante pour les chirurgiens vasculaires lors de certaines interventions telles que la pose de stent carotidien pour éviter les complications peropératoires.

Mots clés : dissection, arc aortique, classification.

MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRECOCE DU CANCER DE L'ENFANT AU BENIN

LADJOUAN M C A^{1,2}, BOGNON G^{1,2}, DIEYE F L², MASSI R³, KINDJINOU M⁴, HESSISSEN L², SAGBO G G^{1,2}

1- Unité d'Oncologie Pédiatrique (UOP) Centre Hospitalo-Universitaire (CHUDOP), Porto-Novo, Bénin

2- Groupe Franco-Africain d'Oncologie Pédiatrique (GFAOP), Villejuif, France

3- Unité d'Hématologie du Centre Hospitalo-Universitaire (CHUDOP), Porto-Novo, Bénin

4- Service d'Ophtalmologie du Centre Hospitalo-Universitaire (CHUDOP), Porto-Novo, Bénin

Auteur correspondant : LADJOUAN C, 01BP 1884 Cotonou, tél. +229 0197887501, lakanho@yahoo.fr

Introduction : le cancer de l'enfant est greffé d'une lourde mortalité dans la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire comme le Bénin parce qu'il est diagnostiqué tardivement. Dans l'objectif de réduire le nombre de patients consultant à des stades tardifs, le GFAOP a mis en place un programme de diagnostic précoce d'abord soutenu par la Fondation BMS puis par la Fondation S.

L'objectif de ce travail est de faire le point de la mise en œuvre au Bénin de ce programme basé sur le renforcement des compétences des soignants et la sensibilisation de la communauté de 2019 à 2023.

Méthodologie : les activités du diagnostic précoce du cancer de l'enfant du GFAOP au Bénin s'étaient déroulées de 2019 à 2023. Elles étaient basées sur le renforcement des compétences des soignants et la sensibilisation de la communauté. Deux cibles avaient été identifiées : il s'agit des agents de santé en contact avec les enfants (médecins spécialistes ou non, infirmiers et sage-femmes), et de la communauté (parents d'enfants, tradithérapeutes, leaders religieux, groupements de femmes). Concernant le personnel de santé, les activités étaient principalement la sensibilisation sur l'existence du cancer de l'enfant et la formation sur les signes précoces du cancer de l'enfant et la référence. Les activités en rapport avec la communauté étaient essentiellement la sensibilisation sur les signes devant faire consulter tôt une structure sanitaire. Des modules éducatifs (manuels, affiches, fiches techniques) conçus par les experts en oncologie pédiatrique du GFAOP pour la détection des signes précoces des cinq principaux cancers pédiatriques (rétinoblastome, leucémie aiguë lymphoblastique, néphroblastome, lymphome de Burkitt et de Hodgkin) avaient servi à former des formateurs puis des soignants en cascade.

Résultats : la formation des agents de santé s'était déroulée dans les douze départements du Bénin. Initialement, une formation des formateurs avait permis de former 30 formateurs dont 24 pédiatres et 6 médecins généralistes. Secondairement, ces formateurs devenus des points focaux dans leurs différents départements, avaient formé au total 374 agents de santé. Des groupes de discussion WhatsApp avaient été mis sur pied par département pour les agents de santé formés, les formateurs et les membres du comité de prise en charge. La digitalisation de la formation sur le diagnostic précoce a facilité le recyclage de ces derniers. La sensibilisation de la communauté s'était intéressée aux tradithérapeutes, leaders religieux, associations de femmes et parents d'enfants. Elle était une sensibilisation présentielle grâce à des supports audio-visuels et des émissions sur les chaînes de radios ou de télévisions locales. Les activités du diagnostic précoce ont permis de rendre effective la référence (22 en 2018 versus 121 en 2023) et de passer d'un taux presque nul de diagnostic précoce à un taux de 17,7% en 2022 et 44,3% en 2023.

Conclusion : le programme du diagnostic précoce du GFAOP a permis d'améliorer la référence et d'atteindre un taux de réalisation du diagnostic précoce de 44,3%. Cependant, les activités de ce programme doivent être continues et renforcées afin d'atteindre les objectifs du GFAOP et de l'OMS d'ici 2030.

Mots clés : diagnostic précoce – cancer enfant – sensibilisation – formation personnel

Simulation en traumatologie, un levier pour l'amélioration de la formation et de la qualité des soins au Benin

Pascal CHIGBLO¹, Adébola PADONOU¹, Oswald GOUKODADJA¹, François AMOSSOU², Aristote HANS-MOEVI¹

1 : Clinique Universitaire de Traumatologie – Orthopédie, CNHU-HKM de Cotonou

2 : Service de Chirurgie CHUD-OP Porto-Novo

Correspondant ; Pascal CHIGBLO, 10 BP 423 Cotonou, tel 0197411745, chispaer@yahoo.fr

CO04

Résumé

:

La traumatologie demeure un défi majeur de santé publique, particulièrement dans les contextes où la prise en charge des urgences est complexe et exige rapidité, précision et travail en équipe. Elle représente une part importante de la morbidité et de la mortalité dans les pays à ressources limitées, où l'accès à des plateaux techniques modernes est limité et le personnel qualifié insuffisant. L'apprentissage des gestes chirurgicaux s'est fait pendant longtemps directement sur le malade. La simulation médicale s'impose comme une méthode pédagogique innovante, favorisant l'acquisition des compétences techniques et non techniques indispensables à la gestion des traumatismes. Elle permet de reproduire des situations cliniques critiques dans un environnement sécurisé, sans risque pour le patient, tout en améliorant la communication interprofessionnelle et la prise de décision. L'intégration de la simulation en traumatologie contribue à standardiser les pratiques, à réduire les erreurs médicales et à renforcer la confiance des soignants, qu'ils soient en formation initiale ou continue. Malgré les contraintes liées au coût et à l'accessibilité des simulateurs, elle a commencé timidement au Benin depuis l'an 2015 avec l'appui d'une ONG internationale et le soutien du Ministère de la Santé. Elle a permis la formation des professionnels de santé de tout ordre, notamment chirurgiens, résidents de chirurgie, médecins généralistes, infirmiers de bloc opératoire et infirmiers des services des urgences, à l'amélioration de la prise en charge des lésions musculosquelettiques traumatiques. Elle utilise comme matériels les instruments chirurgicaux, les implants d'ostéosynthèse, l'os synthétique. La croissance exponentielle des candidatures au fil des ans, montre l'engouement des professionnels de santé pour ce nouveau mode de formation. Le matériel acquis à ce jour peut permettre la poursuite de la simulation au Benin, même en dehors de tout appui étranger, par la recherche de solutions adaptées, telles que les modèles à faible coût et les plateformes collaboratives. En effet le matériel de base qu'est l'os synthétique coûte cher et le bambou, une plante herbacée a déjà fait ses preuves ailleurs. La simulation en traumatologie apparaît ainsi comme un outil stratégique pour optimiser la formation, améliorer la qualité des soins et réduire la mortalité liée aux traumatismes.

Mots-clés : Simulation – Traumatologie – Formation – Urgences – Qualité des soins

Apport de l'ia shuri dans la segmentation automatique des organes pleins abdominaux intrapéritonéaux à la tomodensitométrie au sud du Bénin 2024.

Auteurs : ADJADOHOUN Sonia. B.M.G*, LALEYE C**, SOUNOUNAMETO M.C.B *, AYI MEGNANGLO AUSTER*, WHENU S P U*, YEKPE A P*

*Unité d'Imagerie Médicale/ UFR Médecine/FSS/ Université d'Abomey Calavi/ Bénin

** Unité d'anatomie /UFR Médecine/ FSS / Université d'Abomey Calavi/ Bénin

Correspondant : mail : mahussi222@yahoo.fr; tel (00229) 0161154987

RESUME

Introduction

La segmentation automatique basée sur des solutions d'intelligence artificielle (IA) des organes abdominaux à la tomodensitométrie (TDM) est essentielle pour le diagnostic, la planification chirurgicale, la radiothérapie et l'enseignement. Peu de solutions d'IA sont développées sur des données africaines notamment béninoises. Cette étude visait à évaluer l'apport de l'IA Shuri dans la segmentation automatique des organes pleins abdominaux intrapéritonéaux (foie, rate, pancréas) à la TDM chez des sujets du sud du Bénin en 2024, répondant ainsi aux besoins locaux et à la stratégie nationale d'IA.

Matériel et méthode

Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et analytique avec collecte rétrospective, menée dans quatre centres d'imagerie du Sud du Bénin sur une la période de janvier à décembre 2024. Ont été inclus des patients adultes ayant bénéficié d'une TDM abdominale sans anomalie des organes d'intérêt avec images exploitables.

La segmentation manuelle a été réalisée à l'aide du logiciel 3D Slicer, suivie de l'entraînement de l'IA Shuri (basée sur nnU-Net) sur ces données, avec la validation et les tests sur des sous-ensembles distincts. Les performances de l'IA Shuri ont été évaluées par le score de Sørensen-Dice et l'indice de Jaccard.

Résultats

Ont été colligés 100 patients adultes avec un âge de $50,85 \pm 19,54$ ans et une sex-ratio de 0,79. La segmentation manuelle a permis de caractériser les organes : le volume moyen de $1588,9 \pm 388,8$ cm³ pour le foie, $183,3 \pm 122,7$ cm³ pour la rate et $69,4 \pm 30$ cm³ pour le pancréas, sans corrélation significative avec l'âge ni le sexe ($p > 0,05$).

L'IA Shuri a atteint des scores de Sørensen-Dice de $0,97 \pm 0,02$ (foie), $0,98$ (rate) et $0,95 \pm 0,01$ (pancréas). Le temps moyen de segmentation manuelle était de 2 heures par sujet contre deux minutes avec l'IA Shuri.

Conclusion

L'IA Shuri a une bonne performance dans la segmentation automatique de certains organes abdominaux à la TDM. Elle constitue un outil d'aide au diagnostic adapté aux particularités béninoises. Ces résultats pourraient constituer une référence locale.

Mots clés : intelligence artificielle, Shuri, segmentation, TDM, organes abdominaux, Bénin

Structuration d'une base de données à la Clinique Universitaire de Chirurgie Viscérale du CNHU – HKM au Bénin.

Gbessi MEM^{1,2}, Kougninou EPLP¹, Tamadaho SPA¹, Ogouyemi WP¹, Laleye C-M^{1,2}, Akifewa FA, Gbessi DG¹.

¹Clinique Universitaire de Chirurgie Viscérale, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou (Bénin).

²Laboratoire d'Anatomie Humaine, Faculté des Sciences de la Santé de l'Université d'Abomey – Calavi.

Auteur correspondant : GBESSI Mahugnon Emmanuel Martino ; tél : +229 0194479396 ; e – mail : martino.emmanuel@gmail.com

Résumé

Introduction

Dans les systèmes hospitaliers à ressources limitées, l'absence d'archivage numérique structuré des actes opératoires freine l'analyse épidémiologique, la planification des ressources et la recherche. Nous avons développé un système d'indexation multicritère permettant une lecture croisée et dynamique de l'activité chirurgicale sur dix ans au sein de la Clinique Universitaire de Chirurgie Viscérale du CNHU–HKM. Ce travail vise à en décrire la structuration, l'utilité et les perspectives pour la recherche, la pédagogie et l'amélioration des soins.

Méthode

Une base de données rétrospective a été constituée via KoboCollect, à partir des registres opératoires du bloc central et des urgences, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2024. Chaque cas a été indexé manuellement selon sept dimensions : spécialité/segment anatomique, pathologie principale et secondaire, organe ou siège concerné, nature de la pathologie, voie d'abord, et geste opératoire principal. L'analyse descriptive a été réalisée sous Excel.

Résultats

Sur 4.895 interventions chirurgicales, 71 % ont été réalisées au bloc opératoire central. La sex-ratio était de 1,01 et l'âge moyen des patients de $44,5 \pm 17,1$ ans (1 – 95 ans). L'abdomen représentait 52,9 % des localisations opérées. Les pathologies tumorales prédominaient (33 %). Les indications principales étaient : cancer (18,5 %), hernie (14,5 %), tumeur bénigne (10 %), confection de fistule artério – veineuse pour hémodialyse (8,2 %) et appendicite (7,3 %). La voie ouverte restait majoritaire (91,9 %), suivie de la thoracotomie (5,1 %) et de la coelioscopie (2,6 %).

Conclusion

Ce système **innovant et structuré** constitue un levier stratégique pour l'amélioration continue des soins, la formation spécialisée, et la recherche appliquée en chirurgie. Son adaptabilité permet une reproduction dans d'autres contextes hospitalo – universitaires.

Mots-clés : Chirurgie viscérale, Base de données, Indexation multicritère, Épidémiologie chirurgicale, Qualité des soins, Bénin.

RECONSTITUTION DE L'EXPOSITION AU TOLUÈNE PAR DOSIMÉTRIE INVERSE : UNE APPROCHE INNOVANTE EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE À COTONOU

Honesty TOHON & Paul AYÉLO

Unité d'Enseignement et de Recherche en Santé au Travail et Environnement, Département de santé publique, Faculté des sciences de la santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : Honesty TOHON

Email auteur correspondant : honesty.tohon@yahoo.ca

Introduction :

Le toluène est un solvant organique largement utilisé dans les carburants et certaines industries, reconnu pour ses effets néfastes sur le système nerveux central, le foie et le rein. À Cotonou (Bénin), les conducteurs de taxi-motos sont particulièrement exposés, en raison de leur activité professionnelle intense dans un environnement fortement pollué. La quantification directe de l'exposition atmosphérique individuelle au toluène demeure complexe et coûteuse. La dosimétrie inverse basée sur la modélisation pharmacocinétique à base physiologique (en anglais : reverse dosimetry using physiologically based

pharmacokinetic (PBPK) modeling) permet d'estimer l'exposition externe à partir de biomarqueurs urinaires, constituant ainsi une approche innovante en santé environnementale.

Méthodes : Une étude transversale a été menée auprès de 31 conducteurs de taxi-motos recrutés par convenance sur plusieurs aires de stationnement/repos à Cotonou. Des échantillons d'urines de 24h ont été collectés pour mesurer l'ortho-crésol (o-crésol), biomarqueur spécifique du toluène, par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Les concentrations d'o-crésol ont été intégrées dans un modèle pharmacocinétique à base physiologique (PBPK) afin de reconstituer les concentrations atmosphériques inhales correspondantes.

Résultats : La majorité des conducteurs investigués présentaient des niveaux détectables d'o-crésol, indiquant une exposition significative au toluène. Les concentrations atmosphériques reconstituées indiquaient que les médianes variaient entre 0,07 and 0,10 ppm, les centiles 90 entre 0,15 and 0,21 ppm et les centiles 95 entre 0,23 and 0,30 ppm, suggérant ainsi, pour chaque individu, ainsi des valeurs inférieures à la valeur limite d'exposition professionnelle établie par diverses agences de réglementation de la santé environnementale et professionnelle en Amérique du Nord et en Europe (Santé Canada : 0,6 ppm pour une exposition continue 24 h/jour, et 4 ppm pour une exposition de courte durée pendant 8 h).

Conclusion : Cette étude met en évidence une exposition des conducteurs de taxi-motos au toluène à

Cotonou qui ne dépasse pas les valeurs guides. Elle démontre l'intérêt de la dosimétrie inverse comme outil innovant pour l'évaluation de l'exposition en santé environnementale, une approche applicable pour d'autres polluants organiques volatils, et l'intégration de la simulation toxicocinétique dans les stratégies de prévention et les politiques publiques en Afrique de l'Ouest.

Mots-clés : toluène, dosimétrie inverse, simulation, biomarqueurs, exposition professionnelle, santé environnementale

« RESEAUX SOCIAUX NUMERIQUES INFORMELS ET INNOVATIONS EN SANTE : LE ROLE DES RESNIS DANS LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES ET DE L'INFERTILITE AU BENIN ».

Danh Annick N'GUESSAN, Rafath ALIASSOU, Agnès Oladoun BADOU SAVI,

Email : abognes@yahoo.fr, +229 01 9732 3305

CO08

RESUME

Introduction : Les maladies chroniques représentent aujourd'hui un défi majeur de santé publique, marqué au Bénin par une prévalence croissante et par des contraintes structurelles, notamment la concentration des infrastructures sanitaires en milieu urbain, l'insuffisance du personnel qualifié et la faible couverture de l'assurance maladie. Ces limites du système formel conduisent patients et proches à développer des stratégies alternatives de prise en charge. Parmi elles, les réseaux sociaux numériques informels de santé (ReSNIS), créés sur des plateformes comme WhatsApp et Facebook, s'imposent comme de véritables innovations sociales, échappant toutefois au contrôle institutionnel. Cette communication analyse le rôle des ReSNIS dans la gestion des maladies chroniques et des problèmes d'infertilité à Abomey-Calavi et Cotonou.

Méthodologie : L'étude repose sur une enquête qualitative combinant revue documentaire, entretiens semi-directifs (patients, proches, producteurs de contenus et usagers extérieurs) et observation auprès des phytothérapeutes et au sein des groupes numériques. L'analyse des données, réalisée avec le logiciel Dedoose, s'appuie sur l'interactionnisme symbolique (H. Blumer, 1969) et la théorie des représentations sociales (S. Moscovici, 1961).

Résultats : Les résultats montrent que les ReSNIS assurent des fonctions multiples : partage d'expériences, soutien psychosocial, circulation de conseils thérapeutiques et co-construction de savoirs profanes. Concernant l'infertilité, ces espaces offrent des alternatives aux parcours biomédicaux souvent jugés coûteux ou inefficaces, et valorisent les pratiques phytothérapeutiques et spirituelles. Ils influencent ainsi les trajectoires de soins, parfois en complément, parfois en concurrence avec la biomédecine.

Conclusion : Les ReSNIS apparaissent donc comme des dispositifs hybrides : ils favorisent l'autonomisation des malades et renforcent la légitimité de pratiques populaires en santé reproductive et dans la gestion des maladies chroniques, mais soulèvent des enjeux de fiabilité des informations et de sécurité sanitaire. Ces constats invitent à repenser les politiques de santé numérique, en articulant initiatives institutionnelles et pratiques informelles.

Mots clés : Réseaux sociaux numériques informels, innovation en santé, maladies chroniques, infertilité, phytothérapie, Bénin

ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DES PRATIQUES DE LAVAGE ET DE CONSERVATION SUR LES TENEURS EN RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LE CHOU (*Brassica Oleracea*) ET LA LAITUE (*Lactuca Sativa*)

AGBOKPONTO J. Engelbert^{1,2}, MIZEHOUN ADISSODA Carmelle^{1,3}, SENATO Sandrine^{1,2}, DJOUAKA Rousseau⁴, SINDA Valery⁴, BIAOU Borrel^{1,2}, YEMOA Achille^{1,2}.

CO09

¹ Centre de Recherche et de Développement de Médicaments Pharma-Lab, Université d'Abomey-Calavi, Campus du champ de Foire, 01BP 188, Cotonou, Bénin ;

² Unité de Recherche en Chimie analytique et d'Analyse des Médicaments, FSS/UAC ;

³ Ecole de Nutrition et diététique, FSS/UAC ;

⁴ Laboratoire AgroEcoHealth, Institut International d'Agriculture Tropicale, IITA Bénin.

Introduction : La consommation de légumes contaminés par les résidus de pesticides constitue un risque majeur pour la santé publique. Cette étude vise à évaluer l'efficacité des pratiques de lavage et de conservation sur la réduction des teneurs en résidus de pesticides dans la laitue (*lactuca sativa*) et le chou (*Brassica oleracea*), deux légumes couramment consommés au Bénin.

Matériel et méthodes : Des échantillons de laitue et de chou ont été collectés auprès de producteurs locaux. Une méthode analytique optimisée et validée a été utilisée pour identifier et quantifier les résidus de quatre pesticides couramment utilisés en maraîchage au Bénin (acétamipride, emamectine-benzoate, chlorpyrifos-éthyl, lambda-cyhalothrine). Des tests ont été réalisés pour évaluer l'impact de la conservation et de différentes méthodes de lavage (eau de robinet, des solutions de permanganate de potassium à 0,25 g/L, 0,50 g/L, 1 g/L et des solutions de vinaigre à 2,5%, 5% et 10%). Des lots de laitue biologique sans pesticides ont été dopés au laboratoire avec les quatre pesticides sélectionnés à des concentrations connues et les teneurs en résidus de pesticides ont été analysées après divers traitements de pratiques de lavage et de conservation suivant le protocole expérimental.

Résultats : Les résultats montrent que le taux de réduction des résidus de pesticides varie en fonction de trois facteurs : la méthode de décontamination appliquée, la concentration de la solution de lavage et la nature des pesticides. Le permanganate de potassium (0,25 g/L et 0,5 g/L) est efficace pour éliminer les résidus de pesticides hydrophobes. Le lavage à l'eau et au vinaigre (2,5 % (V/V) et 5 % (V/V)) élimine efficacement les résidus de pesticides hydrosolubles. La conservation a également démontré une efficacité notable, en réduisant les résidus de pesticides à courte demi-vie de manière très significative.

Conclusions et implications : La combinaison de différentes méthodes de décontaminations comme le lavage au permanganate suivi du lavage à l'eau, permettra d'optimiser la réduction des résidus de pesticides, offrant ainsi une efficacité maximale.

Mots-clés : Résidus de pesticide, laitue, chou, lavage, décontamination.

EFFET DE DEUX MOLECULES DE FER ORAL DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE MARTIALE CHEZ LES INSUFFISANTS CARDIAQUES AU CNHU-HKM DE COTONOU DE 2023 A 2024

Soummonni AF¹, Baglo Agbodande T², Hounkponou M¹, Zanda Vougo MMM¹, Bokodaho MD¹, Hounsou MSYRN¹, Sampil AY¹, Kpoholo SDM¹, Savi DM¹, Tete MA¹, Ngossong PFL¹, Dossou D¹, Fadonougbo X¹, Agbalika Ph¹, Zohoun CA², Sonou DJA¹, Codjo HL³

Affiliation :

¹Clinique Universitaire de Cardiologie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert KOUTOUKOU MAGA de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Cotonou, Bénin

²Clinique Universitaire des Maladies du Sang du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert KOUTOUKOU MAGA de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Cotonou, Bénin

³Centre Hospitalier International de Calavi, Unité d'Enseignement et de Recherche de Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

*Auteur correspondant : SOUMMONNI Agué Francis, e-mail : soumonaf@yahoo.fr

Introduction : La carence martiale est fréquente chez les patients insuffisants cardiaques et constitue un facteur aggravant leur pronostic. Cette étude visait à évaluer l'efficacité comparative de deux formes de fer oral : l'Hydroxyde Ferrique Polymaltose (HFP) et le Sulfate Ferreux (SF)) dans la correction de la carence martiale chez les insuffisants cardiaques suivis à la Clinique Universitaire de Cardiologie (CUC) du CNHU-HKM de Cotonou.

Méthodes : Il s'agit d'une étude d'intervention menée de janvier 2023 à août 2024. Ont été inclus les patients insuffisants cardiaque des deux sexes, d'âge supérieur à 18 ans présentant une carence martiale (ferritinémie < 100 ng/ml ou ferritinémie entre 100 et 300 ng/ml associée à un coefficient de saturation de la transferrine < 20%) et répartis en deux groupes recevant 200mg soit du HFP, soit du SF. L'évaluation a été réalisée trois mois après l'instauration du traitement. Les variables étudiées incluaient la correction de la carence martiale, la classe fonctionnelle NYHA, le test de marche de 6 minutes, la fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) et le taux de réhospitalisation.

Résultats : Au total, 148 patients ont été inclus. L'âge moyen était de $52,9 \pm 17,6$ ans et la sex-ratio de 0,94. Avant la mise sous traitement, 51,5% étaient au stade II de NYHA, 66,6% avaient une dysfonction systolique du ventricule gauche et la carence martiale observée chez 33,1%. Aucune différence n'était observée entre les deux groupes (HFP et SF). Après trois mois de prise de fer oral, la correction de la carence a été obtenue chez 33,3 % des patients (23,7 % sous HFP, 43,5 % sous SF). Une amélioration de la classe fonctionnelle NYHA, de la FEVG et du test de marche de 6 minutes a été observée dans les deux groupes, sans différence statistiquement significative. La réhospitalisation était de 9,1 % et la mortalité de 6 %.

Conclusion : Le fer oral, qu'il s'agisse de HFP ou de SF, pourrait être une alternative thérapeutique dans la prise en charge de la carence martiale chez les insuffisants cardiaques.

Mots clés : carence martiale, insuffisance cardiaque, fer oral, Cotonou.

PHYTOCHIMIE ET ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE DE DEUX EXTRAITS DE PLANTES MÉDICINALES DU BÉNIN

**Kossi Jean Marie D. Tokoudagba¹, Rafiatou Ba², Ayide C. Ahouansou¹,
Fernand A. Gbaguidi¹, Lamine Saïd Baba-Moussa²**

¹ Centre de Recherche et de développement du Médicament Pharma Lab (CRDM-Pharma Lab) Unité de Recherche en Chimie Organique et Pharmaceutique¹ UFR Pharmacie, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Campus du Champ de Foire 01BP 188 Cotonou Bénin

² Laboratoire de Biologie et de Typage moléculaire en Microbiologie², Département de Biochimie et de Biologie Cellulaire, Faculté des Sciences et Techniques Université d'Abomey-Calavi

Correspondant auteur: tokusj@yahoo.fr

Résumé

Waltheria indica (Malvaceae) et *Clausena anisata* (Rutaceae) sont deux plantes utilisées traditionnellement pour diverses affections. L'utilisation des plantes de la médecine traditionnelle en particulier les médicaments à base de plantes a crû ces dernières décennies du fait de la cherté des produits pharmaceutiques. Les remèdes à base de plantes sont devenus une voie prometteuse pour le développement de phytomédicaments.

Méthodologie : Nous avons dans le présent travail préparé les extraits, fractionné les extraits ; puis doser les polyphénols et étudier l'activité antibactérienne des extraits. Les extraits ont été obtenus par macération et évaporation à partir des feuilles séchées réduites en poudre de ces plantes. Nous avons fractionné les extraits obtenus par la méthode d'extraction liquide-liquide. Nous avons dosé les flavonoïdes et les polyphénols par les méthodes colorimétriques dans ces fractions. Nous avons testé les extraits et les fractions sur six souches microbiennes de référence et huit souches cliniques.

Résultats : Les rendements des extraits bruts sont respectivement de 20% et 17%. Les résultats des dosages nous ont montré que les fractions polaires sont très riches en polyphénols, et ces fractions ont une activité bactéricide plus que les fractions apolaires et extraits bruts (Bassene ; Dinzedi)

Conclusion : Ces plantes pourraient être une alternative pour les infections microbiennes et contribuer à la valorisation des plantes de la médecine traditionnelle.

Mots clés : *Waltheria indica* *Clausena anisata* phytochimie activité antibactérienne

Enquête ethnobotanique sur les plantes médicinales utilisées contre les dermatoses et le paludisme à Kakanitchoé (Bénin)

Fabrice AKPADJAN¹⁻², Elodie SASSE³, Habib GANFON¹⁻³, Emmanuel SEKLOKA⁴, Charles POMALEGNI⁵, Léonard AFOUDA⁶, Florent OKRY⁷, Armand NATTA⁶, Gustave BONNI⁴, Brice OUSSOU⁵, Lucien IMOROU⁴, Auriol AHIDJANHOUN⁴, Guy MENSAH⁵

¹Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

²Service de Dermatologie-Vénérologie, Centre de Dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli d'Allada (CDTUB_Allada), Bénin

³UFR de Pharmacie, Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, UAC, Bénin

⁴Institut de Recherche sur le Coton (IRC), Bénin

⁵Institut National de Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), Bénin

⁶Université de Parakou (UP), Bénin

Auteur correspondant : AKPADJAN Gbèmawonmède Fabrice ; barfice@yahoo.fr

Introduction

Dans un contexte où plus de 80 % des populations africaines recourent à la médecine traditionnelle, l'identification et la valorisation des plantes médicinales locales constituent un enjeu de santé publique. À Kakanitchoé (Bénin), le paludisme et les affections dermatologiques sont les principales pathologies qui sévissent. Cette étude a eu pour objectif d'inventorier les espèces végétales utilisées localement pour leur traitement et d'analyser leurs propriétés phytochimiques.

Cadre et méthodes

Une enquête ethnobotanique a été réalisée auprès des tradipraticiens, herboristes et chefs de ménages de la localité de Kakanitchoé à Adjohoun au Bénin. Les données ont été collectées par entretiens semi-structurés et observations directes. Dans un premier temps, les plantes utilisées pour le traitement des affections dermatologiques et du paludisme ont été recensées, ainsi que les parties utilisées et les modes de préparation de chacune d'elles. Dans un second temps les identifications botaniques ont été validées par des experts et complétées par une revue de la littérature.

Résultats

Plusieurs dizaines d'espèces végétales ont été recensées, principalement issues de familles botaniques riches en espèces médicinales. Les enquêtés ont cité 18 espèces pour le traitement des affections dermatologiques et 39 espèces dans le traitement du paludisme. *Momordica charantia* et *Vernonia amygdalina* étaient plus citées pour le traitement des affections dermatologiques (sans précision diagnostique), tandis que *Senna siamea* et *Azadirachta indica* ont été les plus cités pour traiter le paludisme. La drogue végétale la plus utilisée était la feuille et le mode de préparation le plus utilisé était la décoction pour les deux groupes d'affections.

La revue phytochimique confirme la présence de composés actifs majeurs (alcaloïdes, flavonoïdes, tanins, terpènes) aux propriétés antimicrobiennes, antiparasitaires et anti-inflammatoires.

Conclusion

La pharmacopée traditionnelle à Kakanitchoé joue un rôle central dans la prise en charge des affections dermatologiques et du paludisme. Les espèces identifiées constituent un réservoir de molécules bioactives susceptibles d'être valorisées dans le développement de médicaments traditionnels améliorés. Des recherches complémentaires portant sur la toxicité, l'efficacité clinique et la standardisation sont nécessaires pour une meilleure intégration de ces ressources dans les systèmes de santé.

Mots clés : Ethnobotanique, phytothérapie, dermatoses, paludisme, Bénin

INDEX ET CHARGES GLYCÉMIQUES DE QUELQUES BOUILLIES À BASE DE CÉRÉALES LOCALES

Carmelle Mizéhoun-Adissoda¹, Amirath Okanla¹, Océane Danmadou¹ Bonaventure Awèdè²

1) Ecole de Nutrition et Diététique, Faculté des Sciences de Santé (FSS) de Cotonou, Université d'Abomey Calavi (UAC), Bénin

2) Laboratoire de Physiologie humaine, Unité de Formation et de recherche en Médecine FSS/UAC, 01 BP 188, Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : Carmelle Mizéhoun-Adissoda

Email : carmelle.mizehoun@uac.bj, carmelle.mizehoun@gmail.com ; 01 BP 188, Cotonou, Bénin Tél : +22994181770

RESUME

Introduction : Une alimentation de qualité joue un rôle essentiel dans la prévention de nombreuses maladies non transmissibles. Sur le plan nutritionnel, les mesures de prévention intègrent la quantité et la qualité des nutriments contenus dans les aliments. L'index et la charge glycémiques sont deux paramètres qui témoignent de leur intérêt nutritionnel. L'objectif était donc de déterminer l'index et la charge glycémique de bouillies de céréales fréquemment consommées au Bénin.

Méthode : Du 02 décembre 2024 au 30 janvier 2025, nous avons mené une étude transversale à visée descriptive sur 12 participants âgés de plus de 18 ans. Tous les dosages ont été réalisés sur des échantillons de sang veineux pour la glycémie. La veille des tests, les sujets ne buvaient pas de jus de fruits, d'alcool, ne pratiquaient pas d'activité physique intense et prenaient un dîner léger. Les prélèvements étaient réalisés après 12h de jeûne. Chaque sujet a été testé une fois pour l'aliment de référence et pour chaque recette. Les prélèvements ont été réalisés à T0, T1= 15min, T2= 30 min, T3= 45 min, T4= 60 min, T5= 90 min et T6= 120 min. Chaque test a duré 2h de temps. L'index et la charge glycémique ont été calculés conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Résultats : Les valeurs moyennes d'IG ($IG \pm$ Coefficient de variation) des aliments testés étaient : bouillie de maïs ($35,32 \pm 0,08 \%$), bouillie de riz ($36,11 \pm 0,47 \%$), Fura ($82,64 \pm 0,04\%$). Les valeurs moyennes de la CG ($CG \pm$ Coefficient de variation) étaient : bouillie de maïs ($17,66 \pm 0,08 \%$), bouillie de riz ($18,05 \pm 0,47 \%$), Fura ($41,32 \pm 0,04\%$). Les bouillies de maïs et de riz présentaient un IG faible et une CG moyenne alors que celle de Fura avait un IG et une CG élevés (pour une portion apportant 50g de glucides).

Conclusion : Ces résultats ont montré que les bouillies à base de céréales locales consommées au Bénin sont des aliments de qualité glycémique acceptable donc favorable à la prévention des maladies métaboliques. Néanmoins, ils doivent être consommés avec modération.

Mots- clés : index glycémique (IG), charge glycémique (CG), céréales, bouillie.

SUIVI NUTRITIONNEL DES GESTANTES ET EFFETS SUR LEUR ETAT NUTRITIONNEL ET CELUI DE LEUR NOUVEAU-NE A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE (CUGO) DU CNHU-HKM

MIZEHOUN Carmelle, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la santé, Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phtisiologie de Cotonou

AMAHOUMI Annette, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga, Clinique Universitaire de Gynécologie Obstétrique

DANMADOU Océane, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la santé, Ecole de Nutrition et Diététique

LISBOA Parménas, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences de la santé

Orateur pour les J4S3 : LISBOA Parménas Samson, Nutritionniste Diététiste

E-mail : lisboasamson@gmail.com

Modalité d'intervention : Présentation affichée

RESUME

Introduction : L'alimentation joue un rôle crucial dans le maintien de la santé et présente des caractéristiques spécifiques selon l'état physiologique, notamment durant la grossesse. Les besoins de la grossesse affectent significativement le développement du fœtus in utéro.

Méthode : L'étude, menée entre juillet 2023 et décembre 2024, était interventionnelle, longitudinale et prospective. Elle a inclus 90 gestantes réparties en un groupe des suivies (30) bénéficiant d'un suivi nutritionnel et un groupe des non suivies (60). Le suivi nutritionnel comprenait des consultations, un suivi pondéral et des interventions spécifiques.

Résultats : Le gain pondéral était mieux maîtrisé chez les gestantes suivies, tandis que celles du groupe des non suivies présentaient plus souvent un gain insuffisant, sauf chez celles en surpoids. Le poids moyen des nouveau-nés était plus élevé dans le groupe des suivies (3131,4g) que dans le groupe des non suivies (2825,8g), avec une prévalence plus importante du faible poids de naissance (16,7 % contre 3,2 %) et de la prématurité (25,0 % contre 10,0 %) dans le groupe des non suivies. Les complications maternelles, notamment l'hypertension, la prééclampsie et l'anémie, étaient plus fréquentes chez les gestantes non suivies. Par ailleurs, le suivi nutritionnel a amélioré les habitudes alimentaires des gestantes suivies, augmentant leur consommation de fruits, légumes et micronutriments essentiels.

Conclusion : Ces résultats soulignent l'importance d'un accompagnement nutritionnel adapté tout au long de la grossesse pour améliorer la santé maternelle et infantile même si notre étude n'a pas montré d'association significative entre tous les résultats et le suivi nutritionnel.

Mots clés : Suivi nutritionnel, grossesse, état nutritionnel, nouveau-nés, interventions

Audit documentaire de la qualité des demandes et des comptes rendus d'échographie thyroïdienne à Parakou (Bénin), 2023–2024.

Auteurs : AKANNI D.W.M.M.^{1,2}, DAMIEN B.G.^{3,4}, AGAÏ K.J-B.^{1,5}, ONIBON A.S.M.^{1,2}, ADJANAYO A-S.^{1,2}, SAVI de TOVE K-M.^{1,2}

1. Faculté de Médecine de Parakou, Université de Parakou (Bénin).

2. Service d'Imagerie Médicale du Centre Hospitalier Universitaire Départemental du Borgou (Bénin).

3. Centre de Formation et de Recherche en matière de Population, Université d'Abomey Calavi (Bénin).

4. Service de Santé Publique du Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phthisiologie de Cotonou (Bénin).

5. Service d'Imagerie Médicale de l'Hôpital des Instructions des Armées de Parakou - Centre Hospitalier Universitaire (Bénin).

Auteur correspondant : AKANNI Djivèdè Witchéko Maurice Mohamed ; djivakanni@yahoo.fr, 06 BP 3263 Cotonou Bénin. Téléphone : (00229) 0166249207

RESUME

Introduction : l'échographie thyroïdienne est l'examen de référence pour l'évaluation morphologique de la glande thyroïde. Cette étude visait à évaluer la qualité et la conformité des demandes et des comptes rendus d'échographie thyroïdienne au Centre Hospitalier Universitaire Départemental du Borgou (CHUD-B), à Parakou, Bénin.

Matériels et méthodes : une étude rétrospective, descriptive et analytique a été menée sur 24 mois (janvier 2023 – décembre 2024) dans le service d'imagerie médicale du CHUD-B. Une grille de 32 items, élaborée à partir des recommandations HAS-G4 et EU-TIRADS, a évalué quatre axes : demande, sémiologie, iconographie et conclusion. Les scores de conformité étaient classés en bonne ($\geq 80\%$), moyenne (60 – 79%) et insuffisante ($< 60\%$). L'analyse statistique a été réalisée avec Epi Info 7.2.5.0, test du χ^2 ($p < 0,05$).

Résultats : au total, 188 comptes rendus ont été analysés. La qualité globale était moyenne ($74,1\% \pm 5,7$). Les demandes présentaient une qualité moyenne ($66,5\% \pm 0,1$), mais étaient significativement meilleures lorsqu'elles émanaient des ORL ($p < 0,001$). La sémiologie était insuffisante ($55,9\% \pm 9,2$), avec des omissions systématiques d'éléments essentiels (appareillage, échogénicité, vascularisation). En revanche, l'iconographie ($98,9\% \pm 7,2$) et les conclusions ($90,4\% \pm 23,4$) affichaient une bonne conformité.

Conclusion : cet audit révèle des insuffisances persistantes dans la qualité des demandes et comptes rendus d'échographie thyroïdienne. La standardisation des formulaires, l'adaptation des référentiels et le renforcement de la concertation clinico-radiologique constituent des priorités pour améliorer la qualité des examens.

Mots-clés : échographie thyroïdienne, audit qualité, comptes rendus radiologiques, Parakou.

QUALITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES DANS LA GESTION DES VOIES AERIENNES EN ANESTHESIE AU CHUD/ BORGOU DE PARAKOU**Soussia T^{1*}, Issakou A², Degbey C³.**¹ Institut National Médico-Sanitaire² Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux³ Institut Régional de Santé Publique

(*) Auteur correspondant : E-mail : soussiatheodore@yahoo.fr Tél : +229 0197085289

RESUME

Introduction : L'infection nosocomiale constitue un phénomène préoccupant dans toutes les unités hospitalières par sa fréquence. Cette recherche vise à étudier la qualité des dispositifs médicaux réutilisables (DMR) dans la gestion des voies aériennes en anesthésie au CHUD-B en 2023.

Méthodes : L'étude était observationnelle incluant tout le personnel exerçant au bloc opératoire du CHUD/ Borgou depuis au moins six (6) mois et s'est déroulée dans un schéma d'enquête transversale descriptive et analytique. Elle a porté sur le matériel réutilisable en anesthésie. Les données collectées sur papier ont été saisies sur logiciel EPIDATA version 3.1 Fr. et l'analyse des données a été réalisée à l'aide du logiciel IBM SPSS Statistics 21.

Résultats : Au total 14 soignants ont été inclus. L'évaluation de la connaissance des soignants sur l'entretien des dispositifs médicaux réutilisables montre que 64,3% considèrent que les risques intermédiaires étaient liés au matériel semi critique. Selon leurs affirmations, 92,2% du personnel déclarait connaître les étapes de traitement du DMR. La décontamination suivie du nettoyage et du rinçage a été évoqué dans 84,6% des affirmations. L'observation de 50 cas d'interventions ayant nécessité une anesthésie a rapporté un petit bocal contenant un petit volume de solution de décontamination pour l'immersion du matériel ; l'absence de notion de renouvellement de la solution de décontamination ; l'inexistence de protocole de décontamination ; 25 cas de respect de l'hygiène des mains et 30 cas de port de gant.

Conclusion : Les pratiques observées au CHUD-Borgou ne sont pas en adéquations avec les normes et recommandations en matière de qualité de prestation de soin de santé sécurisé et mérites d'être améliorées.

Mots clés : Qualité – Gestion – Dispositif – Médical-Réutilisable

QUALITÉ DES CONSEILS DERMOCOSMÉTIQUES DANS LES OFFICINES ET ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS : RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE TRANSVERSALE MENÉE À COTONOU EN 2024Fabrice AKPADJAN¹⁻², Abel MEKOUNOUTCHI³, Hugues ADÉGBIDI¹⁻⁴.

1 Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, UAC, Bénin

2 Service de Dermatologie-Vénérologie, Centre de Dépistage et de Traitement de l'Ulcère de Buruli d'Allada (CDTUB_Allada), Bénin

3 UFR de Pharmacie, Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, UAC, Bénin

4 Service de Dermatologie-Vénérologie, Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou

Introduction

Le dermocosmétique regroupe des produits à la frontière entre santé et esthétique, conçus selon les normes de qualité et de contrôle applicables aux médicaments. La qualité des conseils associés à leur dispensation est un facteur essentiel d'efficacité et de sécurité. L'objectif de cette étude était d'apprécier la qualité des conseils dermocosmétiques délivrés dans les officines et établissements agréés de Cotonou en 2024.

Cadre et méthodes

Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive et analytique qui a été menée du 03 juin au 30 septembre 2024. L'échantillon était exhaustif et concernait le personnel impliqué dans la dispensation des produits dermocosmétiques au sein de 89 pharmacies et 33 établissements agréés de vente. Les données ont été recueillies au moyen d'un questionnaire standardisé et analysées par des méthodes statistiques descriptives et comparatives.

Résultats

Au total, 501 participants ont été inclus. L'âge moyen du personnel en officine était de $29,9 \pm 5,8$ ans contre $35,6 \pm 10,1$ ans dans les établissements agréés. Les femmes étaient prédominantes (sex-ratio = 0,2). En officine, les auxiliaires en pharmacie représentaient 72,5 % du personnel, avec une expérience professionnelle inférieure à 5 ans pour 45,8 %. Dans les établissements agréés, la majorité était constituée d'employés, dont une forte proportion comptait 5 à 10 ans d'expérience. Concernant la qualité des conseils, 46,7 % du personnel officinal et 33,3 % du personnel en établissements agréés avaient une connaissance jugée moyenne. Les pratiques observées étaient également de niveau moyen, rapportées par 56 % du personnel officinal et 62,3 % des employés des établissements agréés.

Conclusion

La qualité des conseils dermocosmétiques dispensés à Cotonou apparaît globalement moyenne, aussi bien en officine que dans les établissements agréés. Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer la formation continue et d'améliorer les pratiques de conseil afin d'optimiser la prise en charge dermocosmétique.

Mots clés : Conseils dermocosmétiques, officines, établissements agréés, Cotonou

Etude de l'impact psychologique des 1^{ères} premières expositions des étudiants en Sciences Infirmières et Obstétricales face à des scènes cliniques traumatisantes lors des stages hospitaliers : Cas des étudiants de l'INMeS en 2025

AHOSSI. E¹, ZANNOU M. B. L. A¹, AKOHA F²

1- Département des Sciences Infirmières, Institut National Médico-Sanitaire, Université d'Abomey-Calavi / Bénin

2- Département de pédagogie, Institut National Médico-Sanitaire, Université d'Abomey-Calavi / Bénin

Auteur correspondant : AHOSSI E E-mail : ahossi_eusebe@yahoo.fr Tel : 0164215291

RESUME

Introduction : Les premières immersions cliniques représentent une étape sensible dans la formation des étudiants en Sciences Infirmières et Obstétricales. À ce stade, certains sont confrontés à des scènes cliniques traumatisantes (SCT) susceptibles d'affecter leur bien-être psychologique. Cette étude s'inscrit dans une volonté d'explorer les effets de ces expositions précoces, à la lumière du modèle transactionnel du stress et du coping de Lazarus et Folkman (1984).

Objectif : Évaluer l'impact psychologique des premières confrontations des étudiants en première année à l'INMeS aux SCT vécues lors des stages hospitaliers, et proposer des pistes d'accompagnement et de prévention.

Méthodologie : Une approche mixte (quantitative et qualitative) de type transversale et descriptive a été réalisée auprès de 91 étudiants en première année. Les données ont été recueillies par questionnaire en ligne du 26 mai au 15 Juin 2025, puis analysées par traitement statistique descriptif et analyse thématique manuelle.

Résultats : L'étude révèle que 91,21 % des étudiants ont été exposés à au moins une scène clinique traumatisante, notamment des plaies suppurantes, des fractures ouvertes et des décès de patients. Les réactions émotionnelles les plus fréquentes sont le stress intense, les flashbacks, les vertiges, les sentiments de culpabilité et la perte de motivation. Malgré ces effets, 75,9 % des étudiants n'ont reçu aucun soutien institutionnel après ces expériences. La majorité a eu recours à des stratégies informelles, principalement l'échange entre pairs, avec une efficacité perçue comme partielle. L'analyse qualitative a mis en évidence un sentiment généralisé d'impuissance, un besoin non satisfait d'accompagnement psychologique, et une difficulté à verbaliser les émotions vécues, traduisant une détresse psychologique latente.

Conclusion : Ces résultats soulignent une forte vulnérabilité psychologique des étudiants dès leurs premiers contacts cliniques, renforcée par l'absence de préparation mentale et de soutien post-exposition, d'où l'urgence d'intégrer dans les curricula des dispositifs structurés de préparation, de simulation et d'accompagnement pour favoriser leur résilience et prévenir les effets néfastes à court et long terme.

Mots-clés : Scènes cliniques traumatisantes - étudiants en Sciences Infirmières et Obstétricales - stress - coping - stages hospitaliers - santé mentale.

RESUME

Introduction. La mortalité néonatale est réduite de 20% par une mise au sein précoce du nouveau-né dès la première heure de vie. Au Bénin, 97 % des enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête EDS 2017-2018 ont été allaités, 54 % ont été allaités dans l'heure qui a suivi la naissance.

Méthodologie : Menée de Janvier à Février 2025, cette étude transversale à visée descriptive et analytique a inclus le personnel soignant de la CUGO du CNHU-HKM de Cotonou et de la maternité de l'hôpital St Jean ayant donné leur consentement éclairé.

Résultats : Au total 54 agents de santé intervenants dans les services ont été sélectionnés.. Il en résulte que la grande majorité des répondants (83,33 %) avait plus de 10 ans d'expérience professionnelle et une bonne connaissance sur la mise au sein précoce. Les participants ont un niveau d'attitude « mauvais » (50%) et 62,96 % des répondants ont une perception moyenne de la mise au sein précoce. La majorité des participants (64,81 %) indiquaient que la mise au sein précoce n'était pas systématiquement encouragée dans leur service. Il n'y a pas de lien significatif entre la connaissance et l'attitude ($p = 0,66$). Une relation significative existe entre la connaissance et la perception ($p = 0,03$).

Conclusion : La majorité du personnel soignant avait un niveau de connaissance acceptable sur la mise au sein précoce. Leur faible implication dans la mise en œuvre reste un défi majeur.

Mots clés : Mise au sein précoce, Cotonou

ÉVALUATION D'UN SCORE D'IDENTIFICATION DES PATIENTS ATTEINTS DE TUBERCULOSE PRESENTANT UN RISQUE ELEVE DE DECES DANS TROIS CENTRES DE DEPISTAGE ET DE TRAITEMENT DANS LE SUD DU BENIN EN 2024.

Wachinou AP ^{1,2}, Assiongbon J ², Loko H ², Esse M ², Mefo P ², Segoun S ², Affolabi D ^{1,2}, Agodokpessi G ^{1,2}

Affiliations :

1. Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin

2. Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phtisiologie, Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : WACHINOUPrudence, email : wachinouprudence@yahoo.fr

RESUME

Introduction : La tuberculose (TB) reste un problème majeur de santé publique au Bénin. La mortalité demeure élevée, surtout chez les patients coinfecteds par le VIH et les personnes malnutries, malgré les efforts du PNT. Pour identifier précocement les patients à haut risque, le PNT a développé le score PARED. Cette étude visait à évaluer ses performances dans trois centres de diagnostic et de traitement du sud du Bénin.

Méthodes : Une étude transversale multicentrique a été menée de janvier 2023 à octobre 2024 auprès de 1135 patients TB âgés de 15 ans et plus. Le diagnostic suivait les critères du PNT. À l'admission, le score PARED a été calculé à partir de huit critères cliniques : altération de la conscience, incapacité à marcher sans aide, FR >30/min, SpO₂ <94 % et/ou FC >120 bpm, PAS <90 mmHg et/ou PAD <60 mmHg, atteinte pulmonaire bilatérale, sérologie VIH+, et anémie (clinique ou Hb <8 g/dL). Un score ≥3 indiquait un haut risque de décès. Les performances ont été évaluées (AUC, sensibilité, spécificité, VPP, VPN), complétées par une régression logistique multivariée et une analyse ROC.

Résultats : Parmi les 1135 patients, 56 décès (4,9 %) ont été enregistrés, principalement en phase intensive. La co-infection TB-VIH (13,7 %) et la dénutrition (IMC <18,5 kg/m² chez 53,6 % des décédés) étaient les comorbidités les plus fréquentes. Au seuil de 3, le score PARED présentait une AUC de 0,81, une sensibilité de 75,4 %, une spécificité de 71,4 %, une VPN de 98,1 %, mais une VPP faible (13,1 %). En multivarié, quatre facteurs restaient associés au décès : incapacité à marcher sans aide (ORa=2,87), FR >30/min (ORa=2,41), VIH+ (ORa=1,56) et anémie (ORa=2,21). Une version optimisée (nPARED) utilisant ces quatre facteurs a montré une AUC de 0,74, une sensibilité de 69,6 % et une spécificité de 78,7 %.

Conclusion : Le score PARED s'avère utile pour exclure un risque de décès chez les patients TB. Une version optimisée (nPARED) pourrait renforcer ses performances, mais nécessite une validation supplémentaire.

Mots-clés : Tuberculose, score PARED, risque de mortalité, TB-VIH, Bénin

CORRELATION TOMODENSITOMETRIE-HISTOLOGIE DANS LE DIAGNOSTIC DES LYMPHOMES DANS L'UNITE D'ONCOLOGIE PEDIATRIQUE DU CHUD-OP

Auteurs : ADJADOHOUN Sonia. B.M.G*, BOGNON G**, ZINZIDONHOU A*, AYI MEGNANGLO AUSTER*, WHENU S P U*, YEKPE A P*

*Unité d'Imagerie Médicale/ UFR Médecine /FSS/ Université d'Abomey Calavi/Bénin

** Unité d'oncologie pédiatrique /Service de pédiatre /CHUD-OP

Correspondant : mail : mahussi222@yahoo.fr; tel (00229) 0161154987

Résumé

Introduction : les lymphomes, 3^{ème} cancer pédiatrique sont certes rares, mais avec une mortalité élevée. La tomodensitométrie et l'histologie sont nécessaires pour une bonne prise en charge. Ce travail vise à évaluer l'apport de la tomodensitométrie dans le diagnostic des lymphomes ainsi que la corrélation histo-radiologique dans l'unité d'oncologie pédiatrique du CHUD-OP à Porto-Novo, au Bénin.

Méthodes : étude descriptive et analytique à collecte rétrospective menée de janvier à décembre 2024. Étaient inclus les enfants âgés de 0 à 18 ans suivis dans l'unité d'oncologie pédiatrique, disposant d'une tomodensitométrie et d'un résultat histopathologique. Les données clinico-épidémiologiques, les résultats tomodensitométriques et histopathologiques ont été analysés à l'aide du logiciel SPSS 20. Le test de Fisher a été utilisé pour évaluer les corrélations entre les résultats de la tomodensitométriques et histopathologiques.

Résultats : ont été colligés 139 patients, dont 69 (49,64 %) cas de lymphome confirmés. La tranche d'âge de 5 à 12 ans était la plus représentée (53,62 %), avec une prédominance masculine (sex ratio : 1,2). Les signes cliniques les plus fréquents étaient l'adénopathie (38 %) et les masses (30 %). A la tomodensitométrie, la localisation sus diaphragmatique était en tête de file 67 (97,10%) avec une prédominance des topographies cervico-médiastinales 58(84,06%). L'histologie a confirmé le lymphome dans 94,21 % des cas, avec une prédominance du lymphome non hodgkinien (65,22 %). Une corrélation était notée entre la suspicion à la tomodensitométrie et la confirmation histopathologique ($p=0,01$) d'une part, et entre le type histologique suspecté à la tomodensitométrie et celui retrouvé par l'histologie ($p=0,00$) d'autre part.

Conclusion : la tomodensitométrie est un outil diagnostique essentiel pour les lymphomes pédiatriques au CHUD-OP, avec une bonne corrélation histopathologique. Cependant son usage doit respecter les règles de radioprotection en pédiatrie.

Mots-clés : Lymphome, tomodensitométrie, histologie, pédiatrie, Bénin

Marche rapide et qualité de vie des patients épileptiques suivis au CHUD Borgou Alibori en 2023

Toviwanou DR^{1, 2}, Agbetou M¹, Kossi O¹, Houeze R², Adoukonou T¹

¹Service de Neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Départemental Borgou/Alibori

²Clinique Universitaire de Neurologie du CNHU HKM de Cotonou

Dr Toviwanou Dègnon Romain, tdegnonromain@gmail.com, +2290167605287

RESUME

Introduction : L'épilepsie est une maladie neurologique dont la prise en charge fait intervenir plusieurs moyens bien médicamenteux que physiques. Dans notre contexte d'accessibilité limitée aux molécules et de conception de l'épilepsie comme barrière à la pratique de l'exercice physique, les moyens complémentaires comme l'exercice physique mérite d'être explorés.

Objectif : Étudier l'impact de l'activité physique régulière sur la qualité de vie des patients souffrant d'épilepsie au CHUD B/A en 2023.

Méthode : il s'agissait d'une étude quasi-expérimentale type avant après, interventionnelle, monocentrique dont la collecte des données s'est déroulée au CHUD B/A sur six mois soit du 04 Mai au 04 Novembre 2023. Les échelles IPAQ (*International Physical Activity Questionnaire*) et QOLIE 31 (*Quality of life in Epilepsy- 31 inventory*), ont été utilisés respectivement pour apprécier le niveau d'activité physique et la qualité de vie à J0, J14, M1 et M3 des patients épileptiques soumis à un programme d'activité physique régulière type marche rapide sur trois mois et suivis grâce à l'accéléromètre *Armband Bodymedia Fit*.

Résultats : Au total, 31 patients ont été inclus sur les 103 recensés. L'âge moyen était de $31,51 \pm 11,52$ ans. Plus de 4/5 soit 87% des patients épileptiques avaient un niveau d'activité faible. Le programme d'activité physique régulière a permis de relever le niveau d'activité physique faible des patients épileptiques à un niveau d'activité physique modérée soit chez 97% des patients. La mauvaise qualité de vie retrouvée chez les patients épileptiques est passée de 80,65% à 16,13% en fin d'intervention avec une forte association avec l'élévation du niveau d'activité physique ($p\text{-value} < 0,05$). Le score moyen de QOLIE31 avant l'intervention est de 50.87 contre 66.68 en fin d'intervention, soit une très large amélioration de la qualité de vie avec $p\text{-value} < 0,0001$ et d de Cohen à 1,97 IC [1,26 ; 2,68].

Conclusion : L'activité physique modérée influence positivement la qualité de vie des patients épileptiques

Mots-clés : Marche rapide - Qualité de vie - Épilepsie - Bénin

FACTEURS ASSOCIÉS À LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS LUPIQUE AU SUD DU BENIN

Dansou E¹ ; Faton A¹ ; Otti Dot¹ ; Assogba Hm¹ ; Fallade Aag¹ ; Houeze R¹ ; Wanvoegbe A² ; Agbodande Ka¹ ; Azon Kouanou A¹

¹ Centre National Hospitalier Universitaire – Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou

² Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémé-Plateau (CHUD-OP), Porto-Novo

Auteur correspondant : **DANSOU Eugénie**. Mail : eugeniedansou1@gmail.com

Numéro téléphone : (00229) 0197648663

RESUME

Introduction

Le lupus érythémateux systémique (LES), maladie inflammatoire et chronique reste l'une des maladies qui donne « du fil à retordre » aux personnes atteintes et donc peut facilement perturber leur qualité de vie

Objectifs : évaluer les facteurs associés à la qualité de vie (QDV) des patients lupiques en prenant en compte les dimensions physiques et psychologiques, et explorer le lien entre les caractéristiques sociodémographiques, les manifestations cliniques et la QDV globale.

Méthodologie : une étude transversale incluant des patients atteints de maladies chroniques. Elle s'était déroulée sur la période du 02 Juin au 06 Août 2023. La population source était celle des patients lupiques suivis dans les services centres hospitaliers du sud du Bénin, notamment dans les services de Médecine Interne, de Rhumatologie et de Dermatologie-vénérologie du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert KOUTOUKOU MAGA (CNHU-HKM) de Cotonou puis dans le service de Médecine et spécialités médicales du Centre Hospitalier Universitaire Départemental Ouémé Plateau (CHUD-OP) de Porto-Novo. Les données ont été recueillies par questionnaire et analysées à l'aide de tests statistiques univariés et multivariés.

Résultats : des manifestations générales, des activités de maladie élevées et un revenu inférieur à 52 000 FCFA ont significativement influencé la QDV. La fatigue était plus prévalente chez les patients présentant des manifestations générales. Aucune corrélation significative n'a été trouvée entre l'âge ou la durée d'évolution de la maladie et les domaines de la QDV.

Conclusion : La qualité de vie reste préoccupante chez ces patients. Une prise en charge centrée sur le patient permettra d'améliorer leur QDV et devraient cibler les patients avec un haut niveau d'activité de la maladie et des manifestations générales.

Mots-clés : qualité de vie, lupus érythémateux systémiques, prise en charge centrée sur patient

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET ACADÉMIQUES DES INFIRMIERS DEMANDEURS D'AUTORISATION D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DE CABINETS DE SOINS DE SANTÉ PRIVÉS AU BÉNIN

*OTTI A.^{1,2} ; DOSSOU A. J. E.^{2,3} ; DJOSSOU D. B. J.^{1,2} ; AGBÉTÉ I.^{1,2} ; KOUTCHONAN D.^{2,4} ; ALLADAYE L.^{2,5} ; BATCHO V. R.^{2,5} ; AKPOVO S. A.⁵ ; SALIFOU S.⁵ ; SOSSA Jérôme C.⁶

¹ Département des Sciences Infirmières, Institut National Médico-Sanitaire (INMeS), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

² Société Béninoise des Sciences Infirmières (SOBESI), Bénin

³ Département des Sciences Obstétricales, Institut National Médico-Sanitaire (INMeS), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin

⁴ Centre de santé d'AÏDJÈDO, Direction Départementale de la Santé du Littoral, Ministère de la Santé, Bénin

⁵ Direction Nationale de la Santé Publique (DNPS), Ministère de la Santé, Bénin

⁶ Institut Régional de Santé Publique (IRSP) Comlan Alfred QUENUM, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin.

*Auteur correspondant : Dr OTTI André, Infirmier, PhD. Maître-Assistant CAMES.

Courriel : drandreotti74@gmail.com GSM : +229 0164068282 ou 0161989888

RESUME

Introduction : Pour préserver la qualité des soins, des réformes ont été amorcées en santé au Bénin en 2016 dont la réorganisation de l'exercice en clientèle privée de la profession infirmière. **Objectif** : Décrire les caractéristiques socio-démographiques et académiques des Infirmiers demandeurs d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de Cabinets de Soins de Santé Privés (CSSP). **Méthode** : Un devis descriptif quantitatif a permis de dépouiller les dossiers de demandes d'ouverture et d'exploitation de CSSP, déposés entre 2021-2024 et sélectionnés par échantillonnage probabiliste de type exhaustif. Des relations linéaires entre variables (si $-1 \leq r \leq 1$) ont été identifiées grâce au test de corrélation de Pearson avec le logiciel d'analyse statistique Stata/IC 16.0. **Résultats** : 306 dossiers de requérants, tous de nationalité béninoise, ont été enregistrés (sexe masculin : 72,55 %). Leur âge moyen était de 38 ans et 31 requérants (10,13%) étaient âgés de 60 ans et plus. Les sites d'installation sollicités couvrent tout le territoire Béninois dont plus de la moitié (53,92%) dans les quatre départements du nord (Alibori, Atacora, Borgou et Donga). Les diplômes d'infirmier présentés étaient obtenus de 1974 à 2024 dont 76,47% entre 2017 et 2022. 68,63% de ces diplômes ont été obtenus à l'étranger et plus de la moitié (55,23%) au Burkina-Faso. Par ailleurs, 69,60% des diplômes présentés étaient le Diplôme d'État d'Infirmier ou équivalent dont 73,70% délivrés au Burkina-Faso. **L'autorisation a été accordée à 87,11% des requérants.** Une corrélation négative modérée a été notée entre l'âge de l'enquêté et le type de diplôme d'infirmier présenté ($r = -0,3729$) et ; une corrélation négative faible : entre l'âge de l'enquêté et le pays d'obtention du diplôme d'infirmier présenté ($r = -0,2308$) et, le type de diplôme d'infirmier présenté et le département d'installation du CSSP sollicité ($r = -0,1129$). **Discussion et conclusion** : Les requérants en âge de la retraite au Bénin, suscitent la problématique de parrainage dont les contours juridiques méritent d'être élucidés. La répartition inégale des sites d'installation demande l'élaboration d'une carte sanitaire privée dans l'objectif de la Couverture Sanitaire Universelle. La prédominance des diplômes étrangers implique l'évaluation des compétences de leurs titulaires.

Mots-clés : Infirmiers ; Cabinets de soins infirmiers privés; Autorisation d'ouverture et d'exploitation ; caractéristiques socio-démographiques et académiques; Bénin.

Impact of vaccination on the risk of anaemia in hospitalized subjects with Severe Acute Respiratory Infection (SARI)

PADONOU Sètonджи Géraud Roméo ^{1*}, AGUEMON Badirou ¹

¹ : Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

***Corresponding author :**

Sètonджи Géraud Roméo PADONOU.

Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN. geraud.padonou@gmail.com geraudpad@yahoo.fr Tél : 00229 0166 64 75 75.

RESUME

Introduction: Vaccination against COVID-19 is an effective way to combat this disease, especially in people at risk. The objectives of this study were to investigate the impact of vaccination on the risk of anaemia in patients with Severe Acute Respiratory Infection (SARI).

Methods: A prospective case-control study including 612 patients with SARI was conducted over a six-month period in 2023 in four hospitals in Benin. The diagnosis of SARS-CoV-2 infection was confirmed by PCR testing. Sociodemographic, clinical, and environmental data, medical history, COVID-19 history, vaccination status, and vaccine-related information were collected. A logistic regression model was performed.

Results: Of the 612 patients, 120 were vaccinated against Covid-19, representing 19.60%. Mean age (SD) was 57.12 (6.36) years; the majority were female, with 61.44%; 38.72% had a secondary education; and 50.01% lived in urban areas. 50.98% had comorbidities and 40.03% had anaemia. Vaccinated status reduced the risk of developing anaemia (OR=0.68 [0.39-0.91]; conversely, age (OR=1.39 [1.12-2.01]) and the presence of comorbidities (OR=2.10 [1.41-3.27]) were associated with a higher risk of anaemia.

Conclusion: This study highlighted a positive effect of vaccination on the risk of developing anaemia, highlighting that the vaccination strategy was a good intervention in the fight against COVID-19, especially in patients with severe cases.

Key-words: COVID-19 – SARI – Anaemia – Vaccination

EVALUATION OF THE DURATION OF OXYGEN THERAPY IN VACCINATED AND UNVACCINATED SUBJECTS AGAINST COVID-19 SUFFERING FROM SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION (SARI)

PADONOU Sètonджи Géraud Roméo ^{1}, AGUEMON Badirou ¹*

¹ : Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

***Corresponding author :**

Sètonджи Géraud Roméo PADONOU.

Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN. geraud.padonou@gmail.com geraudpad@yahoo.fr Tél : 00229 0166 64 75 75.

RESUME

Introduction: In Benin, on a large scale, COVID-19 vaccines were introduced to ensure protection of the population, especially against severe forms. The objective of this study was to investigate the effect of vaccination on the duration of oxygen therapy in subjects with severe acute respiratory infection (SARI).

Methods: Sociodemographic, clinical, and environmental data, medical history, COVID-19 history, vaccination status, and vaccine-related information were collected from 612 subjects with SARI during a prospective case-control study conducted in 2023 in four hospitals in Benin. The diagnosis of SARS-CoV-2 infection was confirmed by PCR testing. A linear regression model was performed.

Results: Vaccination coverage was 19.60%, representing 120 subjects. Mean age (SD) was 57.12 (6.36) years; the majority were female, with 61.44%; 38.72% had a secondary education; 50.01% lived in an urban area; and 50.98% had comorbidities. Mean duration of oxygen therapy was 18.95 days (6.51). Vaccinated status reduced duration of oxygen therapy (coefficient = -2.84; $p = 0.007$). Conversely, age (coefficient = 3.01; $p < 10^{-3}$) and the presence of comorbidities (coefficient = 1.96; $p = 0.004$) were associated with an increased duration of oxygen therapy.

Conclusion: This study showed that being vaccinated reduced duration of oxygen therapy. Vaccination was a good intervention in the fight against COVID-19, especially in patients with severe disease.

Key-words: Covid-19 – SARI – Duration of oxygen therapy – Vaccination.

DETERMINANTS DU DECES MATERNEL INTRAHOSPITALIER PAR COMPLICATIONS OBSTETRIQUES DANS LE DEPARTEMENT DE L'ATLANTIQUE AU BENIN DE 2019 A 2022.

Tchimon Vodouhè^{1,2}, Moufalilou Aboubakar^{2,3}, Ingrid Olowo^{2,4}, Barnard Acakpo^{1,2}, Christiane Tshabu Aguèmon^{1,2}, Angeline Tonato Bagnan^{2,3}, Justin Lewis Dénakpo¹.

Affiliations

1 Clinique Universitaire de Gynécologie et d'Obstétrique (CUGO) du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, Bénin

2 Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

3 Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et l'Enfant Lagune (CHU-MEL) de Cotonou, Bénin

4 Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémé-Plateau (CHUD-OP), Bénin

Introduction : Le défi de réduction du ratio de mortalité maternelle (RMM) reste entier pour les pays de l'Afrique subsaharienne dont le Bénin. Le rythme de décroissance du RMM y est trop faible pour l'atteinte de l'ODD3, à moins de renforcer les interventions dans le domaine de la santé maternelle à tous les niveaux de pyramide sanitaire, ce qui passe par la compréhension du contexte local dans lequel surviennent les décès. C'est ce qui justifie cette étude dont l'objectif était d'identifier les déterminants du décès maternel intrahospitalier dans le département de l'Atlantique.

Méthodes : Deux hôpitaux du département de l'Atlantique ont constitué le cadre de cette étude : le Centre Hospitalier Universitaire de Zone d'Abomey-Calavi/Sô-Ava et l'Hôpital de zone d'Allada. Elle était de type cas-témoins analytique avec collecte rétrospective des données, de 2019 à 2022. Les cas étaient les décès maternels intrahospitaliers, les témoins étant les gestantes et accouchées traitées pour une complication obstétricale (trois témoins pour un cas). Une analyse multivariée par régression logistique a été effectuée pour la recherche d'association entre les variables indépendantes et le décès maternel. La mesure d'association était l'Odds Ratio, présenté avec son intervalle de confiance à 95%. Le seuil de significativité était de 5%. La validité du modèle final a été appréciée à l'aide du test de Hosmer-Lemeshow.

Résultats : Le RMM était de 386 décès pour 100.000 NV. L'âge moyen des cas était $28,67 \pm 6,54$ ans et celui des témoins $26,46 \pm 6,60$ ans. La grossesse était mal suivie (88,04% versus 79,71%). La plupart étaient référées (77,20% versus 76,10%). Les déterminants du décès maternel étaient : la surveillance inadéquate ($p < 0,001$, ORa=35,33), la survenue de complication maternelle ($p < 0,001$, ORa=28,45), le traitement inadéquat ($p < 0,001$, ORa=18,04), le troisième retard ($p < 0,001$, ORa=13,69), les antécédents médicaux ($p = 0,030$, ORa=6,55), l'indication de transfusion sanguine ($p < 0,001$, ORa=6,30), l'existence de pathologie au cours de la grossesse ($p = 0,049$, ORa=2,80).

Conclusion : Les interventions pour la réduction du RMM devront cibler la qualité de la prise en charge holistique des patientes : suivi de grossesse, qualité du traitement et de surveillance, suppression du troisième retard, couverture des besoins transfusionnels.

Mots clés : Ratio de mortalité maternelle, décès maternel intrahospitalier, déterminant, département de l'Atlantique, Bénin.

RESULTATS DU TRAITEMENT DES FRACTURES MALLEOLAIRES AU CNHU-HKM DE COTONOU

Auteurs : Chigblo P, Sagbohan P, Zanfouhouede E, Hans-Moévi Akué A

RESUME

Introduction : Les fractures malléolaires sont des fractures qui désorganisent la pince malléolaire et menacent la stabilité de la cheville. L'objectif de ce travail était d'évaluer les résultats du traitement des fractures malléolaires dans le service Traumatologie-Orthopédie du CNHU-HKM.

Patients et Méthode : Cette étude rétrospective analytique, menée de janvier 2013 à décembre 2022, a inclus 59 cas de fractures malléolaires sur 186 patients. Les patients, âgés en moyenne de 48 ans, étaient majoritairement des hommes (36). Les accidents de circulation, surtout impliquant des motocyclistes (83 %), représentaient la principale cause. Les fractures étaient principalement bimalléolaires (57,6 %), suivies des fractures uni-malléolaires et tri-malléolaires. La malléole latérale présentait surtout des fractures de type II selon Weber (40 %) et de type A2 selon AO (47,5 %). La majorité des cas étaient des lésions fermées (28). Le traitement chirurgical prédominait (93,23 %), utilisant des plaques vissées (54,7 %) ou l'embrochage. Pour la malléole médiale, le vissage (63,8 %) était le plus utilisé.

Résultats : Les résultats fonctionnels évalués par le score de Kitaoka ont révélé 21 cas excellents (35,6 %) et 20 cas bons (33,9 %), soit un total positif de 69,5 %. Selon les critères de Nordin, 45,8 % des patients ont obtenu un résultat « bon » et 39 % un résultat « très bon ». La qualité de réduction, appréciée via le score de Lecestre et Ramadier, était jugée bonne dans 67,8 % des cas. Une corrélation statistiquement significative ($p = 0,018$) a été observée entre le type d'ostéosynthèse de la malléole latérale et la qualité de réduction : 62,2 % de bons résultats ont été obtenus avec une plaque vissée. La nécrose cutanée secondaire représentait la complication précoce la plus fréquente, tandis que le cal vicieux prédominait à distance.

Conclusion : Les fractures malléolaires, fréquentes après un traumatisme routier, affectent gravement la cheville ; la chirurgie offre d'excellents résultats.

Mots clés : Malléole, Fracture, Traitement

EVALUATION DE LA TOXICITE DES ANTICANCEREUX CHEZ LES ENFANTS DANS DEUX HOPITAUX UNIVERSITAIRES AU SUD DU BENIN

LADJOUAN M C A^{1,2}, BOGNON G^{1,2}, HOUSSOU B⁴, MASSI R³, HOUNTONDJI A^{1,2}

- 1- Unité d'Oncologie Pédiatrique (UOP) Centre Hospitalo-Universitaire (CHUDOP), Porto-Novo, Bénin
- 2- Groupe Franco-Africain d'Oncologie Pédiatrique (GFAOP), Villejuif, France
- 3- Unité d'Hématologie du Centre Hospitalo-Universitaire (CHUDOP), Porto-Novo, Bénin
- 4- Clinique Universitaire des Maladies du Sang (CNHU-HKM), Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : LADJOUAN C, 01BP 1884 Cotonou, tél. +229 0197887501, lakanho@yahoo.fr

RESUME

Introduction : la toxicité liée à la chimiothérapie est fréquente en oncologie pédiatrique et peut affecter plusieurs organes. L'objectif de ce travail était d'étudier la toxicité liée à la chimiothérapie chez les enfants pris en charge pour cancer dans deux hôpitaux universitaires au sud du Bénin en 2024.

Méthodes : il s'agissait d'une étude prospective, descriptive et analytique menée du 8 février au 30 juillet 2024. Elle avait inclus tous les enfants âgés de 0 à 18 ans suivis pour cancer à l'Unité d'Oncologie pédiatrique du CHUD-OP, membre du réseau GFAOP et à la Clinique Universitaire des Maladies du Sang du CNHU-HKM et ayant reçu au moins une cure de chimiothérapie. Le seuil de significativité était de 5%.

Résultats : la prévalence hospitalière de la toxicité était de 89,1%. Le sex ratio était de 1,56 ; la tranche d'âge la plus représentée était celle de 5-12ans (n=28 ; 43,8%). Chaque enfant avait reçu en moyenne 2,3 cures. Les principales toxicités étaient hématologiques 46,2%, cutanées 26,2% et digestives 18,9%. On notait une régression totale des toxicités digestives, neurologiques, hépatiques et une régression partielle des toxicités hématologiques, rénales et cutanées. La létalité était de 14,1%. Le jeune âge, le type de cancer et le protocole étaient liées à la survenue de la toxicité cutanée.

Conclusion : la toxicité liée à la chimiothérapie est fréquente en oncologie pédiatrique et greffée d'une lourde mortalité. Il est important que leur prévention soit rigoureuse par l'application des protocoles de surveillance et d'adaptation de dose mais surtout d'éducation thérapeutique des patients

Mots clés : toxicité, chimiothérapie, enfant

ACCESSIBILITE DES SERVICES DE PRISE EN CHARGE DU GLAUCOME PRIMITIF A ANGLE OUVERT A COTONOU

ABOUKI COA, ADJIBI J, TODOME F, ADEROMOU NA, AIGBE N, ALAMOU S, ODOULAMI L
Faculté des Sciences de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi (FSS-UAC)

RESUME

Introduction : les auteurs ont étudié l'accessibilité des services de prise en charge du glaucome primitif à angle ouvert à Cotonou.

Méthode : il s'agissait d'une étude transversale à collecte prospective, à visée descriptive et analytique allant du 28 août au 28 octobre 2023 soit deux mois. La population d'étude était composée des patients glaucomateux suivis dans le service d'ophtalmologie du Centre National Hospitalier Universitaire- Hubert Koutoukou MAGA (CNHU-HKM) et des acteurs du système de santé du public intervenant dans la prise en charge à Cotonou.

Résultats : nous avons inclus 145 patients et 38 acteurs du système de santé. L'âge moyen était de $62,37 \pm 9,64$ ans. Une prédominance masculine était observée à 55,17%. Le coût global annuel moyen de la prise en charge du glaucome était de 276834,48 FCFA $\pm$ 130082,98 et le coût global annuel du transport était de 4673,79 FCFA $\pm$ 34958,60. Environ 64,14% des patients ont recours à un paiement partiel pour leur prise en charge. Les services de prise en charge étaient situés à plus de 10 km de 98,6% des patients et 58,94% des patients ne disposaient pas d'un moyen de déplacement personnel. La majorité des acteurs de santé soit 63,16% affirmaient que le Bénin ne disposait pas d'un plan national de lutte contre le glaucome. Les facteurs associés à l'accessibilité étaient l'âge, le genre, la profession et la prise en charge financière pour les patients.

Conclusion : les services de prise en charge du glaucome primitif à angle ouvert demeurent encore peu accessibles aux patients à Cotonou.

Mots clés : accessibilité, prise en charge, glaucome primitif à angle ouvert, Cotonou.

PROFILS DE LITTÉRATIE EN SANTE DES PATIENTS EN SOINS PALLIATIFS D'UN HOPITAL UNIVERSITAIRE DU BENIN ET FACTEURS ASSOCIES

*Otti André^{1,2,3}, Dossou Afiavi Julienne Estelle^{2,3,4}, Adomou Harmonie Grâce de Dieu Cica^{1,2,3}, Koutchonan Daniel^{2,5}, Hadékon Rodrigue^{2,6}, Misengabu Mamie⁷, Baba-Moussa Lamine⁸, Sossa Jérôme Charles⁹

1. Département des Sciences Infirmières, Institut National Médico-Sanitaire (INMeS), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin
2. Société Béninoise des Sciences Infirmières (SOBESI), Bénin
3. Laboratoire de Recherche en Sciences Infirmières et Obstétricales (LARSIO)/INMeS/UAC/Bénin
4. Département des Sciences Obstétricales, Institut National Médico-Sanitaire (INMeS), Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin
5. Centre de santé d'AïDJÈDO, Direction Départementale de la Santé du Littoral, Ministère de la Santé, Bénin
6. Département des Sciences Infirmières, Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO), Université de Parakou (UP), Bénin
7. Organisation Non gouvernementale [ONG] « Soins Palliatifs à Domicile [SPD] », Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC)
8. Laboratoire de Biologie et de Typage Moléculaire en Microbiologie, Faculté des Sciences et Techniques, Université d'Abomey-Calavi, Bénin
9. Institut Régional de Santé Publique (IRSP) Comlan Alfred QUENUM, Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin.

*Auteur correspondant : Dr Otti André, Infirmier, PhD. Maitre-Assistant CAMES.
Courriel : otti.andre74@yahoo.com GSM : +229 0164068282 ou 0161989888

Introduction : Un faible niveau de Littératie en Santé (LS), surtout en contexte palliatif, a des conséquences négatives sur la santé des patients, notamment un suivi médical erratique et leur faible implication dans les prises de décisions thérapeutiques. **Objectif** : Analyser les profils de LS des patients suivis en Soins Palliatifs au CNHU-HKM au Bénin. **Méthodes** : Un devis descriptif mixte à visée analytique a été adopté. La théorie de Nutbeam proposant trois dimensions de LS (fonctionnelle; interactive; critique) a servi de cadre de référence. Le questionnaire standard d'évaluation de la LS, le FCCHL/HLS-14, a été utilisé auprès des enquêtés, sélectionnés par échantillonnage non probabiliste de type accidentel. Un score moyen (SM) de LS a été calculé par la somme des scores attribués à chaque item, divisée par le nombre d'items. Un $SM \leq 4$ correspondait à un faible niveau de LS. Les test *t* de student et de Welch effectués à l'aide du logiciel d'analyse statistique IBM SPSS Statistics, version 25.0., ont permis d'analyser l'influence de certaines variables sociodémographiques sur la LS ($p < 0,05$), renforcés par une analyse de contenu thématique des discours des enquêtés selon l'approche de Braun & Clarke afin d'enrichir la lecture des résultats. **Résultats** : 25 patients palliatifs ont été inclus dans l'étude (âge moyen : 55 ans) dont 76% ont un faible niveau de LS ($SM \text{ total} \leq 4$). Les plus bas SM ont été observés au niveau de la LS fonctionnelle ($1,83 \pm 1,5$) et celle critique ($1,94 \pm 1,61$). L'âge, le niveau d'instruction et la langue de communication, influencent significativement la LS des enquêtés ($p < 0,05$).

Discussion et conclusion : La vulnérabilité informationnelle et la capacité limitée des enquêtés à évaluer, filtrer ou remettre en question, les informations de santé, demandent des stratégies d'adaptation linguistique des supports de communication et d'éducation thérapeutique. **Mots-clés** : Littératie en santé, Soins palliatifs ; CNHU-HKM ; Bénin

COVID-19 vaccination and thromboembolic disorders risk in subjects hospitalized for Severe Acute Respiratory Infection (SARI)

PADONOU Sètonji Géraud Roméo ^{1*}, AGUEMON Badirou ¹

¹ : Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN.

*Corresponding author :

Sètonji Géraud Roméo PADONOU.

Département de Santé Publique. Faculté des Sciences de la Santé. Université d'Abomey-Calavi. 01 BP 188 Cotonou, République du BENIN. geraud.padonou@gmail.com ; geraudpad@yahoo.fr ; Tél : 00229 0166 64 75 75.

Introduction: During COVID-19, a vaccination campaign was carried out in Benin, particularly in patients with severe forms of COVID-19. This study aimed to investigate the impact of vaccination on the risk of thromboembolic disorders risk in these patients.

Methods: 612 patients with Severe Acute Respiratory Infection (SARI) were included during a prospective case-control study over a six-month period in 2023 in four hospitals in Benin. Sociodemographic, clinical, and environmental data, medical history, COVID-19 history, vaccination status, and vaccine-related information were noted. The diagnosis of SARS-CoV-2 infection was confirmed by PCR testing. A logistic regression model was performed.

Results: A total of 120 patients was vaccinated representing a vaccination coverage of 19.60%. Mean age (SD) was 57.12 (6.36) years; the majority were female, with 61.44%; 38.72% had a secondary education; and 50.01% lived in urban areas. 50.98% had comorbidities. Thromboembolic disorders were present in 274 patients (44.77%). Being vaccinated reduced the risk of developing thromboembolic disorders (OR=0.45 [0.31-0.88]; conversely, age (OR=3.46 [1.47-4.75]) and the presence of comorbidities (OR=2.77 [1.23-5.84]) were associated with a higher risk of thromboembolic disorders. No relationship was found with patient's gender (OR=0.77 [0.68-1.35]).

Conclusion: This study showed a positive effect of vaccination on the risk of having thromboembolic disorders among patients with SARI, highlighting that the vaccination strategy was a good intervention in the fight against COVID-19, especially in patients with severe cases.

Key-words: COVID-19 – SARI – Thromboembolic disorders – Vaccination

HEMORRAGIES DU POST-PARTUM IMMEDIAT : PREVALENCE, CAUSE ET PRISE EN CHARGE A LA MATERNITE DE L'HOPITAL DE ZONE DE SAVE DE JANVIER 2024 A MARS 2025

DOSSOU Afiavi Julienne Estelle¹, GBAGUIDI Florette², OKELEYE Falilath³, SOGNONVI VISSOH Antoinette⁴, TSHABU-AGUEMON Christiane⁵

1. **Auteure correspondante** : DOSSOU Afiavi Julienne Estelle, Sage-femme, PhD **Courriel** : esteldossou@yahoo.fr , Téléphone : 0196262317

Résumé

Introduction : L'hémorragie du post-partum immédiat (HPPI) demeure l'une des principales causes de décès maternel dans les pays en voie de développement. L'HPPI est définie comme étant une perte sanguine de plus de 500 ml dans les 24 heures suivant l'accouchement, est souvent aggravée par des retards dans la reconnaissance, la prise en charge et l'orientation des patientes. Au Bénin, malgré les stratégies nationales de réduction de la mortalité maternelle, des cas de décès évitables dus à l'HPPI persistent, notamment dans les maternités rurales.

Objectif : Cette étude vise à analyser la prévalence des HPPI, identifier les facteurs associés et évaluer la prise en charge dans un contexte spécifique. **Méthodes** : Il s'est agi d'une étude retro-prospective a visé descriptive menée sur une période de 15 mois. Elle a concerné 30 femmes ayant présenté une HPPI. Les données ont été recueillies à partir des dossiers médicaux et analysées de manière descriptive. **Résultats** : L'étude a révélé une fréquence élevée des HPPI. La fréquence des HPPI est bien définie avec des variations par âge, parité et autres caractéristiques démographiques. L'atonie utérine est identifiée comme la cause principale des HPP, suivie des déchirures de la filière génitale et de la rétention placentaire. La prise en charge reposait essentiellement sur l'administration d'utérotoniques, le massage utérin, le tamponnement intra-utérin par ballonnet et, dans les cas graves, la transfusion sanguine ou l'hystérectomie. **Conclusion** : Les HPPI constituent une urgence obstétricale et ~~toujours~~ un enjeu majeur de santé maternelle. Elles demeurent l'une des causes de mortalité maternelles survenant dans les 24 heures suivant l'accouchement et nécessitant une prise en charge rapide et efficace. Le renforcement des compétences du personnel soignant, la disponibilité des ressources d'urgence et la gestion active de la délivrance sont essentiels pour réduire les complications et les décès liés à cette hémorragie.

Mots clés : HPPI ; prévalence, facteurs associés ; mortalité maternelle, HZ Savè.

TROUBLES RESPIRATOIRES DU SOMMEIL SELON L'IAH CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISES POUR INSUFFISANCE CARDIAQUE AU CNHU-HKM DE COTONOU : FREQUENCE ET FACTEURS ASSOCIES

SONOU DJA¹, WACHINOU P², AHOYO ADJOVI M¹, CHITOU-SANNI S¹, DOHOU SHM³, BADAROU I¹, BOUEKE B¹, AKSANTI L¹, BOLARINWA M¹, TEWO K¹, BOKODAHOMD¹, DOSSOU D¹, FADONUGBO X¹, AGBALIKA P¹, SOUMMONNI F, HOUNKPONOU M¹, CODJO HL³

Affiliations :

¹Clinique Universitaire de Cardiologie (CUC), CNHU/HKM de Cotonou, Unité d'Enseignement et de Recherche de Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

²Centre National Hospitalier Universitaire de Pneumo-Phtisiologie, Unité d'enseignement et de recherche en pneumologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC) Cotonou, Bénin

³Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC), Unité d'Enseignement et de Recherche de Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : BOKODAHOM. David, dbokodaho@gmail.com

Introduction : L'objectif de l'étude était d'évaluer la fréquence et les facteurs associés aux troubles respiratoires du sommeil (TRS) chez les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque à la Clinique Universitaire de Cardiologie du CNHU-HKM de Cotonou.

Méthode et patients : Il s'agit d'une étude transversale analytique avec une collecte de données prospective, menée sur une période de 7 mois. L'étude a inclus par enrôlement exhaustif tous les patients âgés de plus de 18 ans, des deux sexes, hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Les variables étudiées étaient la présence ou l'absence d'un TRS et les facteurs qui lui sont associés. Un TRS était défini par un indice d'apnée-hypopnée (IAH) supérieur ou égal à 5.

Résultats : Cinquante patients ont été inclus. L'âge moyen était de $59,26 \pm 16,0$ ans et le sex-ratio (homme/femme) de 1,5. La fréquence hospitalière des TRS était de 76 % (38 cas), dont 44 % étaient des formes modérées à sévères. Les facteurs associés identifiés étaient l'obésité abdominale ($p = 0,019$) et une mauvaise qualité de sommeil, mesurée par un score à l'échelle de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index) supérieur ou égal à 5 ($p = 0,03$).

Conclusion : Les TRS semblent être fréquents chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. D'autres facteurs associés restent à identifier dans des études sur un échantillon plus large et représentatif.

Mots-clés : IAH, troubles respiratoires du sommeil, insuffisance cardiaque, Cotonou.

LOMBALGIE CHRONIQUE MECANIQUE : PERCEPTIONS DE LA DOULEUR ET IMPACTS SUR LA VIE SEXUELLE, SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PATIENTS CONSULTANT AU SERVICE DE RHUMATOLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2024

Auteurs: DJOSSOU Hontongnon Julien, DJAHO Déo Gratias, LENOUMI Gilchrist, DOSSOU-YOVO Hilaire, BADIROU Folachadé, ZOMALHETO Xavier

Affiliation: Service de Rhumatologie du CNHU-HKM

Auteur correspondant : DJOSSOU Hontongnon Julien, drhjuliend@yahoo.com, Tél 00229 0197130572

Introduction

La lombalgie chronique mécanique est une affection fréquente aux retentissements multiples, souvent sous-estimés. Cette étude visait à décrire la perception de la douleur et ses impacts sur la vie sexuelle, sociale et professionnelle des patients atteints de lombalgie chronique consultant au service de rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou.

Patients et Méthodes

Il s'est agi d'une étude transversale descriptive menée sur trois mois (1er octobre – 31 décembre 2024) auprès de patients souffrant de lombalgie mécanique évoluant depuis plus de 3 mois. Les données ont été recueillies par questionnaire électronique via Kobocollect, lors d'entretiens face à face. Les variables étudiées concernaient les données sociodémographiques, cliniques, la perception de la douleur et ses répercussions.

Résultats

Au total, 101 patients ont été inclus, dont 77,2 % de femmes. L'âge moyen était de $50,93 \pm 17,16$ ans. Les principales étiologies retrouvées étaient la discopathie dégénérative et la spondylarthrose (39,5 % chacune), suivies de la zygarthrose (28,4 %) et de la hernie discale (21 %). Concernant la perception, 38,6 % des patients jugeaient leur douleur insupportable, 50,6 % y pensaient constamment, 58,8 % s'en inquiétaient en permanence, et 48,9 % redoutaient une aggravation incontrôlable. Sur le plan fonctionnel, 80 % évitaient certains mouvements, 53,5 % craignaient de ne plus pouvoir reprendre leurs activités habituelles. La douleur impactait la vie quotidienne dans 69,7 % des cas (ménage : 64,6 %, déplacements : 40,6 %). Une limitation des rapports sexuels était rapportée par 33,7 % des patients. La vie sociale et familiale était affectée chez 59,3 % d'entre eux. L'activité professionnelle était impactée dans 53,1 % des cas, avec 45,6 % déclarant une baisse de rendement, et 25,6 % des retards ou absences. L'inactivité professionnelle moyenne était estimée à 24,12 jours/an ; 6,7 % avaient cessé définitivement leur travail.

Conclusion

La lombalgie chronique mécanique a un impact significatif et multidimensionnel, justifiant une prise en charge globale et pluridisciplinaire.

Mots clés : Lombalgie chronique, perception de la douleur, impact sexuel, impact familial, impact social, impact professionnel

FACTEURS ASSOCIES A LA LETALITE DES ENFANTS DREPANOCYTAIRES SUIVIS AU CNHU-HKM DE COTONOU DE 2021 A 2024

Tohodjèdè Y¹, Zohoun L,² Quenum B³, Dèdjinoù E,³ Gomez S³, Gandégnon M³, Cakpo M³, Lalya F¹

¹ Clinique Universitaire de Pédiatrie et Génétique Médicale du CNHU-HKM, Cotonou

² Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi-Sô-Ava

³ Ex-Centre de Prise en charge Médicale Intégrée du Nourrisson et de la Femme Enciente atteints de Drépanocytose (CPMI-NFED) du CNHU-HKM, Cotonou

Auteur correspondant : Tohodjèdè Yévèdo, yeredo05@yahoo.fr, 0197015642

Introduction : La drépanocytose est une maladie héréditaire grave responsable d'une mortalité élevée chez l'enfant en Afrique. L'objectif de ce travail était d'étudier les facteurs associés au décès des enfants drépanocytaires suivis au CNHU-HKM de Cotonou de 2021 à 2024.

Patients et méthodes : Il s'agissait d'une étude Cas-Témoins appariée réalisée dans le service à l'ex-CPMI-NFED. Nous avons inclus tous les décès (Cas) des sujets drépanocytaires suivis sur la période que nous avons appariés selon l'âge et le phénotype de l'hémoglobine aux témoins issus de la même population. Les variables étudiées étaient les données sociodémographiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques. L'analyse des données a été faite avec le logiciel SPSS. Une valeur de $p < 0,05$ était considérée comme significative.

Résultats : La létalité était de 8,13 cas pour 1000 enfants. L'âge moyen chez les cas était de $8,84 \pm 4,04$ ans et une sex-ratio de 3,43. Le phénotype SS était prédominant (93,55%). La majorité des patients étaient diagnostiqués en postnatal à l'occasion d'une complication aiguë de la drépanocytose (77,24%). L'anémie (48,39%) et les infections bactériennes (45,16%) étaient les principales causes de décès. Les facteurs de risque de décès étaient le non-respect des rendez-vous de suivi ($OR = 10,18 [1,24-83,60]$, $p = 0,031$), une histoire familiale de drépanocytose chez les deux parents ($OR = 25,98 [1,77-380,63]$, $p = 0,017$), une mauvaise observance thérapeutique ($OR = 19,60 [3,12-123]$, $p = 0,001$). Un niveau économique élevé du ménage était un facteur protecteur contre le décès ($OR = 0,17 [0,04-0,72]$, $p = 0,017$).

Conclusion : la létalité de la drépanocytose est faible au sein des enfants suivis. Une sensibilisation des parents sur le respect des rendez-vous de suivi et l'observance thérapeutique pourraient davantage réduire cette létalité.

Mots-Clés : Létalité, Drépanocytose, Respect du suivi, Observance, Enfant.

EFFICACITE DE LA THROMBOLYSE DANS LE SYNDROME CORONAIRE AIGU A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU

BOKODAHOU MD¹, SONOU DJA¹, FANDOHAN YJG¹, HOUNKPONOU M¹, HOUETO A¹, AGBALIKA Ph¹, DOSSOU D¹, SOUMMONNI F¹, FADONOUGBO X¹, DJAOUWE S¹, AMINOU W A¹, DIKPO S¹, ADJAGBA MPh², DOHOU SHM³, CODJO HL⁴.

Affiliations :

¹Clinique Universitaire de Cardiologie (CUC), CNHU/HKM de Cotonou, Unité d'Enseignement et de Recherche de Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

²Service de Cardiologie adulte et pédiatrique, Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant Lagune (CHUMEL), Unité d'Enseignement et de Recherche de Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

³Service de Cardiologie du Centre Hospitalier Universitaire Départemental (CHUD) Borgou/Alibori, Faculté de Médecine (FM), Université de Parakou (UP), Parakou, Bénin

⁴Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC), Unité d'Enseignement et de Recherche de Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : BOKODAHOU M. David, dbokodaho@gmail.com

RESUME

Introduction : Le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST (SCA ST+) est une urgence médicale. La reperfusion coronaire précoce améliore le pronostic des patients. Le but de ce travail était d'étudier la thrombolyse dans le syndrome coronaire aigu dans le service de cardiologie du CNHU-HKM.

Méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive allant du 1er janvier 2012 au 31 septembre 2023. Étaient inclus tous les patients ayant bénéficié d'un traitement thrombolytique pour SCA ST+. Les variables étudiées étaient principalement le résultat de la thrombolyse et les facteurs influençant ce résultat. Le succès de la thrombolyse a été retenu lorsque les 2 critères que sont la régression de la douleur thoracique et la réduction d'au moins 50% de l'ampleur du sus-décalage du segment ST étaient présents.

Résultats : Quarante-sept patients ont été inclus d'âge moyen 55 ± 7 ans avec une sex-ratio de 4,87. Le délai moyen entre le début de la douleur et la thrombolyse était de 9 heures. L'altéplase a été utilisée dans 80,2% des cas. Les critères de succès ont été obtenus dans 70,2% des cas et des complications hémorragiques non mortelles ont été recensées dans 8,5% des cas. L'analyse univariée n'a pas identifié de facteur significativement associé au succès.

Conclusion : Ce travail révèle que la thrombolyse reste un moyen efficace de revascularisation du myocarde ischémié. Cependant, l'analyse coût-efficacité a montré un bénéfice bien modeste en termes de vies sauvées.

Mots-clés : Syndrome coronaire aigu, thrombolyse, Cotonou.

FACTEURS ASSOCIÉS AUX CONNAISSANCES ET ATTITUDES DES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI VIS-A-VIS DE LA LOI N°2021-12 SUR L'AVORTEMENT AU BÉNIN EN 2024

I.B. OLOWO¹, A.Y. AHOINGNAN², N.F.M. HOUNKPONOU³, N.V.S. AKPO³, T.T. ADOUKONOU³.

¹Faculté des Sciences et de la santé de l'Université d'Abomey Calavi, Bénin.

²Faculté de Médecine de l'Université de Parakou, Bénin

³Ecole Nationale de Formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et en Surveillance Épidémiologique (ENATSE) de l'Université de Parakou, Bénin

Auteur principal : Dr OLOWO Bénédicte Ingrid

Email : olowoingrid@yahoo.fr

Tél : 00229/0166460654

Introduction : Les avortements clandestins constituent un problème de santé publique et pour améliorer la santé maternelle au Bénin ; la loi 2021-12 a été votée.

Objectif : Etudier les connaissances et attitudes des étudiants vis-à-vis de la loi n°2021-12 sur l'avortement au Bénin.

Méthode : Il s'est agi d'une étude transversale descriptive et analytique à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC). Etaient inclus les étudiants âgés d'au moins 18 ans inscrits pour l'année scolaire 2023-2024 et ayant donné leur consentement et non inclus ceux n'ayant pas donné leur consentement. Une définition opérationnelle a été précisée selon le critère de 3 degrés de l'OMS. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire sur KoBoToolbox et analysées grâce au logiciel Epi Info version 7.1.3.3.

Résultats : Ont été inclus 441 étudiants. L'âge moyen était $20,6 \pm 3,05$ ans avec des extrêmes de 17 et 49 ans. Ils étaient 71,66 % à avoir une connaissance de la loi n°2021-12, 63,95% étaient contre la légalisation de l'avortement et 36,05% y sont favorables. L'accès à l'information ($p < 0,001$) et la connaissance d'un service d'avortement sécurisé ($p < 0,001$) étaient les principaux facteurs associés à de meilleures connaissances. Les attitudes favorables à l'égard de la loi étaient 32,88% ; contre 67,12% qui étaient influencées par la connaissance d'un service d'avortement sécurisé ($p < 0,001$) ($p < 0,001$).

Conclusion : Les connaissances et attitudes des étudiants de l'UAC sur la loi n°2021-12 sur l'avortement au Bénin en 2024 méritent d'être amélioré en intensifiant l'information et en faisant connaître aux étudiants les services d'avortement sécurisé.

Mots clés : Avortement, connaissances et attitudes, université BENIN, loi-2021-12.

ETUDE DES TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE SOUTENUS EN POST OPERATOIRE DE CHIRURGIE CARDIAQUE AU BENIN

Auteurs : Sonou DJA¹, Nguimgo Ngoufack N¹, Bokodaho MD¹, Kompe U¹, Soummonni F¹, Kondo R¹, Dossou C¹, Yelouassi J.D¹, Makuissu D¹, Tandjiekpon R¹, Bori Bata K¹, Dossou D¹, Fadonougbo X¹, Agbalika Ph¹, Codjo HL².

Affiliation :

¹Clinique Universitaire de Cardiologie, CNHU/HKM de Cotonou, Unité d'Enseignement et de Recherche de Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

²Centre Hospitalier International de Calavi, Unité d'Enseignement et de Recherche de Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : BOKODAH M. David, dbokodaho@gmail.com

Introduction : Le but de ce travail était d'étudier la fréquence hospitalière et l'évolution des troubles du rythme cardiaque soutenus en post-opératoire de chirurgie cardiaque au Bénin

Méthode : Il s'agit d'une étude prospective longitudinale à visée analytique. Ont été inclus par recensement exhaustif, l'ensemble des patients des deux sexes, de tout âge, ayant bénéficié d'une chirurgie cardiaque à la CUC du CNHU-HKM de Cotonou de mars 2021 à Septembre 2024. Les variables étudiées étaient les troubles du rythme cardiaque soutenus, survenus en postopératoire et diagnostiqués sur un ECG de surface, ainsi que leurs facteurs associés.

Résultats : Cent deux (102) patients ont été inclus dans le travail. L'incidence des troubles du rythme soutenus était de 37,2% au cours des 30 premiers jours du post-opératoire. Ils comprennent 42,1% de fibrillation atriale, 23,7% de flutter atrial, 13,2% de tachycardie ventriculaire, 13,2% de tachycardie jonctionnelle et 7,9% de tachycardie atriale. A la fin du 12ème mois post opératoire, 16,8% des troubles du rythme persistaient. En plus, 4,3% de nouveaux troubles du rythme soutenus étaient apparus entre le 31^{ème} jour et la fin du 12ème mois. Les facteurs associés à la survenue des troubles du rythme soutenus était l'âge ($p=0,001$) et la réalisation d'une plastie tricuspide ($p=0,035$).

Conclusion : Les arythmies cardiaques post opératoires sont dominées par la fibrillation atriale. Nous avons besoin d'étude basée sur un échantillon de plus grande taille afin d'identifier l'ensemble des facteurs associés à leur survenue.

Mots clés : Troubles du rythme cardiaque post-opératoire ; chirurgie cardiaque ; Bénin

PROFIL ÉVOLUTIF DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE A FRACTION D'ÉJECTION RÉDUITE A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU : 2021 à 2023

HOUNKPONOU AMOUSSOUGUENOU M¹, SONOU DJA¹, TCHANIGA BD¹, TIOMON B¹, ADEOSSI A¹, SAGBOHAN R¹, HOUNDO W¹, GBADAMASSI I¹, TAMEKEM MN¹, BOKODAHOMD¹, SOUMMONNI F¹, DOSSOU D¹, FADONUGBO X¹, AGBALIKA Ph¹, CODJO HL²

Affiliations :

¹Clinique Universitaire de Cardiologie, Centre National Hospitalier Hubert KOUTOUKOU MAGA (CNHU-HKM), Unité d'Enseignement et de Recherche de Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey- Calavi, Cotonou, Bénin

²Centre Hospitalier International de Calavi, Unité d'Enseignement et de Recherche de Cardiologie, Faculté des sciences de la santé (FSS), Université d'Abomey Calavi (UAC), Cotonou, Bénin

*Auteur correspondant : HOUNKPONOU AMOUSSOU-GUENOU Murielle, e-mail : kayivi2003@yahoo.fr

Introduction : L'insuffisance cardiaque (IC) a un impact significatif sur la qualité de vie des patients et est responsable d'une mortalité élevée. L'objectif de ce travail était d'étudier le profil évolutif de l'IC à fraction d'éjection réduite (ICFER) à la Clinique Universitaire de Cardiologie (CUC) du CNHU-HKM.

Méthodes : Il s'agissait d'une étude longitudinale et analytique avec une collecte prospective de données menée de janvier 2021 à juin 2023. Elle a consisté en un recrutement exhaustif des patients admis à la CUC du CNHU-HKM pour IC avec une fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) inférieure à 50%. La variable dépendante étudiée était l'évolution de l'IC appréciée par la survenue des complications, le nombre de ré-hospitalisation et le taux de mortalité. L'évolution a été jugée défavorable lorsque le patient a présenté au moins un de ces éléments. Les facteurs associés à une évolution défavorable ont été recherchés.

Résultats : Cent-treize (113) patients ont été inclus dans l'étude. L'âge moyen était de $53,2 \pm 17,3$ ans avec une sex-ratio de 1,75. La fréquence globale de ré-hospitalisation était de 18,6% et les complications rythmiques étaient les plus fréquentes (13,3%). Le taux de mortalité était de 33,6% à 12 mois. Les facteurs associés à une évolution défavorable étaient l'âge supérieur à 60 ans, la FEVG inférieure à 40%, la cardiomyopathie ischémique, l'hyponatémie, l'hypokaliémie, la mauvaise observance thérapeutique, et la présence de comorbidités.

Conclusion : L'insuffisance cardiaque à FEVG réduite est une pathologie grave greffée d'un mauvais pronostic. L'évolution a été marquée par un taux élevé de ré-hospitalisations, de complications et de mortalité.

Mots clés : Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, NYHA, ré-hospitalisation, décès.

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUE, CLINIQUE ET ÉVOLUTIF DES LOMBALGIES MÉCANIQUES CHRONIQUES DANS LE SERVICE DE RHUMATOLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU EN 2024.

LENOUMI G¹, DJOSSOU J², DJAHO D¹, NANAN E¹, BOTON M¹, DOSSOU-YOVO H¹, ZANNOU V¹, BADIROU F¹, WAKPO N¹, OTTI D¹, SOGAN S¹, FAGNON K¹, BAMPEMBE T¹, AGBOKPONTO B¹, SALAM S, HOUNMENOU A¹, ZOMALHETO Z¹

¹Service de rhumatologie du Centre National Hospitalo-Universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou (CNHU-HKM de Cotonou)

²Service de rhumatologie du Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC)

Auteur correspondant :LENOUMI Mahutondji Gilchrist

Interne des hôpitaux dans la clinique universitaire de rhumatologie du CNHU-HKM

Email :glenoumi@yahoo.com

INTRODUCTION

Les lombalgies mécaniques chroniques représentent un motif fréquent de consultation en rhumatologie. L'objectif de cette étude a été de décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et évolutives de ces affections dans un centre de référence au Bénin.

PATIENTS ET METHODES

Il s'est agi d'une étude transversale descriptive menée du 1er octobre au 31 décembre 2024, dans le service de rhumatologie du CNHU-HKM de Cotonou. Les données cliniques, sociodémographiques et évolutives des patients souffrant de lombalgies mécaniques chroniques ont été recueillies. L'analyse a été effectuée avec le logiciel R version 4.4.2.

RESULTATS

Au total, 101 patients ont été inclus, majoritairement de sexe féminin (77,2 %), avec un âge moyen de $50,9 \pm 17,2$ ans. La plupart étaient mariés (63,4 %) et avaient un niveau d'instruction secondaire ou supérieur (72,3 %). Plus de la moitié bénéficiaient d'une couverture sanitaire (59,4 %). Les circonstances de déclenchement les plus fréquentes étaient le soulèvement de charges (35,6 %) et la position penchée (21,1 %), avec un début progressif dans 77,2 % des cas. La douleur était intermittente chez 76,7 % des patients, avec une durée médiane d'évolution de 3,5 ans. Les principaux facteurs aggravants étaient la station debout prolongée (65,2 %), la marche (49,4 %) et le port de charges (43,8 %), tandis que le repos (81,1 %) et la position en décubitus (55,6 %) apportaient un soulagement. Les douleurs étaient en topographie médiane (47,2 %), latéralisée (34,8 %) ou en barre (18 %), avec une intensité médiane de 7/10. Il existait une douleur à la mobilisation du rachis lombaire dans 84,1 % des cas. En ce qui concerne le retentissement clinique des lombalgies, on retrouvait la raideur rachidienne dans 36,3 %, des attitudes vicieuses dans 31,4 % et des radiculalgies dans 67,8 %, la sciatique étant la forme la plus fréquente (66,1 %).

CONCLUSION

Cette étude met en évidence la fréquence élevée des formes cliniques complexes de lombalgies mécaniques chroniques. Elle souligne la nécessité d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge pluridisciplinaire incluant éducation posturale, rééducation fonctionnelle et soutien psychosocial.

Mots clés :Lombalgie chronique, épidémiologie, facteurs aggravants, caractéristiques cliniques, évolution.

Caractérisation phénotypique des souches de *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline isolées d'hémoculture au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) en 2023

Magloire SODJINOUE, Faridath MASSOU, Jeanne OREKAN, Abel WAKPO, Dissou AFFOLABI
CNHU-HKM, Cotonou

INTRODUCTION –

Les sepsis dus à *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM) constituent une cause majeure de mortalité. Pour certaines molécules critiques, comme la vancomycine, la sensibilité n'est pas évaluée en routine par diffusion mais uniquement par la concentration minimale inhibitrice (CMI). L'objectif de cette étude était de caractériser les souches de SARM isolées d'hémoculture au CNHU-HKM en 2023 par la détermination des CMI en milieu liquide.

MÉTHODES

Étude prospective transversale incluant 92 souches de SARM collectées consécutivement en 2023 à la Clinique Universitaire de Bactériologie-Virologie. Les CMI ont été déterminées à l'aide du système Sensititre® et comparées aux diamètres d'inhibition obtenus par diffusion en gélose, selon les recommandations EUCAST, afin d'évaluer la concordance entre les deux méthodes.

RÉSULTATS

Les taux de sensibilité mesurés par CMI étaient élevés pour la vancomycine, le linézolide et la daptomycine (96,74 % chacun), la ceftaroline (89,13 %), le triméthoprim-sulfaméthoxazole (79,35 %) et la clindamycine (73,91 %). La concordance diffusion/CMI était excellente pour la céfoxitine, la gentamicine, les fluoroquinolones et la tétracycline ($\kappa > 0,81$), mais plus faible pour le triméthoprim-sulfaméthoxazole ($\kappa = 0,55$), soulignant la nécessité de recourir à la CMI pour évaluer la sensibilité.

CONCLUSION

Les SARM étudiés demeurent sensibles à plusieurs antibiotiques majeurs, notamment la vancomycine, le linézolide, la daptomycine et la ceftaroline. La forte concordance entre diffusion et CMI confirme la fiabilité du dépistage initial par diffusion, mais la CMI reste indispensable pour certaines molécules critiques.

Mots clés : Sepsis, SARM, CMI, antibiogramme standard, concordance

Isolement d'une souche d'*Escherichia coli* entéropathogène productrice de bêta-lactamase à spectre élargi dans une coproculture : à propos d'un cas à la Clinique Universitaire De Bactériologie-Virologie du CNHU-HKM de Cotonou en 2025.

OREKAN J, SODJINOU M, WAKPO A, AFFOLABI D

CNHU-HKM de Cotonou

orekanjeanne@gmail.com

Introduction. Les diarrhées sont une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, particulièrement dans les pays à faible revenu. En plus des bactéries entéropathogènes chez les adultes, il est recommandé de rechercher systématiquement dans les selles diarrhéiques des enfants de moins de 2 ans, *Escherichia coli* entéropathogène (ECEP) mais l'isolement de ce pathovar est rare dans notre contexte de travail. Nous rapportons un cas de diarrhée à ECEP productrice de bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE) isolée dans une coproculture à la Clinique Universitaire de Bactériologie-Virologie (CUBV) du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou.

Observation. Il s'agissait d'un nourrisson de 24 mois de sexe masculin, sans antécédents particuliers reçu en consultation pour une fièvre au long cours depuis deux semaines. Il a commencé une diarrhée glairo-sanguinolente une semaine avant la consultation et a eu comme traitement avant admission du céfixime, du cotrimoxazole, et une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. L'examen clinique avait noté un état général conservé, un bon état d'hydratation avec 2 selles par jour d'aspect glairo-sanguinolente. Les explorations biologiques ont révélé une sérologie HIV et la pro-calcitonine négatives et l'examen cyto bactériologique des urines (ECBU) était sans particularités. A la coproculture, il n'y avait pas de *Salmonella*, de *Shigella* ni de *Campylobacter* mais une souche d'ECEP a été isolée. A l'antibiogramme, la souche était productrice de bêta-lactamases à spectre élargi, et était également résistante aux quinolones, au cotrimoxazole mais sensibles aux carbapénèmes, phénicolés et à l'amikacine. En hospitalisation, le traitement antérieur a été arrêté et il a été mis sous du métronidazole sirop, une réhydratation par voie orale avec la solution d'Orasel® associée au zinc et la surveillance de la température été faite. L'évolution a été favorable avec une apyrexie suivie de son exéat.

Conclusion. ECEP est souvent responsable de diarrhées épidémiques d'isolement rare et dans ce contexte la souche était résistante aux antibiotiques usuels. S'agissait-il d'une souche peu virulente ?

Mots clés : ECEP, BLSE, nourrisson, CNHU-HKM 2025.

MUTATIONS GENIQUES DANS LE TISSU PROSTATIQUE DE 52 PATIENTS

Jean Sossa, Michel Michael Agounké, Sarah Houngué, Hadidjatou Ouaké, Callinice D.N. Capo-Chichi, Fred Hodonou, Déjinnin Josué Georges Avakoudjo.

Introduction

Le cancer de la prostate est le cancer urologique le plus fréquent au Bénin mais les mutations géniques sont mal connues chez les patients. L'objectif était d'étudier les mutations géniques chez des hommes à tumeur prostatique suivie à la Clinique Universitaire d'Urologie-Andrologie du CNHU-HKM de Cotonou.

Patients et méthodes

Nous avons fait réaliser du séquençage d'ADN sur des prélèvements de tissu prostatique par le laboratoire américain Breakthrough Genomics (2 Hugues, Suite 100, CA 92618).

Résultats

Nous avons séquencé l'ADN de tissu prostatique de 52 patients. Leur âge médian était 69 ans. Leur taux moyen de PSA était 456.1ng/mL. 15 patients (28.8%) avaient une HBP et 37 patients (71.2%) avaient un cancer de la prostate (CaP). 17 gènes étaient mutés chez 20 patients dont 6 porteurs de HBP et 14 porteurs de CaP. Les gènes BRCA2, PSM1, RECQL, XPC et RAD51D étaient mutés respectivement chez 7.7%, 3.9%, 3.9%, 3.9%, and 3.9% des 52 patients. Les autres cas de mutations concernaient les gènes PSM2, RAD50, RAD51C, ERCC3, ERCC4, FANCC, APC, BRIP1, POLD1, POLE, MITF et MSH6. Il y avait des mutations de 2 ou 3 gènes différents chez le même patient porteur de HBP : FANCC/BRIP1, APC/PSM2 et ERCC4/POLD1/RAD51D. Les mutations des gènes BRCA2, PSM1 et RAD51D affectaient aussi bien des patients porteurs de HBP que des patients porteurs de CaP. Il n'y avait pas d'association significative entre les mutations géniques dans le tissu prostatique et le taux de PSA ($p=0.686$), le diagnostic histologique de HBP ou de CaP ($p=0.885$, $OR=1.1$, $95\%CI=0.3 - 3.7$) ou le grade ISUP des CaP ($p=0.883$).

Conclusion

Les mutations les plus fréquentes étaient celles des gènes BRCA2, PSM1, RECQL, XPC et RAD51D. Il n'y avait pas d'association significative entre les mutations géniques dans le tissu prostatique et le taux de PSA, la nature bénigne ou cancéreuse du tissu prostatique ou le grade ISUP des CaP.

Mots clés : Mutation génique – Cancer de la prostate – HBP.

FIABILITE DE LA PACHYMETRIE PAR TOMOGRAPHIE VERSUS LA PACHYMETRIE PAR ULTRASONS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE-HUBERT KOUTOUKOU MAGA

ABOUKI COA, TODOME F, ADJIBI J, GLODJINON S, AIGBE N, ALAMOU S, ODOULAMI L
Faculté des Sciences de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi (FSS-UAC)

Introduction : les auteurs ont étudié la fiabilité de la pachymétrie par tomographie versus la pachymétrie par ultrasons au CNHU-HKM de Cotonou.

Méthode : Il s'est agi d'une étude observationnelle, descriptive et analytique avec collecte prospective des données sur une période allant du 1^{er} Février 2024 au 30 Avril 2024, soit trois mois.

Résultats : au total 194 yeux de 100 patients avaient été étudiés. L'âge moyen était de $51,05 \pm 17,15$ ans. Une prédominance masculine a été notée avec une sex-ratio de 1,08. Les salariés étaient les plus représentés. L'épaisseur cornéenne moyenne globale était $522,57 \pm 35,73 \mu\text{m}$ pour la pachymétrie par tomographie par cohérence optique (OCT) et $534,09 \pm 33,68 \mu\text{m}$ pour la pachymétrie par ultrason confirmant ainsi la cornée fine des sujets mélanodermes. Les mesures de l'épaisseur cornéenne centrale par pachymétrie par OCT avaient donné des valeurs inférieures aux mesures fournies par la pachymétrie par ultrason. Différentes théories expliqueraient cette sous-estimation.

Conclusion : la mesure de l'épaisseur cornéenne centrale par pachymétrie par OCT avait donné des mesures fiables que la pachymétrie par ultrason.

Mots clés : pachymétrie, épaisseur cornéenne centrale, tomographie par cohérence optique, ultrason, Cotonou.

LES COMPLICATIONS POSTOPERATOIRES DE L'ADENOMECTOMIE TRANS-VESICALE DE LA PROSTATE A L'HOPITAL DE ZONE DE COVE DE 2018 A 2025

Sossa Jean, Bery Mbaitelsem, Adjiwanou Nora, Hadidjatou Ouaké, Kogui Ndouro Akim, Michel Agounkpé, Fred Hodonou, Avakoudjo Déjinnin Josué Georges.

Introduction

L'adénomectomie prostatique par voie haute (AVH) est la principale méthode de traitement chirurgical de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) dans les hôpitaux où les techniques mini-invasives ne sont pas disponibles. L'AVH est soit trans-vésicale soit trans-capsulaire.

Objectif

Étudier les complications postopératoires de l'adénomectomie trans-vésicale de la prostate (ATVP) à l'Hôpital de Zone de Cové au Bénin de 2018 à 2025.

Patients et Méthodes

Il s'agissait d'une étude descriptive rétrospective du 01 janvier 2018 au 30 avril 2025. Les données extraites des dossiers médicaux étaient analysées avec Epi Info 7.2.6.0.

Résultats

Sur 2072 patients hospitalisés, 132 soit 6,37% avaient des SBAU dont 118 cas (5.69 %) d'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP). 32 des 118 patients à HBP (27,12%) avaient subi une ATVP associée à une cure herniaire inguinale dans 6 cas (18,75%). L'âge moyen de ces 32 patients était 70,46 ans. Leur principale comorbidité était l'HTA, observée dans 31,25 % des cas. Leur taux moyen de PSA était 12 ng/mL. Leur volume prostatique moyen était de 97,63 mL. Le taux de complications postopératoires était 43,75%. Les complications postopératoires incluaient : l'hémorragie (21,88%), l'incontinence urinaire (6,25 %), la fistule vésico-pariétale (3,13 %), la sténose urétrale (3,13 %), l'infection urinaire (3,13 %). Le délai moyen d'ablation de la sonde vésicale était 14,50 jours. La durée moyenne d'hospitalisation était de 20,88 jours. Le délai d'ablation de la sonde vésicale et la durée d'hospitalisation étaient plus longs dans les cas de complications postopératoires : 18,93 contre 10,63 jours ($p=0,10$) et 26,29 contre 16,67 jours ($p=0,10$) respectivement. Le taux de mortalité était 6,25 % et était dû au choc hémorragique.

Conclusion

Les complications de l'ATVP au HZC affectaient 43,75% des patients opérés et étaient : l'hémorragie (21,88%), l'incontinence urinaire (6,25 %), l'infection urinaire (3,13 %), la fistule vésico-cutanée (3,13 %) et la sténose urétrale (3,13 %). Le taux de mortalité était 6,25%, dû au choc hémorragique.

Mots-clés : HBP – ATVP – Complications – HZC.

DEVENIR DES PATIENTS PRIS EN CHARGE POUR PRIAPISME A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE D'UROLOGIE ANDROLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU DE 2014 A 2023

Dodji Magloire I. YEVI, Ghislain MBADINGA NZAMB, Akim KOGUI DOURO, Chadrac Jalice A. GNIMASSOU, Jean SOSSA, Fred HODONOU, Michel Michaël AGOUNKPE, Gilles NATCHAGANDE, Khadidjatou OUAKE, Josué D.G. AVAKOUDJO

CNHU-HKM de Cotonou

Correspondant : Dr YEVI Dodji Magloire Inès.

Email : dryevi@gmail.com, Cell : +229 97242160, 07BP 1068 Cotonou

RESUME:

Objectif : Etudier l'évolution post thérapeutique des patients pris en charge pour priapisme à la CUUA du CNHU-HKM de Cotonou.

Patients et méthodes : Il s'est agi d'une étude transversale, descriptive à collecte rétrospective de données réalisée de janvier 2014 à décembre 2023 à la CUUA du CNHU HKM de Cotonou ayant porté sur 30 patients admis durant la période d'étude pour priapisme.

Résultats : 30 dossiers ont été colligés. La fréquence hospitalière du priapisme était de 0,73% sur un total de 4131 patients hospitalisés pendant la période d'étude. La tranche d'âge la plus représentée était celle de 20 à 35ans. Les antécédents identifiés étaient la drépanocytose (70%) avec des formes homozygotes SS (53,33), et des formes hétérozygotes SC (16,67%); Les patients étaient adressés par un agent de santé (50%). L'érection prolongée et douloureuse a été le principal motif de consultation (100%). Le priapisme survenait de manière spontanée (73,33%) suite à la prise d'un aphrodisiaque (20%) ou la prise d'alcool (6,67%). Le délai moyen de consultation était de 74,6 ($\pm 45,6$) heures avec des extrêmes de 9 à 148 heures. Le priapisme était ischémique dans tous les cas (100%). Sur le plan thérapeutique, les patients ont bénéficié d'une ponction caverneuse (90%) ayant ramené dans tous les cas du sang noirâtre et sirupeux, de shunts caverno-spongieuses (53,33%). Les complications tardives étaient la dysfonction érectile (60%), la fibrose des corps caverneux (16,67%), la suppuration des corps caverneux (6,67%) et la nécrose de la verge (3,33%). La satisfaction globale des patients était notée à 4/5 dans 66,7% des cas.

Conclusion : Le priapisme constitue une urgence urologique rare. Dans nos régions, la drépanocytose reste la principale étiologie.

Mots clés : priapisme, drépanocytose, ponction caverneuse, anastomose caverno-spongieuse, dysfonction érectile

COMPLICATIONS CHIRURGICALES GRAVES DE L'AVORTEMENT A RISQUE, REVELATRICES DE DEFIS PERSISTANTS POUR LA PREVENTION DES MORBIDITES ET MORTALITE LIEES AUX AVORTEMENTS CLANDESTINS AU BENIN

Vodouhè Tchimon^{1,2}, Aboubakar Moufalilou^{2,3}, Ogoudjobi Mathieu^{2,4}, Acakpo Barnard¹, Attolou Yannick³, Tshabu Aguemon Christiane^{1,2}, Tonato Bagnan Angeline^{2,3}, Dénakpo Justin Lewis^{1,2}

Affiliations

1. Clinique Universitaire de Gynécologie et d'Obstétrique (CUGO) du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, Bénin
2. Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi, Bénin
3. Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et l'Enfant Lagune (CHU-MEL) de Cotonou, Bénin
4. Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l'Ouémé-Plateau (CHUD-OP), Bénin

Auteur correspondant : Vodouhè Tchimon yéa Sètchégnon

Tél +229 0197291989 ; Email : tchimonvod@yahoo.com

Introduction : Les avortements à risque prédominent dans les pays où l'accès à l'avortement sécurisé est prohibé. Depuis 2021, les conditions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) ont été élargies au Bénin. Paradoxalement, les avortements clandestins persistent, avec des complications graves, révélant des défis persistants.

Méthodes : Nous rapportons trois cas de complications chirurgicales graves d'avortement à risque traitées au CNHU-HKM de Cotonou en 2025.

Observations : Les trois patientes ont été référées au CNHU-HKM pour suspicion de perforation utérine post abortive. La première, nourrice de 35 ans, revendeuse, mariée avec trois enfants, a subi un curetage dans un cabinet, cinq jours auparavant. La deuxième, 23 ans, couturière, célibataire, primigeste, a pratiqué une IVG par introduction d'une tige dans les voies génitales. L'apparition de douleurs pelviennes et métrorragies a motivé sa consultation. La troisième, 20ans, revendeuse, célibataire, fut référée d'un centre de santé pour anémie décompensée compliquant l'avortement d'une grossesse arrêtée de 20SA. La survenue de fièvre et pertes malodorantes motiva la consultation. Les trois bénéficièrent d'un traitement chirurgical. La laparotomie permit de découvrir une perforation du fundique (2cm) avec incarceration de l'appendice chez la première, une perforation postérieure de l'utérus (10cm) avec un fœtus mort mutilé chez la deuxième, une perforation fundique traversée par une tige de bois transperçant l'épiploon chez la troisième. Une réparation des lésions fut effectuée. Concernant les raisons de l'avortement clandestin, les trois relatèrent la crainte de la stigmatisation et du refus des prestataires de santé de pratiquer une IVG ; la première ajouta le jeune âge du dernier enfant, tandis que la deuxième craignit l'information des parents en cas d'IVG dans un établissement réglementaire. Les défis soulevés sont la connaissance des dispositions légales par la population, la confiance dans le système de santé (absence de stigmatisation, respect du secret médical, compétence technique), la compétence des prestataires.

Conclusion : L'éradication des avortements à risque au Bénin nécessite un écosystème à plusieurs composantes dont la législation, le système de santé, les prestataires compétents. L'intégration des soins complets d'avortement dans le curriculum de formation des étudiants en médecine générale pourrait y contribuer.

Mots clés : Avortement à risque, perforation utérine, complication chirurgicale, stigmatisation, prestataires compétents

IRM CARDIAQUE AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE HKM DE COTONOU : BILAN D'ACTIVITE

AYI MEGNANGLO CA¹, ADJADOHOUN SBMG¹, WHENU P¹, SANSUAMOU ET¹, AGAI JB²,
YEKPE AHOANSOU P¹.

¹Clinique Universitaire d'Imagerie médicale, Centre National Hospitalier et Universitaire HKM de Cotonou (Bénin)

²Service de Radiologie et Imagerie du Centre Hospitalier Départemental Borgou-Alibori, Parakou (Bénin)

Auteur correspondant :

Ayi Megnanglo Codjo Austher

Assistant FSS Cotonou

Email : macod55@yahoo.fr

Tél : 00229 95454430

RESUME

Introduction

Les pathologies cardiaques sont diverses et variées et constituent un problème de santé publique. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) devient de plus en plus incontournable dans l'exploration de certaines pathologies cardiaques. L'objectif de cette étude était de faire le point sur les activités de l'IRM cardiaque au CNHU de Cotonou.

Matériel et méthode : étude rétrospective et descriptive sur une période de 21 mois de Décembre 2023 à Aout 2025. Etait inclus tout patient reçu en IRM pour pathologie cardiaque. Les examens étaient réalisés avec une IRM 1,5 Tesla. Le protocole comportait des séquences morphologiques, cinétiques et de rehaussement tardif. Les paramètres étudiés étaient l'âge et le sexe des patients, les indications et les aspects lésionnels rencontrés.

Résultats : trente-cinq (35) patients ont été colligés avec une moyenne d'âge de $51,54 \pm 24,01$ ans [11 - 73 ans] et une sex-ratio de 4. Les indications étaient dominées par la recherche d'étiologie des cardiomyopathies hypertrophiques dans 10 cas (28,5%), suivies des cardiomyopathies dilatées dans 5 cas (14,2%), une myocardite, une cardiopathie ischémique et une palpitation respectivement dans 4 cas (11,4%).

L'IRM avait retrouvé une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) dans 18 cas (51,4 %). Onze patients présentaient une hypokinésie segmentaire (31,4%) et deux une hypokinésie globale (5,7%). Les cardiomyopathies retrouvées étaient majoritairement hypertrophiques (28,5%) suivies des cardiomyopathies dilatées (20%). On retrouvait une myocardite et un infarctus respectivement dans quatre cas (11,4%) et une fibrose dans 1 cas (2,8%). Dans 6 cas (17,1%), l'IRM était normale.

Conclusion

L'IRM est devenue de nos jours une modalité très excellente pour l'exploration des pathologies cardiaques. Les cardiomyopathies et myocardites sont les affections les plus rencontrées dans notre contexte.

Mots clés : IRM cardiaque, pathologie cardiaque, Cotonou

ASPECTS THERAPEUTIQUES DE LA PYELONEPHRITE AIGUE A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE D'UROLOGIE ANDROLOGIE DU CNHU-HKM DE COTONOU DE 2018 à 2023.

Auteurs : Akim KOGUI DOURO, Dodji Magloire I. YEVI, , Dossou Paul TOVIZOUNKOU, Jean SOSSA, Fred HODONOU, Michel Michaël AGOUNKPE, Gilles NATCHAGANDE, Khadidjatou OUAKE, Josué D.G. AVAKOUDJO

Introduction : La pyélonéphrite est une infection bactérienne du bassinet et du parenchyme rénal nécessitant une prise en charge médicale et chirurgicale urgente. Cette étude vise à actualiser et approfondir les données sur la gestion de la pyélonéphrite à la clinique universitaire d'urologie et d'andrologie du CNHU-HKM de Cotonou.

Méthode : Il s'agit d'une étude transversale descriptive à collecte rétrospective des données sur une période de 06 ans allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2023.

Résultats : Sur 2350 admissions, 61 cas (2,60%) répondaient aux critères de l'étude. Les patients avaient en moyenne 47,67 ans. La majorité avait un niveau d'instruction secondaire ou plus (59%), étaient artisans (22,95%) et mariés (55,70%). Les antécédents prédominants étaient des lésions lithiasiques (18,03%) et une hypertrophie prostatique (13,11%). La douleur lombaire (86,89%) était le motif de consultation le plus fréquent. Le signe de Giordano (86,89%) était le signe physique dominant. L'antibiothérapie probabiliste avait été initiée dans 86,89% des cas, avec des céphalosporines de troisième génération (80,33%) et des quinolones (72,13%). Après les résultats, les antibiotiques spécifiques les plus utilisés étaient les aminosides (52%), les céphalosporines de troisième génération (32%) et les carbapénèmes (20%). Sept patients (11,48%) ont nécessité un traitement chirurgical en urgence, incluant drainage de sonde JJ, ponction drainage péri rénal et néphrostomie. Tous les autres patients (88,52%) ont connu une évolution favorable.

CONCLUSION : Au terme de notre étude nous pouvons en déduire que la prise en charge de la pyélonéphrite aigue est bien codifiée et est à la fois médicamenteuse et chirurgicale. Elle doit être précoce pour éviter d'éventuelle complication

Mots clés : Pyélonéphrite aigue, traitement, infection, Bénin

ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES DES URGENCES CHIRURGICALES UROLOGIQUES AU CNHU HKM DE COTONOU DE 2012 A 2023

Dodji Magloire I. YEVI, Akim KOGUI DOURO, Sourou Auguste B. OBOSSOU, Jean SOSSA, Fred HODONOU, Michel Michaël AGOUNKPE, Gilles NATCHAGANDE, Khadidjatou OUAKE, Josué D.G. AVAKOUDJO
CNHU-HKM de Cotonou

Correspondant : Dr YEVI Dodji Magloire Inès.

Email : dryevi@gmail.com, Cell : +229 97242160, 07BP 1068 Cotonou

Introduction : Les urgences chirurgicales urologiques regroupent des pathologies dont la prise en charge est chirurgicale et urgente.

Méthode : Il s'est agi d'une étude rétrospective à visée descriptive avec collecte transversale de données complémentaires qui s'est déroulée au CNHU-HKM de Cotonou et ayant porté sur les aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques des urgences chirurgicales urologiques de Janvier 2012 à décembre 2023.

Résultats : 235 dossiers ont été retenus durant la période d'étude. L'âge moyen des patients était de 34 ans avec des extrêmes de 20 ans et 95 ans. La sex-ratio était de 3 en faveur des hommes. Plus de la moitié des patients avaient consulté après 24h du début de la symptomatologie (59,57%). La majorité des examens initiaux étaient réalisés par des internes (51,91%), suivis des Spécialistes d'Urologie en formation (30,21%). La douleur était le principal motif de consultation (67,84%), suivie des rétentions vésicales complètes d'urines (12,37%) et des traumatismes par AVP (9,19%). Les urgences chirurgicales urologiques étaient dominées par les urgences chirurgicales non traumatiques (81,55%) constituées par les Insuffisances rénales obstructives par urétéro-hydronephroses (14,89%), les torsions du cordon spermatique (8,94%), les priapismes persistants (7,23%), les lithiases rénales obstructives (5,96%), et les gangrènes de Fourniers (5,53%). Les urgences chirurgicales traumatiques avaient pour siège de prédilection l'urètre (23,53%). La prise en charge des urgences chirurgicales urologiques dans les 6 premières heures de l'admission était effective dans 48,51% des cas. Les traitements médicaux reçus aux urgences étaient essentiellement les antalgiques (100%), la réhydratation hydro électrolytique (55,32%). Les antibiotiques (80,85%). Les actes posés en urgence étaient : la montée de sonde double J (25,53%), une orchidopexie bilatérale (12,34%) et une Néphrolithotomie Per Cutané (7,23%). La plupart des patients sont transférés des urgences vers le service d'urologie (83,40 ans)

Conclusion : Les urgences chirurgicales urologiques ne sont pas rares car elles font partie intégrante des urgences urologiques. Leur prise en charge urgente garantit une récupération des fonctions de l'organe lésé.

Mots Clés : Urgence Chirurgicale, Diagnostic, Epidémiologie, Rétention urinaire, Ponction caverneuse, NLPC, traitement

Exencéphalie de diagnostic post-natal compliquée de méningite : à propos d'un cas à la clinique universitaire de néonatalogie du CNHU-HKM

LOKOSSI Jean-Claude¹, HODE Luphin¹, BAGNAN TOSSA Léhila², ALIHONOU Thierry¹

Introduction : L'exencéphalie est une anomalie congénitale résultant d'un trouble de développement du crâne . Il s'agit d'une absence de formation ou d'une formation incomplète de la voûte crânienne avec un défaut du scalp exposant le tissu cérébral entièrement formé. Nous rapportons un cas d'exencéphalie chez un nouveau-né reçu à la Clinique Universitaire de Néonatalogie (CUNC) du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou au Bénin (CNHU-HKM), chez qui un avis neurochirurgie a été requis.

Observation : Il s'est agi d'un nouveau-né de sexe féminin à J14 de vie, référé de la périphérie pour infection néonatale associée à une malformation congénitale de la voûte. Huit jours plus tôt, il aurait présenté deux épisodes de crises convulsives sans notion de fièvre et un refus de téter. L'étude des antécédents retrouvait une grossesse mal suivie, sans anomalie prénatale révélée et une naissance eutocique. L'examen clinique permis de mettre en évidence le défaut du cuir chevelu et de la voûte du crâne ainsi qu'une fuite de liquide cérébro-spinal. Les explorations biologiques retrouvent un syndrome inflammatoire, une hypoglycorachie amicrobienne. L'absence d'indication chirurgicale et le pronostic péjoratif furent expliqués aux parents. L'antibiothérapie probabiliste n'a pas prouvé une bonne réponse biologique sur les contrôles. L'évolution a été marquée par une sortie contre avis médical à J36 de vie.

Conclusion : L'exencéphalie est une malformation rare et léthale. Son diagnostic est clinique en post-natal mais est possible à l'imagerie lors du suivi prénatal.

Mots clés : Exencéphalie, acranie, congénitale, CNHU-HKM, néonatalogie, 2025

TORSION D'UN KYSTE OVARIEN SUR GROSSESSE GEMELLAIRE AU TROISIEME TRIMESTRE A PROPOS D'UN CAS A L'HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PARAKOU EN 2021.³Ingrid OLOWO; ²Moufalilou Aboubakar; ¹Roger Clikpézo.¹Hopital d'instruction des armées de Parakou.²Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant-Lagune.³Centre Hospitalier Universitaire Départemental Ouémé Plateau**Auteur correspondant :** OLOWO B Ingrid, assistant en Gynécologie-Obstétrique, FSS/UAC, olowoingrid@yahoo.fr,

RESUME : Les urgences chirurgicales causent un véritable problème diagnostique et mettant en danger la vie de la mère et du fœtus. Nous rapportons d'une torsion de l'ovaire droite en cours d'une grossesse gémellaire de 33 semaines d'aménorrhée. L'objectif est de montrer les difficultés de diagnostic et de prise en charge précoce. Le diagnostic erroné de départ a conduit à une ovariectomie après extraction des fœtus par césarienne.

Conclusion : La torsion du kyste sur grossesse au troisième trimestre a été découverte à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou en 2021. Le diagnostic n'a été confirmé qu'après la césarienne et la sanction chirurgicale était une annexectomie.

Mots clés : torsion, kyste, ovaire, grossesse gémellaire ; HIA-Parakou.

ENDOMÉTRIOSE OMBILICALE PRIMITIVE ISOLÉE : À PROPOS D'UN CAS

SGR ATTOLOU, J-JB BILUBI, B ATCHOU, M CHABI-YOROUBA, MC LALEYE, NR HOUNSOU,
PC FADONUGBO, DG GBESSI, FM DOSSOU

Auteur correspondant : attolougilles@yahoo.fr

Introduction : L'endométriome ombilicale connue sous le nom de nodule de Villar représente une entité pathologique rare caractérisée par la présence ectopique du tissu endométrial au niveau de l'ombilic. Nous rapportons un cas clinique illustrant cette pathologie peu fréquente, dans sa forme primitive et isolée chez une patiente de 35 ans en absence de toute chirurgie abdomino-pelvienne préalable.

Observation : Il s'agit d'une Patiente âgée de 35 ans, G1P1, aux antécédents de cure de hernie ombilicale par raphie 04 ans auparavant, qui présentait une induration ombilicale douloureuse évoluant depuis 03 ans. Les examens clinique et histopathologique ont permis de conclure à une endométriome ombilicale. Elle a bénéficié d'une exérèse du nodule avec omphalectomie, suivie d'une mini-laparotomie exploratrice de la cavité abdominale et du pelvis.

Les suites opératoires étaient simples. La patiente a été adressée en gynécologie pour prise en charge médicale.

Conclusion : L'endométriome ombilicale est une pathologie peu fréquente qui représente environ 1% de l'ensemble des localisations de cette affection, mais pouvant évoluer vers une transformation maligne. Il sied d'y penser devant tout nodule ombilical douloureux cyclique.

Mots clés : Endométriome – ombilicale – primitive – isolée – chirurgie

SYNDROME DE DI GEORGE DE DIAGNOSTIC TARDIF CHEZ UNE ADOLESCENTE DE 14 ANS : A PROPOS D'UN CAS AU CENTRE NATIONAL HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HUBERT KOUTOUKOU MAGA DE COTONOU.**Tohodjèdé Y¹, Zohoun L¹, Codjo L², Lankpeko C¹, Ague-Chabi K¹, Alihonou F¹, Lalya F¹**¹Clinique Universitaire de Pédiatrie et Génétique Médicale du CNHU-HKM de Cotonou.² Clinique Universitaire de Cardiologie du CNHU-HKM de CotonouAuteur correspondant : Tohosjèdé Yévèdo, veredo05@yahoo.fr, 0022997015642

Introduction : Le syndrome de Di George est le trouble microdélétionnel chromosomique le plus courant. Nous rapportons un cas diagnostiqué dans le service de pédiatrie du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou au Bénin en 2022.

Observation : Il s'agit d'une adolescente de 14 ans qui nous avait été référée pour des contractures des extrémités des membres évoluant depuis plusieurs jours. Elle était suivie depuis l'âge de 02 ans par un cardiologue pour un essoufflement à l'effort associé à une cyanose et des contractures récurrentes des mains. Son traitement était fait de propranolol et d'une supplémentation en calcium. Il n'y avait pas de notion de consanguinité et sa naissance était normale. Elle avait un retard scolaire. A l'examen, on il n'y avait pas de dysmorphie faciale ; elle avait un souffle systolique au foyer pulmonaire, un colobome irido-cristallo-rétinien au fond d'œil, une cyanose et des contractures des mains. La biologie a montré une polyglobulie, une hypocalcémie, une hyperphosphorémie et un taux anormalement normal de la parathormone. Les deux reins étaient de petites tailles mais la fonction rénale était normale. L'échographie cardiaque conclut à une atrésie de l'artère pulmonaire. L'analyse génétique conclut à une micro délétion 22q11.2.

Conclusion : Le syndrome de Di George doit être évoqué devant l'association d'une cardiopathie congénitale et des signes d'hypocalcémie.

Mots Clés : Syndrome de Di George, cardiopathie congénitale, hypocalcémie.

INTERCEPTION DE LA CLASSE II DIVISION 1 EN ORTHOPEDIE DENTO FACIALE CHEZ UNE JEUNE FILLE A LA CUCMF OS DU CNHU HKM DE COTONOU

**Dahoue Tr1, Dohou Gam1, Bancole Pognon As1, Do Santos Za2, Lawson Afouda S2,
Avakoudjo F3, Vodouhe U3, Adjibabi W2**

UE- ORL- CCF/ FSS / UAC

1 : Clinique Universitaire de CMF-OS du CNHU HKM de Cotonou

2 : Clinique Universitaire d'ORL- CCF du CNHU HKM de Cotonou

3 : Clinique Universitaire d'ORL- CCF du CHUZ de Suru Léré

Auteur correspondant : DAHOUE Togbedji Richard, assistant en position probatoire/ UE d'ORL -CCF de la Faculté des Sciences de la Santé / Université d'Abomey Calavi

Introduction :

La classe II division 1 est une anomalie des relations d'arcades caractérisée par une première molaire mandibulaire en retrait par rapport à la première molaire maxillaire et au niveau antérieur par un surplomb augmenté. Sa fréquence est de 25% en population générale et représente 60% des patients orthodontiques en France. Les causes de cette anomalie sont multifactorielles, héréditaires et fonctionnelles ou mixtes. Leurs prises en charge peuvent être préventives, interceptives ou curatives. L'intérêt de notre présentation réside dans le fait qu'il s'agit d'une patiente avec un surplomb horizontal excessif de 10 millimètres. L'objectif de notre présentation est un partage d'expérience sur la prise en charge d'une jeune patiente à la CUCM OS du CNHU HKM de Cotonou.

Observation clinique :

Il s'agissait d'une jeune patiente âgée de 7 ans, reçue en consultation d'orthopédie dento faciale, pour un motif de protrusion incisive maxillaire. L'interrogatoire, l'examen clinique, l'étude de la radiographie panoramique et de la téléradiographie de profil et l'examen des fonctions oro faciales ont permis de poser le diagnostic de classe II division 1 avec un maxillaire en forme de V et une ventilation buccale sur un schéma de croissance hyperdivergent. Il a été convenu avec les parents, de faire une interception de la classe II division 1, à l'aide d'une plaque à vérin avec un bandeau vestibulaire pour le contrôle de la position des incisives et la rééducation de la ventilation nasale.

Au bout d'un an de contrôles mensuels et d'activations, il a été noté une réduction importante du surplomb passant de 10 à 4 millimètres ; minimisant ainsi les risques de fracture coronaire des incisives maxillaires et un remodelage de la forme de l'arcade maxillaire passant d'une forme en V à une forme en U.

Conclusion

La plaque à vérin avec un bandeau vestibulaire a permis une correction du surplomb exagéré ; ce qui réduit ainsi les risques de fracture de ces incisives maxillaires. La correction du sens transversal obtenue avec le vérin a contribué à une avancée mandibulaire.

Mots clés : Classe II division 1, surplomb, interception, plaque à vérin, activation, orthopédie dento faciale

Luxation sous talienne antéro-médiale au CNHU-HKM de Cotonou : A propos d'un cas et revue de littérature

Auteurs : Sagbohan P, Chigblo P, Ayénodé D, Dohou J, Hessou A, Hans-Moévi Akué A

Introduction : La luxation sous-talienne se définit par la perte permanente des rapports entre les surfaces articulaires des articulations talo-calcanéenne et talo naviculaire, le talus gardant ses rapports avec la mortaise tibio-fibulaire. Les luxations sous-taliennes sont rares, représentant 1 à 1,5 % de l'ensemble des lésions traumatiques du pied. En fonction du sens de déplacement de l'avant-pied, elles sont en luxation médiale, latérale, postérieure et antérieure. Ce sont des lésions de bon pronostic mais des complications sont possibles à type de nécrose du talus et d'arthrose sous talaire.

Observation : Il s'agissait, d'une femme âgée de 24 ans, admise aux urgences dans un contexte de traumatisme fermé de la cheville gauche par accident de la voie publique avec inversion et équinisme du pied. La radiographie standard a permis de poser le diagnostic de luxation sous talienne antéro-médiale avec arrachement du tubercule postérieur du talus. La peau en regard était très tendue, avec un risque de nécrose. Elle a bénéficié en urgence d'une réduction orthopédique sous anesthésie générale puis immobilisation par une botte plâtrée. A 10 mois de recul aucun signe de nécrose du talus n'a été détecté et le résultat fonctionnel est satisfaisant avec un score de l'AOFAS à 88/100.

Conclusion : La luxation sous talienne est une affection traumatologique rare, son diagnostic est facile, le traitement consiste souvent en une réduction par manœuvre externe sous anesthésie générale, sauf en cas d'irréductibilité par incarceration ligamentaire où une réduction à foyer ouvert s'impose

Mots clés : Luxation, Talus, Réduction, Nécrose, CNHU-HKM

TRAITEMENT ORTHODONTIQUE SANS EXTRACTION DE PREMOLAIRES CHEZ LA JEUNE ADOLESCENTE : A PROPOS D'UN CAS

DOHOU GAM, DAHOUE TR, LEKESSE APILLA C, BANCOLE POGNON S, ZAOUI F, ADJIBABI W
UFR- ORL- CCF/ FSS/ UAC

Introduction :

La dysharmonie dento-maxillaire (DDM) se définit comme une disproportion entre le diamètre mésio-distal des dents et le périmètre des arcades alvéolaires correspondantes et comprend l'encombrement, la courbe de spee et le repositionnement incisif. Le traitement de la DDM dépend de nombreux facteurs tels que la quantité de DDM, l'esthétique faciale, la philosophie et la dextérité du praticien

Observation Clinique :

Il s'agissait d'une patiente de 14 ans, reçue en consultation pour un motif de sourire disgracieux. L'examen clinique et l'analyse céphalométrique ont permis de diagnostiquer sur le plan squelettique d'une classe I squelettique normo-divergente, une occlusion de classe I avec DDM de 14 mm. Malgré l'importance de la DDM, il a été décidé de commun accord avec la patiente de faire un traitement orthodontique sans extraction.

Résultat :

Le traitement a duré 16 mois et a permis de rétablir une continuité des points de contact sans abimer le profil et le sourire

Conclusion :

La décision thérapeutique dans le cas des DDM nécessite un bon sens clinique du praticien même devant des valeurs céphalométriques extrêmes.

Mots clés : Encombrement dentaire, extraction dentaire, esthétique faciale, orthodontie

Issue fatale d'un cas de traumatisme abdominal à faible cinétique : aspects médico-légaux

Cedric Bigot¹, **Ibrohim Odjo¹**, Megninou Brice², Imorou Souaibou Yacoubou²

1- Unité de médecine légale – FSS-UAC

2- Unité de chirurgie Générale – FSS-UAC

Introduction : La perforation intestinale est définie par une brèche de la paroi digestive, entraînant l'épanchement du contenu intestinal dans la cavité péritonéale. Elle expose à une péritonite, un sepsis et au décès en l'absence de prise en charge rapide. Ses causes sont pathologiques (ulcères, cancers, infections, ischémie, iatrogénie) ou traumatiques. Les traumatismes directs à faible cinétique, tels que les coups portés à l'abdomen, sont exceptionnels. Leur rareté, l'absence parfois de signes externes et les enjeux médico-légaux soulignent l'importance de l'autopsie (en cas de décès) pour établir le diagnostic et les responsabilités. Le cas concerne un homme de 36 ans, victime de coups de poing et de genou portés à l'abdomen par son employeur. Après un repas, son état s'est aggravé au cours de la nuit avec des douleurs abdominales intenses. Décédé à son arrivée à l'hôpital, il n'a bénéficié d'aucun examen médical complémentaire.

L'examen externe était peu contributif, ne révélant qu'une érosion superficielle au genou. L'autopsie a mis en évidence une perforation jéjunale de 6 mm, une péritonite diffuse avec liquide fécaloïde, et une congestion multiviscérale. La cause du décès a été attribuée à une contusion abdominale compliquée d'une perforation intestinale et d'une péritonite fatale.

Ce cas illustre la rareté des perforations intestinales liées à un traumatisme abdominal à faible cinétique, ainsi que le contraste frappant entre l'absence de lésions externes visibles et la gravité des atteintes internes observées. Il met également en évidence le rôle déterminant de l'autopsie pour établir la cause réelle du décès et éviter qu'il ne soit faussement attribué à une mort naturelle. Enfin, il rappelle les obligations médico-légales qui incombent aux praticiens : signaler tout décès suspect, instaurer un obstacle médico-légal à l'inhumation et informer les autorités judiciaires, conformément aux dispositions légales en vigueur au Bénin.

Mots-clés : perforation intestinale, péritonite, traumatisme abdominal à faible cinétique, autopsie, mort violente, responsabilité médicale.

OSTEONECROSE ASEPTIQUE BILATERALE DE LA TETE HUMERALE : A PROPOS D'UN CAS

Gbodo M, Chigblo P, Sagbohan P, Padonou A, Amossou F, Goukodadja O, Hans-Moevi A

Introduction : L'ostéonécrose aseptique de la tête humérale est une **pathologie résultant d'une altération de la vascularisation osseuse, entraînant une nécrose** progressive. C'est la 2^{ème} localisation des ostéonécroses atraumatiques après celles de la tête fémorale. Il s'agit d'une pathologie multifactorielle très rare et donc très peu rapportée dans la littérature. Nous rapportons ici un cas d'ostéonécrose bilatérale de la tête humérale chez un hémoglobinopathe.

Observation : Il s'agissait d'une jeune femme de 32 ans, hémoglobinopathe SC, reçue pour des douleurs chroniques des deux épaules évoluant depuis 5 ans environ. L'examen physique a permis de retrouver une amyotrophie bilatérale du moignon de l'épaule, une douleur vive à la palpation des deux têtes humérales. Les amplitudes articulaires des deux épaules étaient limitées par la douleur avec l'élévation antérieure active à 70°, l'élévation antérieure passive à 90°, la rotation latérale à 10° et la rotation médiale à la fesse. La radiographie standard des deux épaules, incidences de face et de profil, a permis d'objectiver une nécrose des deux têtes humérales au stade IV de ARLETT et FICAT. Elle a été mise sous traitement médicamenteux à base d'antalgiques et d'anti-inflammatoires avec un repos articulaire puis secondairement de la rééducation fonctionnelle. L'évolution a été marquée par une régression des douleurs, autorisant la reprise de ses activités professionnelles. Un réaménagement de poste est envisagé pour optimiser l'économie articulaire. Une arthroplastie bilatérale est à prévoir au stade ultime. Cette offre thérapeutique n'est pas encore disponible dans notre contexte de travail. Une évacuation sanitaire vers un centre plus équipé sera la solution.

Conclusion : L'ostéonécrose aseptique de la tête humérale est une des complications rares de la drépanocytose. Nous avons présenté un cas où l'atteinte est bilatérale.

Mots clés : ostéonécrose, aseptique, tête humérale, CNHU, Bénin.

HÉMANGIOME CAPILLAIRE RÉTINIEN JUXTAPAPILLAIRE : À PROPOS D'UN CAS
TODOME F1, 2, 3, VIINIKKA E1,2, AUFFRET E1

1. Service d'Ophtalmologie, GHRMSA – Groupe Hospitalier Régional Mulhouse Sud-Alsace, France
2. Faculté de Médecine de Strasbourg, France
3. Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, Bénin

Résumé

Les hémangiomes capillaires rétiniens, également appelés hémangioblastomes, sont des tumeurs vasculaires bénignes rares, pouvant être sporadiques ou associés à la maladie de von Hippel-Lindau. Leur forme juxtapapillaire représente environ 5 % des cas et pose des difficultés diagnostiques et thérapeutiques du fait de sa proximité avec le nerf optique. Nous rapportons le cas d'une patiente de 81 ans, reçue pour larmoiement, chez qui le bilan ophtalmologique a mis en évidence une masse juxtapapillaire nasale de l'œil droit, associée à un œdème papillaire sectoriel et des exsudats secs péripapillaires. L'OCT montrait une déstructuration des couches rétinienne avec masse intrarétinienne, et l'angiographie à la fluorescéine objectivait une hyperfluorescence persistante. L'angiographie au vert d'indocyanine et l'OCT-angiographie confirmaient l'absence de néovaisseaux. Le bilan général et l'IRM orbito-cérébrale n'ont pas retrouvé d'anomalies associées, et aucun antécédent personnel ou familial de VHL n'était rapporté. Après concertation multidisciplinaire, le diagnostic d'hémangiome capillaire rétinien juxtapapillaire sporadique a été retenu. À dix mois de suivi, aucune complication n'a été notée, avec stabilisation clinique et préservation de l'acuité visuelle, permettant une simple surveillance sans traitement invasif.

Conclusion : ce cas illustre la rareté et la difficulté diagnostique des hémangiomes capillaires rétiniens juxtapapillaires. La surveillance rapprochée constitue une option raisonnable en l'absence de complications visuelles ou évolutives.

Mots-clés : hémangiome capillaire rétinien, juxtapapillaire, nerf optique, cas clinique.

ANOMALIE DE NAISSANCE DE L'ARTERE CORONAIRE DROITE DU SINUS OPPOSE A PROPOS D'UN CAS AU CNHU-HKM DE COTONOU

AYI MEGNANGLO CA¹, ADJADOHOUN SBMG¹, WHENU P¹, DOSSOU D², SANSUAMOU ET¹, YEKPE AHOUANSON P¹.

¹Clinique Universitaire d'Imagerie Médicale, Centre National Hospitalier et Universitaire HKM de Cotonou (Bénin)

²Clinique Universitaire de Cardiologie, Centre National Hospitalier et Universitaire HKM de Cotonou (Bénin)

Auteur correspondant :

AYI MEGNANGLO Codjo Austher, Email : macod55@yahoo.fr, Tél : 00229 0195454430

RESUME :

Introduction : l'anomalie de naissance des artères coronaire du sinus opposé est une malformation cardiaque congénitale rare et constitue une des causes les plus importantes de la mort subite chez des jeunes sportifs. La prévalence de la maladie est de 12 à 19 % chez les athlètes de 14 à 40 ans qui présentent une mort subite cardiaque versus 1.2% pour les morts sans lien avec le sport. Nous rapportons un cas dont le diagnostic a été fait au coroscanner.

Observation : il s'agit d'un patient âgé de 72 ans admis pour douleurs thoraciques évoluant par intermittence. Dans ses antécédents on ne notait pas d'HTA ni de diabète et a pour FDRCV l'âge et le sexe. Au plan clinique, l'examen cardiovasculaire était normal. L'électrocardiogramme avait objectivé une bradycardie sinusale régulière à 55 bpm et une hyperexcitabilité ventriculaire grade III de Lown associant des extrasystoles ventriculaires polymorphes sans phénomène R sur T avait été évoqué à l'enregistrement Holter ECG. L'échographie cardiaque était sans particularité avec une bonne fonction systolique (FEVG=72%). Le coroscanner réalisé avait révélé un score calcique égal à 4,5 évoquant une coronaropathie très modérée de l'artère circonflexe, une dominance coronaire gauche et une artère coronaire droite grêle naissant du sinus coronaire gauche. Le patient a été mis sous traitement symptomatique.

Conclusion : les anomalies de naissance des artères coronaires du sinus opposé sont des anomalies anatomiques rares, mais qui restent une des causes importantes de mort subite chez des sujets jeunes pendant l'effort. Le coroscanner permet de faire le diagnostic.

Mots clés : anomalie de naissance, artère coronaire droite, sinus opposé, coroscanner.



Résumés des Conferences GRAND PUBLIC

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES : POUR LE MEILLEUR OU POUR LE PIRE DU CONSOMMATEUR ?

Comlan Jules GNINKOUN, Annelie KEREKOU HODE

Service d'Endocrinologie Métabolisme Nutrition, CNHU-HKM, Bénin

Auteur correspondant : Jules GNINKOUN, jules.gninkoun@uac.bj

résumé

Les compléments alimentaires (C.A) constituent au niveau mondial un domaine en forte expansion, situé à l'interface entre alimentation et pharmacologie. Ce sont des sources concentrées de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. La fabrication, la commercialisation et la consommation, normalement réglementées, des compléments est sans cesse croissante aussi bien dans les pays du Nord qu'en Afrique. Effet, des enquêtes rapportent qu'entre 25 et 35 % des adultes urbains en consomment régulièrement. Les plus utilisés sont les vitamines (D, C, B), le fer chez les femmes en âge de procréer et les produits à base de plantes locales (*Moringa oleifera*, *Hibiscus sabdariffa*, gingembre). Une étude nigériane (2020) a montré que 41 % des étudiants consommaient régulièrement des C.A, tandis qu'au Sénégal, environ 28 % des femmes enceintes recevaient une supplémentation en fer ou acide folique. Ces chiffres reflètent une pénétration croissante mais hétérogène selon les pays et les contextes socio-économiques. Ils sont utilisés pour prévenir ou corriger des déficits nutritionnels, mais également à réduire certains risques de maladies chroniques. Certains apportent des effets antioxydants, soutiennent la fonction immunitaire et participent à la prévention de l'ostéoporose ou des anémies. D'autres compléments à base d'acides gras ou de probiotiques sont également étudiés pour leurs effets métaboliques et cardiovasculaires. Cependant, leur usage non contrôlé peut être délétère. L'excès de calcium augmente le risque cardiovasculaire et d'infarctus. Le fer, consommé de manière chronique chez la femme ménopausée, est associé à une surmortalité. Des études ont montré une majoration du risque de cancers (poumon chez les fumeurs exposés au bêta-carotène, prostate avec vitamine E). De plus, certains produits de phytothérapie, peuvent présenter des effets rénaux et hépatiques indésirables. L'automédication et l'absence de contrôle de qualité renforcent donc ces dangers. Face à la pression médiatique (marketing) de plus en plus forte vantant leurs vertus curatives ou préventives et les données scientifiques actuelles sur les C.A, il apparaît nécessaire de revisiter leurs indications et conditions d'usage.

Mots clés : compléments alimentaires, aliments fonctionnels, anti oxydants, vitamines, probiotiques, oligo-éléments.

RESUME

La neurochirurgie béninoise a une vingtaine d'années au compteur depuis les premiers neurochirurgiens qui sont rentrés au pays après leur formation. Après une phase, où nos deux premiers aînés ont exercé seuls durant au moins 5 ans, il y a eu une 2^e étape où les neurochirurgiens de tout le Bénin étaient au nombre de 6 en fin 2012 avec 1 neurochirurgien à Parakou et 5 à Cotonou et ceci jusqu'en 2015. Actuellement, il y a une quinzaine de praticiens présents sur le territoire.

Le plateau technique est aussi inégalement réparti entre le sud et le nord du pays. L'accessibilité de l'imagerie reste encore un casse-tête pour une bonne frange de la population. Malgré toutes les difficultés rencontrées, les neurochirurgiens s'efforcent d'offrir autant que possible des soins de qualité autant que le permet le plateau technique disponible. Le rapport d'activités de la CUNC du CNHU-HKM de 2024 montre les résultats suivants (enfants et adultes et toute pathologie neurochirurgicale confondue) : 2034 patients consultés (170/ mois) et 296 interventions chirurgicales (17/mois). Cette offre de soins en neurochirurgie permet de prendre en charge des pathologies neurochirurgicales traumatiques, dégénératives, malformatives, tumorales, infectieuses et vasculaires.

Cependant, pour un exercice adéquat de la neurochirurgie au Bénin et pour une augmentation du taux de satisfaction des patients, il urge de renouveler l'équipement existant qui est devenu bien obsolète.

Mots-clés : neurochirurgie, plateau technique, Bénin.

RESUME

NON DISPONIBLE

RESUME :

La baisse de la fertilité masculine observée au cours des dernières décennies représente un défi majeur pour la santé reproductive masculine, avec des implications sociétales importantes. L'infertilité reste encore souvent taboue dans nos sociétés. Les causes suspectées sont multiples. Il s'agit de facteurs environnementaux (perturbateurs endocriniens, les pesticides, la pollution atmosphérique.), les habitudes de vie (les changements dans l'alimentation, la diminution de l'activité physique, l'obésité, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et le stress) et les changements sociétaux notamment le report de la paternité à un âge plus avancé.

Face à cette tendance complexe et multifactorielle, l'urologue se trouve en première ligne pour évaluer, diagnostiquer et proposer des solutions adaptées aux hommes concernés. Son rôle a évolué considérablement avec les avancées scientifiques et technologiques. Ces solutions devront être mises en œuvre en privilégiant une approche globale et personnalisée, ainsi qu'en en collaborant étroitement avec d'autres spécialistes.

Résumé

Les affections bucco-dentaires sont diverses et variées. Elles peuvent affecter aussi bien les tissus durs de la dent que les tissus de soutien de l'organe dentaire. Il s'agit essentiellement des caries, des lésions dentaires non carieuses, des maladies parodontales et des traumatismes dento-maxillo-faciaux. Ce sont des pathologies multifactorielles dont les facteurs de risque peuvent dépendre aussi bien des caractéristiques socio-démographiques tels que l'âge et le sexe que de l'environnement, de l'état général, du mode de vie, des facteurs comportementaux et des parafunctions. De ce fait, certaines pathologies sont plus spécifiques à une tranche d'âge particulière. Ainsi, on peut décrire les pathologies de la petite enfance (0 à 6 ans), celles des enfants et préadolescents (6-12 ans), celles des adolescents (12-18 ans), des adultes (19-64 ans) et des sujets du troisième âge (65 ans et plus). Dans cette présentation, après un panorama des principaux problèmes de santé bucco-dentaire par tranche d'âge, nous décrirons les facteurs de risque spécifiques à chaque groupe, avant de parler des possibilités thérapeutiques qui finiront sur les conseils préventifs.

Mots-clés : affections bucco-dentaires, groupe d'âge, facteurs de risque, prévention, traitement



TABLES RONDES:

Résumés des

Conferences

Rôle des organisations de santé dans le contrôle de l'intelligence artificielle dans la pratique médicale au Bénin

Professeur Djimon Marcel ZANNOU,
Président du Conseil national de la médecine hospitalière

RÉSUMÉ

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la santé au Bénin représente un tournant stratégique majeur, ancré dans une volonté politique forte de faire du pays un leader technologique en Afrique de l'Ouest. Cette ambition se manifeste à travers des initiatives gouvernementales structurées, notamment la Stratégie Nationale d'Intelligence Artificielle et des Mégadonnées (SNIAM) 2023-2027. Bien que cette approche soit proactive et ait valu au Bénin une reconnaissance régionale, l'analyse révèle que le cadre de contrôle et de gouvernance de l'IA dans la pratique médicale est encore en cours de formalisation.

La gouvernance de l'IA en santé repose sur une architecture institutionnelle tripartite, où le Ministère de la Santé définit la politique publique, l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN) assure la mise en œuvre technique, et l'Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) veille à la conformité réglementaire. Parallèlement, l'Ordre National des Médecins du Bénin (ONMB) joue un rôle fondamental dans la régulation déontologique de la profession.

Cependant, des défis majeurs persistent. Le cadre juridique, bien que fondé sur le Code du Numérique, nécessite des décrets d'application spécifiques à l'IA pour encadrer des questions de responsabilité et de certification. Sur le plan technologique, le manque de données de santé numérisées et de qualité représente un obstacle critique à l'entraînement de modèles d'IA fiables et éthiques. Enfin, des préoccupations éthiques, notamment la protection des données sensibles et le risque de biais algorithmiques, exigent une vigilance accrue et des programmes de renforcement des capacités ciblés pour les professionnels de la santé et le grand public. Pour surmonter ces obstacles, il est recommandé de finaliser le cadre législatif, de renforcer la coordination entre les acteurs, d'investir massivement dans la numérisation des données de santé et de prioriser la formation et la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes.

Mots clés : intelligence artificielle, organisation de santé, données personnelles.

RESUME

NON DISPONIBLE

RESUME

NON DISPONIBLE

Professeur Ulrich Bidossèssi VODOUHE**Vice-Doyen Médecine -FSS****Résumé**

La simulation en santé est devenue un outil pédagogique majeur dans la formation médicale et paramédicale. Elle consiste à recréer, à l'aide de mannequins, de simulateurs haute fidélité, de jeux de rôle ou d'environnements virtuels, des situations cliniques proches de la réalité. L'objectif à la faculté des Sciences de la Santé de Cotonou est de transmettre des compétences aux apprenants sans créer de dommage sur le vivant.

Sa mise en place apporte de nombreux atouts pédagogiques (favorise l'apprentissage actif par la pratique : "learning by doing"), sécuritaires pour les patients, organisationnels et éthiques.

Les freins à son développement sont matériels et financiers (coût élevé des mannequins haute fidélité, des simulateurs virtuels et des infrastructures, maintenance et mise à jour technologique onéreuses), organisationnels (nécessité de temps dédié pour les étudiants et les formateurs, besoin d'une équipe formée à la pédagogie par simulation, difficulté d'intégrer la simulation dans des programmes académiques déjà chargés), pédagogiques (elle ne peut remplacer totalement l'expérience clinique réelle, manque d'enseignants qualifiés pour exploiter au mieux les séances de débriefing) et culturels (résistance au changement chez certains enseignants/formateurs, perception de la simulation comme moins "authentique" que la clinique).

Conclusion : la simulation en santé est un formidable outil pédagogique qui améliore la sécurité des soins et l'apprentissage, mais son déploiement à la faculté des Sciences de la Santé de Cotonou est limité par des freins financiers, organisationnels et culturels. La mise en place est actuellement progressive.

RESUME

NON DISPONIBLE

ENJEUX ET DÉFIS DES MTA DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ DU BÉNIN

Habib GANFON

Laboratoire de Pharmacognosie et phytothérapie/Centre de Recherche et de Développement du Médicament (CRDM-PHARMALAB) / FSS/UAC, 01 BP 188 Cotonou

Résumé

Le Bénin se caractérise par un recours important, des populations aux plantes médicinales pour se soigner, motivé à la fois par des considérations d'accessibilité économique, de proximité culturelle, et par la relative insuffisance de la couverture en infrastructure de santé. Toutefois, cette utilisation empirique de plantes médicinales soulève d'importants enjeux de santé publique, en lien avec l'insuffisance de standardisation des préparations, les incertitudes de dosage, les risques de toxicité non maîtrisés et le déficit en données probantes sur l'efficacité. Face à ces défis, le Bénin s'est progressivement doté d'un arsenal réglementaire articulé autour de l'arrêté n° 017 du 15 février 2017 portant modalités d'homologation des médicaments à base de plantes ainsi que la loi n°2021-03 portant organisation des activités pharmaceutiques. Ce cadre a favorisé l'enregistrement progressif de Médicaments Traditionnels Améliorés (MTA) pour des indications thérapeutiques variées : paludisme simple, drépanocytose, hémorroïdes, HTA, troubles hépato-digestifs, troubles de la prostate, anémie, anti venins etc. Malgré ces avancées, les promoteurs de MTA restent confrontés à plusieurs obstacles : difficulté de standardisation de leur préparation, insuffisance de structures de recherche pour valider scientifiquement les produits, confusion fréquente avec les compléments alimentaires, et absence d'un système structuré de phytovigilance. Ces enjeux freinent l'intégration effective des MTA dans le système de santé béninois.

Mots clés: Médicaments Traditionnels Améliorés/ standardisation/ Réglementation pharmaceutique/ Intégration dans Système Santé

HÉMOPHILIE AU BÉNIN : OÙ EN SOMMES-NOUS EN 2025 ?

CONF1TR4

Baglo Agbodandé T1,2, Zohoun A1, 2,,3, Houssou B2, Massi R2, Orou-Guiwa C2, Ahoton B1,3

Auteur correspondant : Baglo Agbodandé Tatiana, tatianabag@yahoo.fr

1-Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou- Université d'Abomey-Calavi, Bénin

2-Laboratoire d'hématologie, Centre National Hospitalier Universitaire-Cotonou, Bénin

3- Direction centrale, Service de Santé des Armées, Bénin

RÉSUMÉ :

L'hémophilie est une maladie hémorragique constitutionnelle rare mais grave. Au Bénin, en Août 2025, le nombre d'hémophiles est de 166 soit 12,7% du nombre de cas d'hémophiles attendus. Parmi eux, 06 patients étaient hémophiles B. Lors d'une étude prospective réalisée en 2023, la médiane d'âge des hémophiles était de 11 ans. Les circonstances de découverte les plus fréquentes étaient des hémorragies cutanéomuqueuses (29,7 %) suivies des saignements post-circoncision (25,7 %). Les hémarthroses étaient retrouvées chez 77 % des patients et une arthropathie hémophilique documentée chez 65 d'entre eux. A ce jour, grâce au soutien de la HHNF, de la WFH et en collaboration avec l'ABH, des Centres de Traitement de l'Hémophilie ont été mis en place et sont fonctionnels dans les départements suivants : Littoral, Ouémé, Zou, Collines, Borgou, Alibori, Atacora, Mono et Couffo.

Au laboratoire, le diagnostic biologique de l'hémophilie est limité à Cotonou tandis que seulement sept hôpitaux départementaux sur les 12, disposent d'un coagulomètre pour réaliser le dépistage de l'hémophilie. Pour la recherche des inhibiteurs, elle n'est possible qu'au laboratoire d'hématologie du CNHU de Cotonou et a été retrouvée chez environ 20% des hémophiles traités.

Sur le plan de la prise en charge, la WFH soutient le Bénin depuis 2018 à travers son programme humanitaire, avec des dons de concentrés de facteur et d'emicizumab. Cette aide a permis l'instauration de traitements prophylactiques, réduisant considérablement la fréquence des épisodes hémorragiques chez les hémophiles A sévères. L'analyse du spectre mutationnel du gène F8 chez 43 hémophiles A non apparentés a permis de retrouver 10 porteurs de l'inversion de l'intron 22 et un cas d'inversion de l'intron 1. Chez les patients double négatifs, 24 mutations ponctuelles ont été identifiées parmi lesquelles 07 n'ont jamais été rapportées dans les bases de données internationales.

L'hémophilie est une pathologie largement sous-diagnostiquée au Bénin. L'amélioration des capacités diagnostiques des centres de traitement de l'hémophilie (notamment en milieu rural), le renforcement des compétences des agents de santé et la pérennisation de l'accès aux facteurs anti-hémophiliques sont des priorités pour améliorer le suivi, la prévention des complications et la qualité de vie des hémophiles béninois.

Mots-clés : Hémophilie, Bénin, arthropathie hémophilique, diagnostic biologique, prophylaxie.

**DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE L'HÉMOPHILIE AU BÉNIN :
DÉFIS ET PERSPECTIVES****Zohoun A1,2,3, Baglo Agbodandé T1,2, Ahoton B1,3, Ganhoutode A3**¹ Laboratoire d'hématologie – Centre National Hospitalier Universitaire-HKM – Cotonou, Bénin² Faculté des Sciences de la Santé, Cotonou – Université d'Abomey Calavi, Bénin³ Direction Centrale, Service de Santé des Armées, BéninAuteur correspondant : Zohoun Alban, comlanz@yahoo.fr**RESUME**

L'hémophilie est un trouble constitutionnel rare mais sévère de la coagulation, nécessitant un diagnostic biologique précis pour une prise en charge adéquate. Elle doit être suspectée devant tout syndrome hémorragique inexpliqué et confirmée par un bilan standard révélant un allongement isolé du temps de céphaline avec activateur, corrigé par mélange avec un plasma témoin, puis par le dosage spécifique des facteurs VIII et IX afin de typer l'hémophilie et d'en préciser la sévérité. Au Bénin, le diagnostic repose sur la mesure de l'activité des facteurs de coagulation, impliquant l'utilisation d'un coagulomètre et de réactifs adaptés. Cependant, l'accès à ce diagnostic demeure limité et inégalement réparti sur le territoire. Peu de laboratoires disposent d'un coagulomètre, et parmi ceux équipés, plusieurs obstacles entravent la réalisation des tests spécialisés : insuffisance de formation des techniciens, difficultés d'interprétation et irrégularité d'approvisionnement en réactifs. Cette situation entraîne des retards, voire l'absence de confirmation biologique des suspicions cliniques, compromettant la rapidité et l'efficacité de la prise en charge. Le faible niveau de sensibilisation des professionnels de santé et du grand public constitue un autre frein majeur au diagnostic précoce. Face à ces défis, des solutions sont envisageables : création de centres de traitement de l'hémophilie, renforcement ciblé des compétences techniques, équipement progressif des laboratoires des hôpitaux départementaux et de zone. En conclusion, l'amélioration du diagnostic biologique de l'hémophilie au Bénin requiert des efforts coordonnés en matière de formation, d'équipements et de coordination institutionnelle. Ces actions sont indispensables pour réduire les inégalités d'accès au diagnostic biologique, aux soins et améliorer durablement la qualité de vie des hémophiles.

Mots-clés : hémophilie, diagnostic biologique, coagulomètre, renforcement des capacités, Bénin

**MERCI A
NOS PARTENAIRES**

NOS REMERCIEMENTS :

- **Ministère de la Santé**
- **Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique**
- **Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance**
- **ENABEL**
- **Ambassade de France**
- **Tous les enseignants de la FSS**
- **Le personnel administratif technique et de soutien**
- **Anciens étudiants en médecine**
- **Promoteur des jus naturels Livek**
- **Directeur général de l'Agence Nationale de Protection Sociale**
- **La SOBAPS**
- **LE CERRHUD**
- **BGL SYSMET**
- **BIOLYNX**
- **Responsable de la PHARMACIE SAINTE FAMILLE**
- **ANSSP**
- **PNLMNT**
- **PNLP**
- **PNSP**
- **TOUS CEUX QUI DE PRES OU DE LOIN ONT SOUTENU L'EVENEMENT**

